急诊与灾难医学·教师重点版题库

急诊与灾难医学·教师重点版题库（batch043，200 题）题库（200题）

> 来源：最终产物\batch043\ALL_questions_FIXED.json | 导出：2026-10-27 00:27
> 题型分布：A1×101、A2×34、X×25、A3×22、判断×18
> Bloom分布：理解×84、记忆×58、应用×49、分析×9

M01（16题）

1. [A1型题｜记忆] batch043-M01-A1-001

> 模块：M01｜页码：教材P2

按急诊五级分诊标准，II 类“随时危及生命”的病人应在多长时间内完成病情评估和治疗

- A. 立即进行抢救
- **B. 10分钟内** ✅
- C. 30分钟内
- D. 1小时内
- E. 2小时内

答案：B

> 解析：【正确答案】急诊五级分诊把病人按病情轻重缓急分为五类，II 类为随时危及生命的病人，规定应在 10 分钟内完成病情评估和治疗；Ⅰ类生命垂危需立即抢救，III类 30 分钟内，IV类 1 小时内，Ⅴ类一般 2 小时内处理。
>
> 【逐项解析】A. Ⅰ类生命垂危病人才需要立即抢救，II 类尚未到立即抢救的级别。（错误）
> B. II 类的法定时限是 10 分钟内完成评估和治疗，符合“随时危及生命”的时间敏感性。（正确）
> C. 30 分钟是III类“存在危及生命状况”的时限，不是 II 类。（错误）
> D. 1 小时是IV类潜在危重病人的处理时限；把IV类时限套到 II 类。（错误）
> E. 2 小时是Ⅴ类非紧急病人的一般处理时限。（错误）
>
> 【易错点】五级分诊记成一条时间轴：立即—10 分钟—30 分钟—1 小时—2 小时，级别越高允许等待越短。

---

2. [A1型题｜理解] batch043-M01-A1-002

> 模块：M01｜页码：教材P285

灾难现场伤员数量超过救治能力时，分拣应遵循的基本策略是

- A. 最好的医疗资源用于最严重的伤员
- B. 先救轻伤员以快速扩大救治人数
- C. 按到达现场的先后顺序依次救治
- **D. 最好的医疗资源用于最大多数的伤员** ✅
- E. 优先救治身份明确的伤员

答案：D

> 解析：【正确答案】灾难现场分拣与平时单个伤员救治的策略不同：平时强调“最好的资源用于最严重的伤员”，而批量伤员时必须把有限资源用于最大多数可救治的伤员，以提高整体救治效率，这就是分拣的基本策略。
>
> 【逐项解析】A. 这是平时单个或少量伤员救治的原则，不是灾难批量伤员的分拣策略。（错误）
> B. 轻伤员可等待或自行离场，优先救轻伤员会挤占重伤员资源。（错误）
> C. 按到达顺序救治没有考虑伤情与可救治性，会延误重伤员。（错误）
> D. 灾难分拣的基本策略是最好的医疗资源用于最大多数的伤员。（正确）
> E. 身份是否明确与伤情轻重无关，不能作为分拣依据。（错误）
>
> 【易错点】记住一对反义：平时“最重优先”，灾难“最多数优先”。

---

3. [A1型题｜应用] batch043-M01-A1-003

> 模块：M01｜页码：教材P286

成人批量伤员采用 START 法分拣，某伤员呼吸 24 次/分、毛细血管再充盈 1 秒，但不能遵从指挥行走，应归为

- A. 立即救治（红）
- **B. 延迟救治（黄）** ✅
- C. 等待救治（绿）
- D. 期待救治（黑）
- E. 无法分拣

答案：B

> 解析：【正确答案】START 按“30-2-可以-做”快速判断：呼吸频率小于 30 次/分、毛细血管再充盈小于 2 秒，说明尚未达到立即救治的生理阈值；但不能遵从指挥行走，不能归入轻伤绿色，因此归为延迟救治黄色。
>
> 【逐项解析】A. 立即救治要求存在无意识、呼吸急促、再充盈延迟或桡动脉脉搏缺失等更危急表现。（错误）
> B. 满足 30-2 条件但不能行走，归为延迟救治（黄色），符合本例。（正确）
> C. 绿色要求能遵从指挥行走，本例不能行走，不能归绿。（错误）
> D. 黑色用于存活可能性极小、无法救治者，本例无此表现。（错误）
> E. START 的三种归类的已覆盖本例，不存在无法分拣。（错误）
>
> 【易错点】START 先看能否走：能走绿；不能走再看 30-2，满足者黄、不满足者红。

---

4. [A1型题｜理解] batch043-M01-A1-004

> 模块：M01｜页码：教师补充

SALT 批量伤员分拣法的第一个步骤是

- **A. Sort全局排序** ✅
- B. Assess评估呼吸、脉搏、意识
- C. 救命干预（止血/气道）
- D. 治疗与转运
- E. Triage标签固定

答案：A

> 解析：【正确答案】SALT 的四步顺序是 Sort（全局排序，先按能走、能挥手、无反应把人群体快速分层）、Assess（评估呼吸、脉搏、意识）、Lifesaving interventions（止血、开放气道、针刺减压等救命干预）、Treatment/Transport（治疗与转运），因此第一步是全局排序。
>
> 【逐项解析】A. SALT 的第一步是 Sort 全局排序，先快速分层再逐项评估。（正确）
> B. Assess 是第二步，在全局排序之后进行。（错误）
> C. Lifesaving interventions 是第三步，应在评估后立即实施。（错误）
> D. Treatment/Transport 是最后一步，负责治疗与转运安排。（错误）
> E. Triage 标签固定不是 SALT 的独立步骤，且应在分拣后完成。（错误）
>
> 【易错点】SALT 顺序记“排—评—救—转”，与 START 的“30-2-可以-做”区分。

---

5. [A1型题｜记忆] batch043-M01-A1-005

> 模块：M01｜页码：教材P1-2

我国急救医疗服务体系（EMSS）的三位一体模式不包括下列哪一项

- A. 院前急救环节
- B. 医院急诊环节
- C. 危重症监护
- D. 突发公共事件医学救援
- **E. 慢性病长期随访管理** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】我国 EMSS 是院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体的模式，并承担突发公共事件与灾难事故的应急医学救援；慢性病长期随访管理不属于急诊医学体系的职责，急诊强调急危重症的早期判断与救治。
>
> 【逐项解析】A. 院前急救是 EMSS 的第一段，负责现场支持与安全转运。（正确）
> B. 医院急诊是 EMSS 的中心环节，承担首诊与分流。（正确）
> C. 危重症监护（EICU）是 EMSS 的第三段，负责器官支持。（正确）
> D. 突发公共事件救援是急诊与灾难医学的重要职责，属于体系任务。（正确）
> E. 慢性病长期随访管理不属于 EMSS 三位一体，也不属于急诊职责。（错误）
>
> 【易错点】EMSS 记“院前—院内—EICU”三段，再加突发公共事件救援；慢性病随访是排除项。

6. [A1型题｜记忆] batch043-M01-A1-006

> 模块：M01｜页码：教材P18

格拉斯哥昏迷评分（GCS）的最高分与最低分分别是

- A. 最高12分，最低1分
- **B. 最高15分，最低3分** ✅
- C. 最高15分，最低1分
- D. 最高14分，最低3分
- E. 最高10分，最低3分

答案：B

> 解析：【正确答案】GCS 由睁眼反应（E，4～1 分）、言语反应（V，5～1 分）和运动反应（M，6～1 分）三项组成，三项相加最高为 15 分（无昏迷），最低为 3 分（各项均 1 分），分数越低昏迷程度越深。
>
> 【逐项解析】A. 12 分不是 GCS 的最高分，最高分为 E4+V5+M6=15 分。（错误）
> B. 最高 15 分、最低 3 分，符合 GCS 的三项计分范围。（正确）
> C. 最低分不是 1 分，因为三项各最低 1 分，合计至少 3 分。（错误）
> D. 最高分不是 14 分，E4+V5+M6 合计为 15 分。（错误）
> E. 10 分既不是最高分也不是最低分，不能作为总分范围。（错误）
>
> 【易错点】GCS 三项满分 4+5+6=15，三项最低 1+1+1=3，任何总分都在 3～15 之间。

---

7. [A2型题｜应用] batch043-M01-A2-001

> 模块：M01｜页码：教材P18

男，35 岁，车祸后昏迷。查体：疼痛刺激睁眼，能理解但不连贯地答话，刺激时肢体有逃避反应。其 GCS 总分及预后判断是

- A. 7分，预后不良
- **B. 9分，8分以上恢复机会较大** ✅
- C. 11分，预后良好
- D. 13分，无明显昏迷
- E. 15分，无昏迷

答案：B

> 解析：【正确答案】该病人睁眼为疼痛刺激睁眼（E2），言语为能理解但不连贯（V3），运动为刺激时逃避反应（M4），合计 2+3+4=9 分。GCS 8 分以上恢复机会较大，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险，故 9 分属于恢复机会较大的范围。
>
> 【逐项解析】A. 7 分需要 E1V2M4 或相近组合，本例 E2V3M4 合计 9 分。（错误）
> B. E2+V3+M4=9 分，且 8 分以上恢复机会较大，判断正确。（正确）
> C. 11 分需要更高的睁眼或言语得分，本例未达到。（错误）
> D. 13 分接近无昏迷，与本例疼痛睁眼、答话不连贯不符。（错误）
> E. 15 分为完全清醒，本例明显不符；把昏迷病人误判为清醒。（错误）
>
> 【易错点】先逐项定分再相加：E2+V3+M4=9；记住 8 分是预后分水岭。

---

8. [A2型题｜应用] batch043-M01-A2-002

> 模块：M01｜页码：教材P286

地震现场发现一名伤员：意识清楚，能自行行走，呼吸 22 次/分，桡动脉搏动可触及，左前臂有一处浅表擦伤。按 START 法应标记为

- A. 红色，立即救治
- B. 黄色，延迟救治
- **C. 绿色，等待救治** ✅
- D. 黑色，期待救治
- E. 暂不标记，待二次评估

答案：C

> 解析：【正确答案】START 首先判断能否遵从指挥行走：该伤员意识清楚、能自行行走，呼吸 22 次/分（小于 30 次/分），桡动脉搏动可触及，仅有浅表擦伤，符合轻伤标准，应标记绿色等待救治，不占用紧急转运资源。
>
> 【逐项解析】A. 红色要求无意识、呼吸急促、再充盈延迟或桡动脉脉搏缺失等，本例均无。（错误）
> B. 黄色用于满足 30-2 但不能行走者，本例能行走。（错误）
> C. 能遵从指挥行走、呼吸小于 30 次/分，归为绿色等待救治，正确。（正确）
> D. 黑色用于存活可能极小者，本例仅有浅表伤。（错误）
> E. START 允许现场直接给出颜色，不需要因轻伤而暂缓标记。（错误）
>
> 【易错点】START 的第一刀是“能不能走”：能走先归绿，再谈其他指标。

9. [判断题｜理解] batch043-M01-JUD-001

> 模块：M01｜页码：教材P285

灾难现场批量伤员分拣时，应把最好的医疗资源优先用于伤情最重的伤员，轻、中度伤员仅等待处理。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】这句话描述的是平时单个或少量伤员救治的原则，不是灾难现场的分拣原则。灾难现场伤员数量超过救治能力时，基本策略是“最好的医疗资源用于最大多数的伤员”，按红、黄、绿、黑四色确定救治与转运优先级，而不是无条件最重优先。
>
> 【逐项解析】A. 该说法把平时原则误当成灾难分拣原则，故不正确。（错误）
> B. 灾难现场应为“最多数伤员”优先，因此原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】判断此类题先找“最重”还是“最多数”，灾难现场一律是“最多数”。

---

10. [X型题｜理解] batch043-M01-X-001

> 模块：M01｜页码：教材P285-287

关于灾难现场四色分拣标签，下列叙述正确的有

- **A. 红色为第一优先，需紧急救治和转运** ✅
- **B. 黄色为第二优先，伤势较重但暂无生命危险** ✅
- **C. 绿色为第三优先，伤势较轻、可走动** ✅
- **D. 黑色为零优先，指存活可能性极小、无法救治者** ✅
- E. 黑色标签伤员应优先占用转运资源

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】灾难现场四色标签按优先级分为红（第一优先，紧急救治）、黄（第二优先，延迟救治）、绿（第三优先，等待救治）、黑（零优先，存活可能极小、期待救治）；黑色标签的意义正是把有限资源留给可救治者，不应优先占用转运资源。
>
> 【逐项解析】A. 红色代表第一优先，需立即救治与转运，叙述正确。（正确）
> B. 黄色代表第二优先，伤重但暂无生命危险，叙述正确。（正确）
> C. 绿色代表第三优先，轻伤、可走动，叙述正确。（正确）
> D. 黑色代表零优先，存活可能极小、无法救治，叙述正确。（正确）
> E. 黑色标签不应优先占用转运资源，该叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】四色顺序红→黄→绿→黑，黑色是“放弃救治”而非“最优先”。

---

11. [A1型题｜记忆] batch043-M01-A1-007

> 模块：M01｜页码：教材P1-2

院前急救反应时间的国际目标是在接到呼救后多长时间内到达现场

- A. 3～5分钟
- **B. 5～10分钟** ✅
- C. 10～15分钟
- D. 15～20分钟
- E. 20～30分钟

答案：B

> 解析：【正确答案】院前急救反应时间指从接到呼救到急救人员到达现场的时间，国际目标为 5～10 分钟内到达。缩短院前延误能提高心搏骤停、严重创伤等时间依赖性疾病的存活率，是 EMSS 的第一环。
>
> 【逐项解析】A. 3～5 分钟是理想值，不是国际通用目标。（错误）
> B. 5～10 分钟是国际公认的院前反应时间目标。（正确）
> C. 10～15 分钟已超过目标上限，院前延误明显。（错误）
> D. 15～20 分钟属明显延误，存活率下降。（错误）
> E. 20～30 分钟已接近或超过黄金抢救时间。（错误）
>
> 【易错点】院前反应记 5～10 分钟；超过 10 分钟，骤停与重创的存活率明显下滑。

---

12. [A1型题｜记忆] batch043-M01-A1-008

> 模块：M01｜页码：教材P1-2

急诊科留观病人的留观时间原则上不超过

- A. 24小时
- B. 48小时
- **C. 72小时** ✅
- D. 96小时
- E. 1周

答案：C

> 解析：【正确答案】急诊科全年 24 小时开放，留观时间原则上不超过 72 小时。超过 72 小时仍不能明确诊断或稳定病情者，应重新评估，转入专科病房或 EICU，避免急诊滞留。
>
> 【逐项解析】A. 24 小时过短，多数留观病人尚未完成评估。（错误）
> B. 48 小时不是规定上限，仍可继续留观；凭印象取值。（错误）
> C. 72 小时是急诊留观的原则性上限；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 96 小时已超过上限，属急诊滞留；把上限放宽。（错误）
> E. 1 周明显超出急诊功能定位；把急诊当病房。（错误）
>
> 【易错点】急诊留观 72 小时是红线，超时就要重新评估收容。

---

13. [A1型题｜理解] batch043-M01-A1-009

> 模块：M01｜页码：教材P286

用 START 法对成人批量伤员进行初筛时，每例分拣时间应控制在

- A. 10～20秒
- **B. 30～60秒** ✅
- C. 2～3分钟
- D. 5分钟以上
- E. 不做时间限制

答案：B

> 解析：【正确答案】START 分拣要求在 30～60 秒内完成一例，只查呼吸频率、毛细血管再充盈与能否遵从指挥三项，目的是在最短时间内把大批伤员分成红、黄、绿、黑四档，避免在单个伤员身上停留过久。
>
> 【逐项解析】A. 10～20 秒过短，三项指标来不及完成。（错误）
> B. 30～60 秒是 START 规定的每例分拣时间。（正确）
> C. 2～3 分钟过长，200 名伤员需数小时。（错误）
> D. 5 分钟以上会使分拣成为救治瓶颈；把分拣与处置混淆。（错误）
> E. 不限时间会导致重伤员在等待分拣中死亡；忽视批量伤员的时效。（错误）
>
> 【易错点】START 是“快筛”不是“查体”：30～60 秒、三项指标、立即贴标。

---

14. [A2型题｜应用] batch043-M01-A2-003

> 模块：M01｜页码：教材P285-287

某地震现场 3 小时内完成 200 名伤员分拣，其中 96 人被标为红色，实际仅 40 人需立即救治；另有 5 名重伤员被标为绿色。按分拣质量标准判断，该结果

- **A. 过度分拣与分拣不足均未超限** ✅
- B. 过度分拣超限、分拣不足未超限
- C. 分拣不足超限、过度分拣未超限
- D. 过度分拣与分拣不足均超限
- E. 无法评价分拣质量

答案：A

> 解析：【正确答案】过度分拣为 96/200＝48%，未超过 50% 的可接受上限；分拣不足为 5/200＝2.5%，低于 10% 的可接受上限。因此该现场的分拣质量在可接受范围内，但仍应通过复筛把不必要的红色标签降级，节省转运资源。
>
> 【逐项解析】A. 48%＜50%、2.5%＜10%，两项均未超限。（正确）
> B. 过度分拣未超 50%，该判断错误；把 48% 当成超限。（错误）
> C. 分拣不足仅 2.5%，未超 10%；把 5 人当成超限。（错误）
> D. 两项都未超限，该判断错误；把两个阈值记反。（错误）
> E. 有明确比例即可评价，不能以“无法评价”回避。（错误）
>
> 【易错点】分拣质量两条线：过度分拣≤50%、分拣不足≤10%，先算比例再判断。

---

15. [X型题｜理解] batch043-M01-X-002

> 模块：M01｜页码：教材P1-2

关于急诊医学与 EMSS 体系，下列叙述正确的有

- **A. 核心是急危重症与创伤的快速评估处置** ✅
- **B. EMSS 由院前急救、医院急诊、危重症监护组成** ✅
- **C. 急诊科承担突发公共事件救援任务** ✅
- D. 急诊科负责慢性病的长期随访管理
- **E. 急诊科全年 24 小时开放** ✅

答案：ABCE

> 解析：【正确答案】急诊医学的核心是急危重症与创伤的快速评估和处置，通过院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体的 EMSS 实现无缝衔接；急诊科还承担突发公共事件救援，并全年 24 小时开放。慢性病的长期随访管理由专科与社区承担，不属于急诊职责。
>
> 【逐项解析】A. 急危重症与创伤的快速评估处置是急诊核心，叙述正确。（正确）
> B. EMSS 正是院前、院内急诊、EICU 三位一体，叙述正确。（正确）
> C. 突发公共事件救援是急诊职责之一，叙述正确。（正确）
> D. 慢性病长期随访不属于急诊职责，该叙述错误。（错误）
> E. 急诊科 24 小时开放，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
>
> 【易错点】急诊的边界：急、危、重、伤、突发事件；不含慢病长期随访。

---

16. [判断题｜理解] batch043-M01-JUD-002

> 模块：M01｜页码：教材P2

急诊五级分诊中，分诊级别越高，说明病情越轻，允许等待的时间越长。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】五级分诊的级别越高代表病情越危重： Ⅰ类立即抢救、 Ⅱ类 10 分钟内、Ⅲ类 30 分钟内、Ⅳ类 1 小时内、 Ⅴ类 2 小时内。级别越高，允许等待的时间越短，而不是越长。
>
> 【逐项解析】A. 级别越高病情越重、等待时间越短，原句把关系说反了。（错误）
> B. Ⅰ类立即、 Ⅴ类 2 小时，说明级别越高等待越短，故原句错误。（正确）
>
> 【易错点】分诊记一条反向轴：级别↑ → 病情↑ → 允许等待↓。

M02（32题）

17. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-001

> 模块：M02｜页码：教材P233

心脏骤停的“三联征”是指

- **A. 突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失** ✅
- B. 胸痛、呼吸困难、大汗
- C. 意识模糊、抽搐、大小便失禁
- D. 血压下降、脉搏细速、皮肤湿冷
- E. 瞳孔散大、对光反射消失、心音消失

答案：A

> 解析：【正确答案】心脏骤停三联征为突发意识丧失、呼吸停止和大动脉搏动消失。这三项是现场判断骤停的核心依据，瞳孔散大、心音消失等虽可出现，但属于查体细节，不是三联征的组成。
>
> 【逐项解析】A. 三联征正是突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失，叙述正确。（正确）
> B. 胸痛、呼吸困难、大汗是急性冠脉综合征的表现，不是骤停三联征。（错误）
> C. 抽搐、大小便失禁可见于癫痫或骤停后脑缺氧，但不是三联征。（错误）
> D. 血压下降、脉搏细速、皮肤湿冷是休克表现，不是骤停三联征。（错误）
> E. 瞳孔散大、心音消失是骤停的查体所见，但三联征强调意识、呼吸、大动脉搏动。（错误）
>
> 【易错点】骤停三联征只记三件事：叫不应、没呼吸、摸不到大动脉搏动。

---

18. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-002

> 模块：M02｜页码：教材P231-232

常温下心脏骤停后，脑细胞开始发生不可逆缺血损害的时间约为

- A. 1分钟
- B. 2分钟
- **C. 4分钟** ✅
- D. 8分钟
- E. 15分钟

答案：C

> 解析：【正确答案】正常体温下，心脏骤停约 4 分钟后脑细胞开始发生不可逆的缺血损害；心脏骤停 10 分钟内未行心肺复苏，神经功能极少能恢复到发病前水平，因此把 4 分钟称为黄金抢救时间。
>
> 【逐项解析】A. 1 分钟时脑细胞尚未进入不可逆损害阶段，此时开始复苏效果最好。（错误）
> B. 2 分钟仍处于可逆缺血阶段，尚未到不可逆损害的界值。（错误）
> C. 常温下约 4 分钟脑细胞开始不可逆缺血损害，与黄金 4 分钟一致。（正确）
> D. 8 分钟已超过不可逆损害起点，延误越久神经预后越差。（错误）
> E. 15 分钟时神经功能恢复的可能性极低，不是损害起点。（错误）
>
> 【易错点】4 分钟是脑细胞不可逆损害的起点，也是黄金抢救时间的来源。

---

19. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-003

> 模块：M02｜页码：教材P235

成人高质量心肺复苏时，胸外按压的频率和深度应为

- A. 60～80次/分，3～4cm
- B. 80～100次/分，4～5cm
- **C. 100～120次/分，5～6cm** ✅
- D. 120～140次/分，5～6cm
- E. 100～120次/分，6～7cm

答案：C

> 解析：【正确答案】成人高质量胸外按压要求频率 100～120 次/分、按压幅度 5～6cm，并保证每次按压后胸廓完全回弹、尽量减少中断（中断时间小于 10 秒）。频率过低灌注不足，过高则心脏充盈时间缩短；过深易致损伤。
>
> 【逐项解析】A. 60～80 次/分低于指南推荐，3～4cm 深度也不足，不能产生有效灌注。（错误）
> B. 80～100 次/分略低，4～5cm 深度不足，均未达到高质量标准。（错误）
> C. 100～120 次/分、5～6cm 正是成人高质量 CPR 的标准参数。（正确）
> D. 120～140 次/分超过推荐上限，心脏充盈时间不足，反而降低心输出量。（错误）
> E. 6～7cm 超过推荐深度，增加肋骨骨折与内脏损伤风险。（错误）
>
> 【易错点】按压参数记“一百二、五六”，即 100～120 次/分、5～6cm。

---

20. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-004

> 模块：M02｜页码：教材P235

成人胸外心脏按压的正确部位是

- A. 胸骨上1/3
- **B. 胸骨中下1/3** ✅
- C. 剑突下方
- D. 左侧第4肋间心尖部
- E. 胸骨柄与锁骨交界处

答案：B

> 解析：【正确答案】成人胸外按压部位为胸骨中下 1/3 或两乳头连线与胸骨交界点中央。按压剑突易致肝脾破裂，按压心尖部不能有效挤压心脏，按压胸骨上 1/3 则位置过高、效果差。
>
> 【逐项解析】A. 胸骨上 1/3 位置过高，不能有效挤压心室。（错误）
> B. 胸骨中下 1/3 或两乳头连线与胸骨交界点中央，是正确按压部位。（正确）
> C. 剑突处按压易致肝破裂、剑突骨折，是错误部位。（错误）
> D. 心尖部不能有效挤压心脏，且易致肋骨骨折。（错误）
> E. 胸骨柄与锁骨交界处位置过高，达不到有效按压。（错误）
>
> 【易错点】按压点记“两乳头连线中点”，避开剑突与心尖。

---

21. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-005

> 模块：M02｜页码：教材P236

成人单人心肺复苏时，按压与通气的比例及一个 CPR 周期的组数是

- A. 15:2，5组
- **B. 30:2，5组** ✅
- C. 30:2，10组
- D. 15:2，10组
- E. 50:2，5组

答案：B

> 解析：【正确答案】成人单人 CPR 按压与通气比为 30:2，每 5 组 30:2 的 CPR 为一个周期，时间约 2 分钟；2 人以上 CPR 时每 2 分钟轮换一次，以减少按压者疲劳导致的质量下降。
>
> 【逐项解析】A. 15:2 是双人小儿复苏的比例，不是成人单人比例。（错误）
> B. 成人 30:2，每 5 组为一个周期、约 2 分钟，叙述正确。（正确）
> C. 一个周期是 5 组而不是 10 组，10 组约 4 分钟。（错误）
> D. 15:2 与 10 组均不符合成人单人 CPR 标准。（错误）
> E. 50:2 不是推荐比例，过度强调按压会牺牲通气。（错误）
>
> 【易错点】成人 30:2、5 组 2 分钟、每 2 分钟换人，三个“2”一起记。

---

22. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-006

> 模块：M02｜页码：教材P237

关于成人电除颤的首次能量，正确的是

- A. 单相波200J，双相波100J
- **B. 单相360J/双相120～200J** ✅
- C. 单相波120J，双相波360J
- D. 单相波360J，双相波360J
- E. 单相波150J，双相波150J

答案：B

> 解析：【正确答案】单相波除颤首次使用 360J；双相波首次为 120～200J，后续可使用第一次的能量或适当增加。能量过低不能终止室颤，过高则增加心肌损伤。
>
> 【逐项解析】A. 单相波 200J 不足以终止多数室颤，双相波 100J 也低于推荐下限。（错误）
> B. 单相波 360J、双相波 120～200J，符合指南推荐。（正确）
> C. 把单相波与双相波的能量对调，单相波 120J 明显不足。（错误）
> D. 双相波首次不需要 360J，120～200J 即可。（错误）
> E. 150J 不是单相波推荐能量，单相波应 360J。（错误）
>
> 【易错点】单相“三百六”，双相“一百二到二百”，两个数字不要对调。

---

23. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-007

> 模块：M02｜页码：教材P237

心室颤动病人每延迟 1 分钟除颤，存活率大约下降

- A. 1%～2%
- B. 3%～5%
- **C. 7%～10%** ✅
- D. 15%～20%
- E. 25%以上

答案：C

> 解析：【正确答案】早期电击除颤是决定心脏骤停病人能否存活的关键因素，除颤每延迟 1 分钟，病人存活率下降 7%～10%。因此室颤一旦确认，应尽快电击，并在电击后立即恢复胸外按压。
>
> 【逐项解析】A. 1%～2% 明显低估了除颤延迟的危害，实际下降更快。（错误）
> B. 3%～5% 低于教材给出的 7%～10% 区间。（错误）
> C. 每延迟 1 分钟存活率下降 7%～10%，与教材一致。（正确）
> D. 15%～20% 高于教材区间，夸大了单分钟下降幅度。（错误）
> E. 25% 以上不符合教材数据，除颤延迟的危害虽大但无此高。（错误）
>
> 【易错点】除颤时间就是存活率：每拖 1 分钟掉 7%～10%。

---

24. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-008

> 模块：M02｜页码：教材P237

成人使用 AED 时，两个电极片的正确放置位置是

- **A. 右锁骨下区与左乳头侧腋中线** ✅
- B. 左锁骨下区与右乳头侧腋中线
- C. 胸骨正中与剑突
- D. 右乳头下与左乳头下
- E. 背部肩胛间区与心前区

答案：A

> 解析：【正确答案】AED 电极的标准位置是右侧电极置于病人右锁骨下区，左侧电极置于左乳头侧腋中线处。这样可使除颤电流尽量横穿心脏，提高除颤成功率；电极应紧贴皮肤，避开起搏器与潮湿部位。
>
> 【逐项解析】A. 右锁骨下区与左乳头侧腋中线，是 AED 的标准电极位置。（正确）
> B. 左右位置放反，电流方向虽仍可穿过心脏，但不符合标准放置。（错误）
> C. 胸骨正中与剑突不能形成横穿心脏的电流通路，且剑突处易致损伤。（错误）
> D. 双乳头下方位置偏低，电流不能有效覆盖心室。（错误）
> E. 背部与心前区位置适用于部分手动除颤，不是 AED 的标准前后位。（错误）
>
> 【易错点】AED 电极记“右锁下、左腋中”，一上一下夹住心脏。

---

25. [A1型题｜理解] batch043-M02-A1-009

> 模块：M02｜页码：教材P244、P256

创伤性心脏骤停病人建立高级气道时，最可靠的方法是

- A. 口咽通气道
- B. 鼻咽通气道
- C. 食管气管联合导管
- **D. 气管插管** ✅
- E. 面罩球囊通气

答案：D

> 解析：【正确答案】创伤性心脏骤停常伴气道阻塞、血气胸、出血等可逆病因，建立人工气道最可靠的方法是气管插管，能完全控制气道、防止误吸并保证氧供；口咽/鼻咽通气道与面罩球囊属于基础气道支持，不能替代确切人工气道。
>
> 【逐项解析】A. 口咽通气道只能暂时解除舌后坠，不能完全控制气道或防误吸。（错误）
> B. 鼻咽通气道同样属于基础气道，禁用于严重颌面外伤。（错误）
> C. 食管气管联合导管可用于插管困难，但不是最可靠的方法。（错误）
> D. 气管插管能完全控制气道、防止误吸，是创伤骤停最可靠的人工气道。（正确）
> E. 面罩球囊通气不能隔离气道，仍有误吸风险。（错误）
>
> 【易错点】创伤骤停气道记“最可靠=气管插管”，不能插则环甲膜。

---

26. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-010

> 模块：M02｜页码：教材P239

成人气道完全梗阻行海姆立克腹部冲击时，手拳应放在

- A. 剑突正下方处
- **B. 剑突与脐之间的腹中线** ✅
- C. 脐下两横指
- D. 右侧肋缘下
- E. 胸骨正中处

答案：B

> 解析：【正确答案】海姆立克腹部冲击时，救助者一手握拳，拳眼顶住病人腹部，位置在剑突与脐之间的腹中线，另一手握住拳头快速向内、向上冲击，利用胸腔内压骤升把异物冲出。冲击剑突或肋缘易致骨折与内脏损伤。
>
> 【逐项解析】A. 剑突处冲击易致剑突骨折、肝损伤，位置偏高。（错误）
> B. 剑突与脐之间的腹中线，是海姆立克腹部冲击的标准位置。（正确）
> C. 脐下位置过低，不能有效抬高膈肌、增加胸内压。（错误）
> D. 右侧肋缘下易致肝损伤，且压力方向不对；把冲击点偏向肋缘。（错误）
> E. 胸骨正中进行的是胸部冲击，适用于妊娠末期或肥胖者。（错误）
>
> 【易错点】腹部冲击点记“剑突与脐之间”，不是剑突、也不是脐下。

---

27. [A1型题｜理解] batch043-M02-A1-011

> 模块：M02｜页码：教材P239

妊娠末期或过度肥胖病人发生气道完全梗阻时，应采用的冲击方法是

- A. 腹部冲击法
- **B. 胸部冲击法** ✅
- C. 拍背法
- D. 饮水冲咽法
- E. 手指盲目掏取

答案：B

> 解析：【正确答案】妊娠末期或过度肥胖者腹部膨隆，救助者无法用双臂环抱腰部行腹部冲击，应改用胸部冲击法：站在病人身后，双臂从其腋下环抱胸部，拳的拇指侧放在胸骨中线、避开剑突和肋骨下缘，向后冲压直至异物排出。
>
> 【逐项解析】A. 腹部冲击需要环抱腰部，妊娠末期/肥胖者无法实施，且可能损伤胎儿。（错误）
> B. 胸部冲击法适用于妊娠末期或过度肥胖者，位置在胸骨中线、避开剑突与肋缘。（正确）
> C. 单纯拍背对成人完全梗阻效果有限，不能替代胸部冲击。（错误）
> D. 饮水冲咽可能加重梗阻或导致误吸，禁忌；用土办法处理完全梗阻。（错误）
> E. 手指盲目掏取可能把异物推得更深，仅在可见异物时使用。（错误）
>
> 【易错点】特殊人群记“孕妇胖人压胸，不压腹”。

---

28. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-001

> 模块：M02｜页码：教材P235-237

男，58 岁，在门诊候诊时突然倒地，呼之不应，无正常呼吸，颈动脉搏动消失，现场有 AED。最恰当的处置顺序是

- A. 先测血压，等AED到场再按压
- **B. 立即胸外按压，同时取AED，尽快除颤** ✅
- C. 先开放气道并人工呼吸2分钟，再按压
- D. 先等心电图确认室颤，再决定是否除颤
- E. 立即静脉推注肾上腺素，再开始按压

答案：B

> 解析：【正确答案】目击倒地、无反应、无正常呼吸且大动脉搏动消失，即可临床诊断心搏骤停，应立即开始胸外按压并呼叫帮助、取 AED；AED 到达后尽快分析心律，室颤/无脉室速立即电击。等待心电图或先用药都会延误灌注与除颤。
>
> 【逐项解析】A. 骤停时血压往往测不到，测血压会浪费黄金时间，且休克不是骤停的同义词。（错误）
> B. 立即按压并尽快取 AED 除颤，符合目击骤停的生存链。（正确）
> C. 先通气 2 分钟会延误按压与除颤，降低存活率。（错误）
> D. 等心电图确认会延误除颤，每延迟 1 分钟存活率下降 7%～10%。（错误）
> E. 肾上腺素应在按压/除颤基础上使用，不能替代早期按压与除颤。（错误）
>
> 【易错点】目击骤停：先按压、快除颤，不等心电图、不先用药。

---

29. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-002

> 模块：M02｜页码：教材P235-237

男，62 岁，突发意识丧失，AED 分析为心室颤动，给予 1 次电击后心律恢复为有组织的电活动。此时最恰当的处理是

- A. 立即检查脉搏1分钟
- **B. 立即继续胸外按压2分钟** ✅
- C. 立即静脉推注胺碘酮
- D. 立即停止复苏并转运
- E. 立即再次电击

答案：B

> 解析：【正确答案】电除颤终止室颤后的最初阶段，心脏常处于无灌注或低灌注状态，即使恢复了有节律的心电活动，也应立即胸外按压 2 分钟，再检查心律和脉搏。过早检查脉搏或再次电击会中断灌注，降低复苏成功率。
>
> 【逐项解析】A. 电击后立即查脉搏会中断按压，且此时灌注尚未稳定。（错误）
> B. 电击后立即按压 2 分钟，再评估心律与脉搏，符合复苏流程。（正确）
> C. 胺碘酮用于难治性室颤/室速，不是电击后立即常规使用。（错误）
> D. 刚恢复电活动不等于循环稳定，不能立即停止复苏。（错误）
> E. 心律已恢复有组织电活动，不应立即再次电击；应继续按压并评估。（错误）
>
> 【易错点】电击后先按压 2 分钟再摸脉搏，别被“心律回来了”骗到。

---

30. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-003

> 模块：M02｜页码：教材P239

男，45 岁，进食时突然双手抓颈、不能说话、不能咳嗽，面色发绀，但意识清楚、能站立。现场首选的处理是

- A. 鼓励用力咳嗽
- **B. 立即行海姆立克腹部冲击** ✅
- C. 立即行胸部冲击
- D. 大量喂水冲咽
- E. 立即心肺复苏

答案：B

> 解析：【正确答案】病人不能说话、不能咳嗽、双手抓颈，提示气道完全梗阻；意识清楚且能站立时，首选海姆立克腹部冲击，手拳置于剑突与脐之间的腹中线，快速向内、向上冲击，直至异物排出。
>
> 【逐项解析】A. 完全梗阻时无法有效咳嗽，鼓励咳嗽会延误抢救。（错误）
> B. 意识清楚、能站立的完全梗阻，首选腹部冲击，位置在剑突与脐之间。（正确）
> C. 胸部冲击用于妊娠末期或过度肥胖者，本例无此情况。（错误）
> D. 喂水会加重梗阻并导致误吸，禁忌；用土办法处理完全梗阻。（错误）
> E. 病人意识清楚、有脉搏，尚未到心肺复苏阶段。（错误）
>
> 【易错点】完全梗阻、意识清醒：先腹部冲击；倒地无意识才转 CPR。

---

31. [A3型题｜应用] batch043-M02-A3-001

> 模块：M02｜页码：教材P235

关于该病人的胸外按压，下列做法正确的是

- A. 60～80次/分，深3～4cm
- **B. 100～120次/分，深5～6cm** ✅
- C. 140次/分，深6～7cm
- D. 按压时肘关节屈曲，借助手臂力量
- E. 每次按压后手掌离开胸壁休息

答案：B

> 解析：【正确答案】该病人为目击心搏骤停，应立即行高质量 CPR：按压频率 100～120 次/分、深度 5～6cm，肩肘腕在同一轴线、垂直向下，每次按压后让胸廓完全回弹但手掌不离开胸壁，尽量减少中断。
>
> 【逐项解析】A. 频率与深度均低于标准，不能产生有效灌注。（错误）
> B. 100～120 次/分、5～6cm 是成人高质量按压标准。（正确）
> C. 频率过快、深度过深，增加损伤且充盈不足。（错误）
> D. 屈肘会使按压力量分散、深度不足，应保持肩肘腕一条直线。（错误）
> E. 手掌离开胸壁会导致位置丢失与按压中断，应贴住胸壁回弹。（错误）
>
> 【易错点】跑步倒地目击骤停：先按压，参数记 100～120、5～6cm。

---

32. [A3型题｜分析] batch043-M02-A3-002

> 模块：M02｜页码：教材P236

现场仅有一名施救者，尚未建立高级气道。其按压与通气比例应为

- A. 15:2
- **B. 30:2** ✅
- C. 50:2
- D. 持续按压不通气
- E. 按压2分钟、通气2分钟交替

答案：B

> 解析：【正确答案】成人单人心肺复苏、尚未建立高级气道时，按压与通气比为 30:2；每 5 组 30:2 为一个周期，约 2 分钟。15:2 是双人小儿复苏比例；建立高级气道后才改为连续按压、每 6 秒通气 1 次。
>
> 【逐项解析】A. 15:2 是双人小儿复苏的比例，不适用于成人单人。（错误）
> B. 成人单人、未建立高级气道时为 30:2，正确。（正确）
> C. 50:2 不是推荐比例，过度按压会减少必要通气。（错误）
> D. 不通气会导致缺氧加重，除非已建立高级气道并有持续氧供。（错误）
> E. 按压与通气应交替，不是整段时间分开进行。（错误）
>
> 【易错点】成人单人 30:2；高级气道后才是连续按压+10 次/分通气。

---

33. [判断题｜记忆] batch043-M02-JUD-001

> 模块：M02｜页码：教材P237

使用 AED 时，一个电极放在右锁骨下区，另一个电极放在左乳头侧腋中线处。

- **A. 正确** ✅
- B. 错误

答案：A

> 解析：【正确答案】AED 电极的标准位置正是右侧电极置于右锁骨下区、左侧电极置于左乳头侧腋中线处，使除颤电流横穿心脏。电极应紧贴皮肤，避开起搏器、药物贴片与潮湿部位。
>
> 【逐项解析】A. 该描述与 AED 标准电极位置一致，故正确。（正确）
> B. 把正确位置判为错误，说明左右或高低位置记错。（错误）
>
> 【易错点】AED 电极：右锁下、左腋中，两个点夹住心脏。

---

34. [判断题｜理解] batch043-M02-JUD-002

> 模块：M02｜页码：教材P244、P256

怀疑颈椎损伤的病人开放气道时，应采用仰头抬颏法，使头部充分后仰。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】怀疑颈椎损伤时禁用仰头抬颏法，因为头部后仰可能加重脊髓损伤；应采用双手托颌法，在保持头颈部固定的前提下向上托起下颌，必要时加用颈托。
>
> 【逐项解析】A. 仰头抬颏会使颈椎过伸，可能加重脊髓损伤，故该说法错误。（错误）
> B. 怀疑颈椎损伤应改用双手托颌法，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】颈椎损伤记“托颌不仰头”。

---

35. [判断题｜记忆] batch043-M02-JUD-003

> 模块：M02｜页码：教材P235

成人胸外按压的部位是胸骨上 1/3 与胸骨柄交界处。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】成人胸外按压部位是胸骨中下 1/3 或两乳头连线与胸骨交界点中央，不是胸骨上 1/3。位置过高不能有效挤压心室，位置过低（剑突）则易致肝脾损伤。
>
> 【逐项解析】A. 胸骨上 1/3 位置过高，不能有效挤压心脏，故原句错误。（错误）
> B. 正确部位是胸骨中下 1/3，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】按压点在“胸骨中下 1/3”，不在上 1/3、不在剑突。

---

36. [X型题｜理解] batch043-M02-X-001

> 模块：M02｜页码：教材P235

下列属于成人高质量心肺复苏要点的有

- **A. 按压频率100～120次/分** ✅
- **B. 按压深度5～6cm** ✅
- **C. 每次按压后让胸廓完全回弹** ✅
- **D. 尽量将按压中断控制在10秒以内** ✅
- E. 按压时快速、用力，允许胸廓不完全回弹

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】高质量 CPR 的要点包括：按压频率 100～120 次/分、深度 5～6cm、每次按压后胸廓完全回弹、尽量减少中断（小于 10 秒）。胸廓不完全回弹会增加胸内压、减少静脉回流，降低心输出量，是错误的。
>
> 【逐项解析】A. 100～120 次/分是推荐按压频率，属于高质量要点。（正确）
> B. 5～6cm 是推荐按压深度，属于高质量要点。（正确）
> C. 每次按压后胸廓完全回弹，属于高质量要点。（正确）
> D. 按压中断小于 10 秒，属于高质量要点。（正确）
> E. 允许胸廓不完全回弹会减少静脉回流，不是高质量要点。（错误）
>
> 【易错点】高质量 CPR 四要素：够快、够深、全回弹、少中断。

---

37. [X型题｜理解] batch043-M02-X-002

> 模块：M02｜页码：教材P237

关于成人电除颤，下列叙述正确的有

- **A. 心室颤动应立即电除颤** ✅
- **B. 无脉性室性心动过速可电除颤** ✅
- C. 心室静止应立即电除颤
- **D. 单相波首次能量为360J** ✅
- **E. 双相波首次能量为120～200J** ✅

答案：ABDE

> 解析：【正确答案】可电击心律包括心室颤动和无脉性室性心动过速，应立即除颤；心室静止与无脉性电活动不可电击，应继续 CPR、肾上腺素并寻找可逆病因。单相波首次 360J，双相波首次 120～200J。
>
> 【逐项解析】A. 心室颤动是可电击心律，应立即除颤，叙述正确。（正确）
> B. 无脉性室速同样可电击，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 心室静止不是可电击心律，电击无效且可能损害心肌，叙述错误。（错误）
> D. 单相波首次 360J，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 双相波首次 120～200J，叙述正确。（正确）
>
> 【易错点】可电击只有室颤和无脉室速；心室静止/PEA 不电击。

---

38. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-012

> 模块：M02｜页码：教材P231-233

心搏骤停病人的黄金抢救时间是

- A. 1分钟
- B. 2分钟
- **C. 4分钟** ✅
- D. 8分钟
- E. 10分钟

答案：C

> 解析：【正确答案】心搏骤停后脑组织对缺氧极敏感，黄金抢救时间为 4 分钟；4 分钟内开始有效心肺复苏，神经功能恢复机会明显增加，超过 10 分钟仍未复苏者神经功能极少能恢复。
>
> 【逐项解析】A. 1 分钟是理想启动时间，但“黄金”界值指 4 分钟。（错误）
> B. 2 分钟仍在黄金窗内，但不是界值；把窗口内时点当界值。（错误）
> C. 4 分钟是公认的黄金抢救时间；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 8 分钟已明显超过黄金窗，脑损害加重；把耐受时间估长。（错误）
> E. 10 分钟是神经功能几乎不能恢复的界限。（错误）
>
> 【易错点】黄金 4 分钟、10 分钟为预后分水岭；看到“骤停”先算时间。

---

39. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-013

> 模块：M02｜页码：教材P231-233

心搏骤停最常见的心律失常是

- **A. 心室颤动** ✅
- B. 心房颤动
- C. 室性心动过速
- D. 窦性心动过缓
- E. 房室传导阻滞

答案：A

> 解析：【正确答案】心搏骤停最常见的心律失常是心室颤动，也是除颤最有效的可电击心律；室性心动过速虽也属可电击心律，但发生率低于室颤，且部分可自行终止。
>
> 【逐项解析】A. 心室颤动是心搏骤停最常见的心律失常，也是除颤首选目标。（正确）
> B. 心房颤动多有脉搏，不直接导致骤停；把房颤当成室颤。（错误）
> C. 室速是可电击心律，但发生率低于室颤；把可电击等同最常见。（错误）
> D. 窦缓一般不引起骤停，除非极度缓慢；把缓慢性心律失常当常见。（错误）
> E. 房室传导阻滞以心动过缓为主，非最常见；混淆传导阻滞与骤停。（错误）
>
> 【易错点】骤停＝室颤最常见；可电击心律＝室颤＋无脉室速。

---

40. [A1型题｜理解] batch043-M02-A1-014

> 模块：M02｜页码：教材P235

成人高质量心肺复苏时，胸外按压的中断时间应控制在

- A. <5秒
- **B. <10秒** ✅
- C. <20秒
- D. <30秒
- E. <60秒

答案：B

> 解析：【正确答案】高质量 CPR 要求尽量减少按压中断，每次中断时间 <10 秒。中断期间冠脉灌注压迅速下降，频繁或长时间中断（如反复摸脉、长时间分析心律）会显著降低复苏成功率。
>
> 【逐项解析】A. <5 秒更理想，但教材标准是 <10 秒。（错误）
> B. <10 秒是高质量 CPR 的中断上限。（正确）
> C. <20 秒已超过标准，灌注压下降明显；把上限放宽。（错误）
> D. <30 秒中断过久，复苏成功率下降；低估中断代价。（错误）
> E. <60 秒严重违反高质量 CPR 要求。（错误）
>
> 【易错点】按压中断只有一条线：<10 秒；摸脉、分析、换人都在 10 秒内完成。

---

41. [A1型题｜理解] batch043-M02-A1-015

> 模块：M02｜页码：教材P239-240

1 岁以内婴儿发生气道异物梗阻，推荐使用的现场手法是

- A. 腹部冲击法
- **B. 拍背与冲胸法** ✅
- C. 胸部冲击法
- D. 倒提拍背法
- E. 环甲膜穿刺

答案：B

> 解析：【正确答案】婴儿气道异物梗阻推荐拍背与冲胸法：先俯卧于前臂、头低脚高拍背 5 次，再翻转为仰卧按压胸部 5 次，交替进行。婴儿肝脏相对大、位置高，腹部冲击易致肝损伤，不作首选。
>
> 【逐项解析】A. 腹部冲击易损伤婴儿肝脏，不是推荐手法；把成人海姆立克套给婴儿。（错误）
> B. 拍背与冲胸交替是婴儿气道异物的推荐手法。（正确）
> C. 胸部冲击是妊娠末期或肥胖成人的替代手法。（错误）
> D. 倒提拍背易致颈椎与内脏损伤，禁忌；用土办法处理婴儿梗阻。（错误）
> E. 环甲膜穿刺是有创气道，仅在完全梗阻且插管失败时使用。（错误）
>
> 【易错点】婴儿记“5 拍背 + 5 冲胸”，禁用腹部冲击。

---

42. [A1型题｜理解] batch043-M02-A1-016

> 模块：M02｜页码：教材P244、P256

创伤性心脏骤停病人，若声门水肿导致气管插管失败，应立即

- A. 加大球囊通气
- **B. 行环甲膜穿刺或切开** ✅
- C. 改用口咽通气道
- D. 等待麻醉科会诊
- E. 立即行气管切开

答案：B

> 解析：【正确答案】创伤性心脏骤停的高级气道首选气管插管；当插管失败且存在声门水肿、上气道梗阻时，应立即行环甲膜穿刺或切开，迅速建立有创气道，不能因等待会诊而延误通气。
>
> 【逐项解析】A. 球囊通气无法绕过上气道梗阻；把通气困难当成通气不足。（错误）
> B. 环甲膜穿刺或切开是插管失败时的紧急有创气道。（正确）
> C. 口咽通气道只能解除舌后坠，不能绕过声门梗阻。（错误）
> D. 等待会诊会延误数分钟，脑缺氧不可逆；把会诊置于通气之前。（错误）
> E. 气管切开需时较长，紧急情况首选环甲膜；把择期手术当急救。（错误）
>
> 【易错点】插管失败＋上气道梗阻＝环甲膜；气管切开是后续，不是第一反应。

---

43. [A1型题｜记忆] batch043-M02-A1-017

> 模块：M02｜页码：教材P231-233

心搏骤停后若未行心肺复苏，神经功能极少能恢复的时间界值是

- A. 2分钟
- B. 4分钟
- C. 6分钟
- **D. 10分钟** ✅
- E. 15分钟

答案：D

> 解析：【正确答案】心搏骤停后 4 分钟内开始复苏效果最好，若 10 分钟内仍未行心肺复苏，脑组织缺血缺氧性损害已不可逆，神经功能极少能恢复，因此 10 分钟是预后判断的重要界值。
>
> 【逐项解析】A. 2 分钟仍在黄金窗内，不影响神经功能恢复。（错误）
> B. 4 分钟是黄金抢救时间，不是“极少恢复”界值。（错误）
> C. 6 分钟已有损害，但尚未到极少恢复的界值。（错误）
> D. 10 分钟未复苏者神经功能极少能恢复；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 15 分钟时已几乎无恢复可能，界值仍是 10 分钟。（错误）
>
> 【易错点】两个时间点别混：4 分钟是黄金窗，10 分钟是神经功能几乎不可恢复线。

---

44. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-004

> 模块：M02｜页码：教材P244、P256

男，35 岁，车祸致面部多发伤、意识不清，现场怀疑颈椎损伤。开放气道时应采用的手法是

- A. 仰头抬颏法
- **B. 双手托颌法** ✅
- C. 压额抬颈法
- D. 直接口对口吹气
- E. 头低足高位

答案：B

> 解析：【正确答案】怀疑颈椎损伤时，仰头抬颏会使颈椎过度后伸，可能加重脊髓损伤；应采用双手托颌法，双手固定头部两侧、托起下颌向前，保持颈椎中立位的同时开放气道。
>
> 【逐项解析】A. 仰头抬颏会使颈椎后伸，可能加重脊髓损伤。（错误）
> B. 双手托颌法可在颈椎中立位下开放气道；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 压额抬颈同样使颈椎过伸，禁忌；把两种抬头手法混为一谈。（错误）
> D. 未开放气道就吹气会造成胃胀气与误吸；跳过开放气道。（错误）
> E. 头低足位不能开放气道，且加重颅内压；用体位代替手法。（错误）
>
> 【易错点】颈椎伤开放气道记“托颌不仰头”；仰头抬颏是常规，不是创伤常规。

---

45. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-005

> 模块：M02｜页码：教材P236

男，60 岁，心搏骤停，两名施救者已持续胸外按压 5 分钟。为保证按压质量，正确的做法是

- **A. 每2分钟轮换一次** ✅
- B. 每5分钟轮换一次
- C. 每10分钟轮换一次
- D. 不轮换以免中断
- E. 感觉疲劳时才轮换

答案：A

> 解析：【正确答案】2 人以上心肺复苏应每 2 分钟轮换一次按压者，与 5 组 30:2 的周期同步，在换人时完成心律分析与除颤，既不额外增加中断，又能避免按压者疲劳导致深度和频率下降。
>
> 【逐项解析】A. 每 2 分钟轮换与一个 CPR 周期同步，最符合规范。（正确）
> B. 5 分钟轮换时按压质量已明显下降；把轮换间隔拉长。（错误）
> C. 10 分钟轮换过晚，深度与频率难以保证。（错误）
> D. 不轮换会因疲劳导致按压变浅变慢；把连续按压绝对化。（错误）
> E. 等到疲劳才换缺乏客观节点，质量已受损；凭感觉决定轮换。（错误）
>
> 【易错点】轮换看周期不看感觉：每 2 分钟（5 组 30:2）换一次。

---

46. [A2型题｜应用] batch043-M02-A2-006

> 模块：M02｜页码：教材P239-240

女，32 岁，妊娠 32 周，进食时突然不能说话、双手抓颈、面色发绀，意识清楚尚能站立。此时应采用的冲击部位是

- A. 剑突与脐之间
- **B. 胸骨中线，避开剑突** ✅
- C. 左侧第5肋间
- D. 背部两肩胛之间
- E. 上腹部偏左侧

答案：B

> 解析：【正确答案】该病人为完全性气道梗阻且意识清楚，应行海姆立克手法；但妊娠末期子宫增大，腹部冲击可能损伤子宫与胎儿，应改用胸部冲击，冲击点取胸骨中线，避开剑突和肋骨下缘。
>
> 【逐项解析】A. 腹部冲击在妊娠末期可能损伤子宫与胎儿；把常规海姆立克套给孕妇。（错误）
> B. 妊娠末期改用胸部冲击，位置在胸骨中线；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 左侧第 5 肋间是胸腔穿刺位置，不是冲击点。（错误）
> D. 背部拍击适用于婴儿或部分清醒成人，孕妇首选胸部冲击。（错误）
> E. 上腹偏左仍在腹部，可能伤及增大的子宫；把位置稍移仍算腹部。（错误）
>
> 【易错点】孕妇/肥胖者记“上腹不能压，改压胸骨中线”。

---

47. [X型题｜理解] batch043-M02-X-003

> 模块：M02｜页码：教材P237

关于 AED 与电除颤的操作，下列叙述正确的有

- **A. 右侧电极置于右锁骨下区** ✅
- **B. 左侧电极置于左乳头侧腋中线** ✅
- **C. 双相波首次能量120～200J** ✅
- **D. 分析心律时任何人不得接触病人** ✅
- E. 电击后应等待心律恢复再按压

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】AED 电极位置为右侧锁骨下区、左侧乳头侧腋中线；双相波首次能量 120～200J，单相波 360J；分析心律时必须离开病人，避免干扰与触电；电击后应立即恢复胸外按压 2 分钟，再判断心律，而不是等待心律恢复。
>
> 【逐项解析】A. 右锁骨下区是右侧电极的标准位置，叙述正确。（正确）
> B. 左乳头侧腋中线是左侧电极的标准位置，叙述正确。（正确）
> C. 双相波 120～200J 符合教材能量范围，叙述正确。（正确）
> D. 分析时接触病人会干扰心律识别并可能触电，叙述正确。（正确）
> E. 电击后应立即按压，等待心律恢复会延长无灌注时间，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】AED 五件事：右锁骨下、左腋中线、双相 120～200、分析时离开、电击后立即按压。

---

48. [X型题｜理解] batch043-M02-X-004

> 模块：M02｜页码：教材P239-240

关于气道异物梗阻与紧急有创气道，下列叙述正确的有

- **A. 成人完全梗阻意识清醒首选腹部冲击** ✅
- **B. 妊娠末期改用胸部冲击** ✅
- **C. 婴儿采用拍背与冲胸法** ✅
- **D. 环甲膜穿刺用于插管失败的上气道梗阻** ✅
- E. 异物梗阻意识丧失后应立即停止抢救

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】成人完全性气道梗阻且意识清醒时首选海姆立克腹部冲击；妊娠末期或过度肥胖者改用胸部冲击；婴儿用拍背与冲胸法；环甲膜穿刺或切开用于气管插管失败、上气道梗阻的紧急情况。异物梗阻病人意识丧失后应转为心肺复苏，而不是停止抢救。
>
> 【逐项解析】A. 成人完全梗阻、意识清醒首选腹部冲击，叙述正确。（正确）
> B. 妊娠末期改用胸部冲击，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 婴儿采用拍背与冲胸法，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 环甲膜穿刺是插管失败时的紧急有创气道，叙述正确。（正确）
> E. 意识丧失后应立即行 CPR，停止抢救是错误的。（错误）
>
> 【易错点】异物梗阻三步走：清醒腹部冲击→孕妇胸部冲击→倒地立即 CPR。

M03（24题）

49. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-001

> 模块：M03｜页码：教材P148

休克的本质是

- A. 血压低于90/60mmHg
- **B. 有效循环血量减少致灌注不足** ✅
- C. 心率超过120次/分
- D. 外周血管阻力持续升高
- E. 心脏指数低于正常

答案：B

> 解析：【正确答案】休克是由各种致病因素引起的有效循环血容量急剧减少，导致器官和组织微循环灌注不足，致使组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损乃至结构破坏的综合征。血压低只是可能的表现，不能等同于休克。
>
> 【逐项解析】A. 血压低于 90/60mmHg 是低血压的数值标准，部分休克早期血压可正常。（错误）
> B. 有效循环血容量急剧减少、微循环灌注不足，正是休克的本质。（正确）
> C. 心率增快是代偿表现之一，不是休克的本质定义。（错误）
> D. 外周阻力可升高（低血容量/心源）也可降低（感染/过敏），不是本质。（错误）
> E. 心脏指数降低见于心源性休克，不是所有休克的本质。（错误）
>
> 【易错点】休克记“灌注不足”，不记“血压低”；血压正常也要看乳酸、尿量、皮肤灌注。

---

50. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-002

> 模块：M03｜页码：教材P148

按病因分类，休克不包括下列哪一型

- A. 低血容量性休克
- B. 心源性休克
- C. 感染性休克
- D. 过敏性休克
- **E. 内分泌性休克** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】按病因分类，休克分为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性五型；不同类型病因并不互斥，可同时存在数种而称为复合性休克。内分泌性休克不是教材采用的病因分型。
>
> 【逐项解析】A. 低血容量性是五型之一，由失血或脱水引起。（正确）
> B. 心源性是五型之一，由泵功能衰竭引起；漏记心源性。（正确）
> C. 感染性是五型之一，由感染与血管扩张引起。（正确）
> D. 过敏性也是五型之一，由过敏反应引起；漏记过敏性。（正确）
> E. 内分泌性休克不属于教材的五型分类，为正确选项。（错误）
>
> 【易错点】五型记“低心感过神”，内分泌性不在其中。

---

51. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-003

> 模块：M03｜页码：教材P153-154

关于急性失血引起的变化，下列哪一项是错误的

- A. 动脉血压下降
- **B. 红细胞比容升高** ✅
- C. 心率加快
- D. 中心静脉压下降
- E. 皮肤苍白湿冷

答案：B

> 解析：【正确答案】急性失血时，血容量减少导致动脉血压下降、中心静脉压下降、心率代偿性加快，皮肤因交感收缩而苍白湿冷；但红细胞与血浆按比例丢失，早期红细胞比容通常正常或仅轻度下降，不会升高（升高见于脱水/血液浓缩）。
>
> 【逐项解析】A. 失血使有效循环血量减少，动脉血压下降，叙述正确。（正确）
> B. 急性全血丢失时红细胞比容不会升高，该说法错误，为本题答案。（错误）
> C. 失血后交感兴奋使心率加快，叙述正确；把失血后心率加快误判为错误。（正确）
> D. 回心血量减少使中心静脉压下降，叙述正确。（正确）
> E. 交感收缩使皮肤苍白湿冷，叙述正确；把失血后皮肤苍白湿冷误判为错误。（正确）
>
> 【易错点】急性失血早期 Hct 可正常或下降；Hct 升高提示脱水/浓缩，不是急性失血。

---

52. [A1型题｜应用] batch043-M03-A1-004

> 模块：M03｜页码：教材P151

休克病人动态监测中心静脉压值为 25cmH_2O，表示

- A. 急性肺梗塞
- B. 静脉血管床过度收缩
- C. 肺循环阻力增加
- D. 血容量不足
- **E. 充血性心力衰竭** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】中心静脉压正常约 5～12cmH_2O，升高至 25cmH_2O 提示右心前负荷过高或右心泵功能衰竭，最常见于充血性心力衰竭、容量过负荷或心脏压塞；血容量不足时 CVP 降低。
>
> 【逐项解析】A. 肺梗塞可致右心负荷增加，但 CVP 25cmH_2O 不是其特异表现。（错误）
> B. 静脉血管床过度收缩可使 CVP 升高，但 25cmH_2O 更提示心衰/容量过负荷。（错误）
> C. 肺循环阻力增加主要影响右室后负荷，不是 CVP 升高的直接解释。（错误）
> D. 血容量不足时 CVP 降低，与本例相反。（错误）
> E. CVP 25cmH_2O 明显升高，提示充血性心力衰竭/容量过负荷。（正确）
>
> 【易错点】CVP 记“低了容量不足、高了心衰/过负荷”，25cmH_2O 属明显升高。

---

53. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-005

> 模块：M03｜页码：教材P155

感染性休克病人最初 6 小时液体复苏的目标，不包括

- A. 中心静脉压8～12mmHg
- B. 平均动脉压≥65mmHg
- C. 尿量≥0.5ml/(kg・h)
- D. 中心静脉血氧饱和度≥70%
- **E. 中心静脉压降至2～5mmHg** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】感染性休克最初 6 小时复苏目标为中心静脉压 8～12mmHg、平均动脉压≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、中心静脉或混合静脉血氧饱和度≥70%。中心静脉压降至 2～5mmHg 提示容量严重不足，不是复苏目标。
>
> 【逐项解析】A. CVP 8～12mmHg 是复苏目标之一，反映前负荷。（正确）
> B. MAP≥65mmHg 是保证器官灌注的目标。（正确）
> C. 尿量≥0.5ml/(kg・h) 是组织灌注有效的实用指标。（正确）
> D. ScvO2≥70% 反映氧输送与氧耗平衡，是目标之一。（正确）
> E. CVP 2～5mmHg 过低，提示容量不足，不是复苏目标。（错误）
>
> 【易错点】感染性休克 6 小时四目标：CVP 8～12、MAP≥65、尿量 0.5、ScvO2≥70%。

---

54. [A1型题｜记忆] batch043-M03-A1-006

> 模块：M03｜页码：教材P155

过敏性休克的首选药物及给药途径是

- A. 地塞米松静脉注射
- **B. 肾上腺素肌内注射** ✅
- C. 去甲肾上腺素静脉滴注
- D. 多巴胺静脉滴注
- E. 异丙嗪肌内注射

答案：B

> 解析：【正确答案】过敏性休克一旦发生，应立即去除过敏原，首选肾上腺素肌内注射；它能迅速收缩血管、升高血压、缓解支气管痉挛和喉头水肿。糖皮质激素、抗组胺药、升压药为辅助，不能替代肾上腺素。
>
> 【逐项解析】A. 糖皮质激素起效慢，不能迅速逆转喉水肿与休克，只能辅助。（错误）
> B. 肾上腺素肌内注射是过敏性休克的首选，起效快。（正确）
> C. 去甲肾上腺素用于感染性休克等，不是过敏首选。（错误）
> D. 多巴胺为辅助升压药，起效与气道保护不如肾上腺素。（错误）
> E. 抗组胺药只能减轻皮肤症状，不能逆转休克。（错误）
>
> 【易错点】过敏性休克记“肾上腺素肌注第一”，激素和抗组胺都排后面。

---

55. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-007

> 模块：M03｜页码：教材P152-153

关于休克的治疗原则，不正确的是

- A. 失血性休克的治疗首先以输注平衡盐溶液为主
- **B. 以处理原发感染灶、抗感染为主** ✅
- C. 不主张早期用碱性药纠酸
- D. 在充分容量复苏的前提下可给予血管活性药物
- E. 先纠正休克，再处理原发病

答案：B

> 解析：【正确答案】休克的共同首要环节是纠正有效循环血量不足与组织灌注，感染性休克也不例外：应在液体复苏的同时尽早抗感染与清除感染灶，但不能把“处理原发感染灶、抗感染”作为唯一的首要治疗而忽略液体复苏；其余选项均符合休克治疗原则。
>
> 【逐项解析】A. 失血性休克先输平衡盐溶液扩容，叙述正确。（正确）
> B. 感染性休克不能只强调抗感染而忽略液体复苏，该说法不正确，为本题答案。（错误）
> C. 休克酸中毒不主张早期用碱性药，叙述正确。（正确）
> D. 充分容量复苏后可给血管活性药，叙述正确。（正确）
> E. 先纠正休克再处理原发病，符合“先救命”原则，叙述正确。（正确）
>
> 【易错点】感染性休克也要先液体复苏，抗感染是并行而非替代。

---

56. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-008

> 模块：M03｜页码：教材P153

休克病人使用血管活性药物的正确时机是

- A. 一诊断休克立即静脉推注升压药
- **B. 充分液体复苏后血压仍不稳定时** ✅
- C. 输血前预防性使用
- D. 心率超过100次/分时
- E. 中心静脉压升高时

答案：B

> 解析：【正确答案】血管活性药物适用于经充分液体复苏后血压仍不稳定，或休克症状未见缓解、血压仍继续下降的严重休克；不能在输血输液前就用，否则会掩盖容量不足、加重组织缺血。心源性休克是限制补液的例外。
>
> 【逐项解析】A. 一诊断就推升压药会掩盖容量不足，且未纠正前负荷，灌注反而更差。（错误）
> B. 充分液体复苏后仍低血压才启用，符合休克治疗顺序。（正确）
> C. 输血前预防性升压没有依据，且可能加重心脏负荷。（错误）
> D. 心率快是代偿表现，不是升压药指征，需先找原因。（错误）
> E. CVP 升高提示容量已足或心衰，应减速补液并评估心功能，不是升压药指征。（错误）
>
> 【易错点】升压药顺序记“先液后药”，唯一例外是心源性休克限液。

---

57. [A2型题｜应用] batch043-M03-A2-001

> 模块：M03｜页码：教材P153-154

男，28 岁，车祸致左股骨骨折、骨盆骨折，血压 80/50mmHg，心率 130 次/分，皮肤湿冷。现场急救最恰当的处理是

- A. 先大量输注升压药维持血压
- B. 立即复位骨盆骨折后转运
- **C. 止血、固定骨盆、补液** ✅
- D. 先做CT明确全部伤情
- E. 立即手术内固定

答案：C

> 解析：【正确答案】该病人为创伤性/失血性休克，现场应先控制致命性外出血、固定骨盆与骨折、建立静脉通道并按限制性液体复苏快速补液，同时尽快转运至有手术条件的医院；升压药、复位、CT 都不能优先于止血与复苏。
>
> 【逐项解析】A. 升压药不能替代止血与扩容，且未控制出血时升压会加重出血。（错误）
> B. 现场复位缺乏条件且可能加重出血，应先固定而非复位。（错误）
> C. 控制出血、骨盆固定、建立通道并补液，符合创伤失血性休克现场处理。（正确）
> D. 血流动力学不稳定时不宜先做 CT，应在复苏同时快速转运。（错误）
> E. 休克未纠正时手术风险极高，需先复苏并控制出血。（错误）
>
> 【易错点】创伤休克现场三步：止血、固定骨盆、补液转运；升压药与 CT 都往后排。

---

58. [A2型题｜应用] batch043-M03-A2-002

> 模块：M03｜页码：教材P209-211

男，65 岁，重症肺炎入院第 4 天，出现呼吸衰竭需机械通气，随后血肌酐进行性升高、尿量减少，凝血功能异常。最符合的诊断是

- A. 慢性肾功能不全急性加重
- **B. 多器官功能障碍综合征** ✅
- C. 单纯性呼吸衰竭
- D. 感染性休克代偿期
- E. 急性左心衰竭

答案：B

> 解析：【正确答案】病人在重症肺炎这一严重打击后，序贯出现呼吸、肾脏、凝血等多个器官功能障碍，符合 MODS 的定义（严重打击后≥2 个器官序贯发生功能障碍）。MODS 可为原发性或继发性，治疗核心是控制原发病与器官支持。
>
> 【逐项解析】A. 慢性肾功能不全不能解释呼吸衰竭与凝血异常的序贯出现。（错误）
> B. 重症肺炎后呼吸、肾、凝血序贯障碍，符合 MODS。（正确）
> C. 单纯呼吸衰竭不能解释肾与凝血功能异常；漏掉多器官受累。（错误）
> D. 感染性休克代偿期以血流动力学为主，本例已有多器官障碍。（错误）
> E. 急性左心衰以肺水肿为主，不能解释肾衰与凝血异常。（错误）
>
> 【易错点】MODS 记“一个打击、两个以上器官、序贯发生”，不要只盯一个器官。

---

59. [判断题｜理解] batch043-M03-JUD-001

> 模块：M03｜页码：教材P152-154

心源性休克与低血容量性休克一样，均应首先快速、大量补液。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】补液是抗休克的基本治疗，但心源性休克是例外：其前负荷已高或肺淤血明显，快速大量补液会加重肺水肿。心源性休克应限制补液、取半卧位，使用正性肌力药/血管活性药并积极再灌注。
>
> 【逐项解析】A. 把低血容量的补液原则套到心源性休克，会加重肺水肿，故原句错误。（错误）
> B. 心源性休克应限制补液，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】补液原则记“除心源外先补液”，心源性要限液。

---

60. [X型题｜理解] batch043-M03-X-001

> 模块：M03｜页码：教材P148-155

关于各型休克的特点，下列叙述正确的有

- **A. 低血容量性休克中心静脉压降低** ✅
- **B. 心源性休克肺动脉楔压常升高** ✅
- **C. 感染性休克早期外周血管阻力可降低** ✅
- **D. 过敏性休克首选肾上腺素肌内注射** ✅
- E. 神经源性休克常表现为皮肤湿冷、外周阻力升高

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】低血容量性休克 CVP 降低；心源性休克 PAWP 常升高；感染性休克早期为分布性，外周阻力降低、皮肤可温暖；过敏性休克首选肾上腺素肌注。神经源性休克由交感张力骤降引起，表现为低血压伴心动过缓、皮肤温暖干燥、外周阻力降低，而非湿冷、阻力升高。
>
> 【逐项解析】A. 低血容量性休克 CVP 降低，叙述正确。（正确）
> B. 心源性休克 PAWP 常升高，叙述正确。（正确）
> C. 感染性休克早期血管扩张、外周阻力降低，叙述正确。（正确）
> D. 过敏性休克首选肾上腺素肌注，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 神经源性休克外周阻力降低、皮肤温暖干燥，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】五型休克的血流动力学方向要成对记，神经源性是“低阻力、暖干”。

---

61. [X型题｜理解] batch043-M03-X-002

> 模块：M03｜页码：教材P155

关于感染性休克的早期复苏，下列正确的有

- **A. 最初6小时中心静脉压目标8～12mmHg** ✅
- **B. 平均动脉压目标≥65mmHg** ✅
- **C. 尿量目标≥0.5ml/(kg·h)** ✅
- **D. 中心静脉血氧饱和度目标≥70%** ✅
- E. 首选大剂量糖皮质激素替代液体复苏

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】感染性休克最初 6 小时复苏目标包括 CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg·h)、ScvO2≥70%；糖皮质激素不是替代液体复苏的手段，仅在充分液体复苏和血管活性药后仍难以维持血压时酌情使用。
>
> 【逐项解析】A. CVP 8～12mmHg 是前负荷目标，叙述正确。（正确）
> B. MAP≥65mmHg 是灌注压目标，叙述正确。（正确）
> C. 尿量≥0.5ml/(kg·h) 是灌注有效指标，叙述正确。（正确）
> D. ScvO2≥70% 是氧平衡目标，叙述正确。（正确）
> E. 糖皮质激素不能替代液体复苏，且不常规大剂量使用，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】感染性休克先液体、后升压、再考虑激素，顺序不能倒。

---

62. [X型题｜理解] batch043-M03-X-003

> 模块：M03｜页码：教材P209-211、P228

关于多器官功能障碍综合征（MODS），下列叙述正确的有

- **A. 严重打击后≥2个器官序贯发生功能障碍** ✅
- **B. 可分为原发性与继发性** ✅
- **C. 治疗重点是控制原发病与器官功能支持** ✅
- D. MODS一旦发生必然不可逆
- E. 常规使用大剂量糖皮质激素

答案：ABC

> 解析：【正确答案】MODS 指严重打击后≥2 个器官序贯发生功能障碍，分原发性（直接损伤早期）与继发性（炎症失控）；治疗重点是控制原发病与器官支持。MODS 并非必然不可逆，早期干预可使器官功能恢复；不常规使用大剂量糖皮质激素。
>
> 【逐项解析】A. ≥2 个器官序贯障碍是 MODS 的定义，叙述正确。（正确）
> B. 原发与继发 MODS 的区分正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 控制原发病+器官支持是治疗核心，叙述正确。（正确）
> D. MODS 不是必然不可逆，早期干预可恢复，叙述错误。（错误）
> E. 不常规大剂量激素，叙述错误；把激素当成常规。（错误）
>
> 【易错点】MODS 三句话：≥2 器官、序贯、控原发病；不常规大剂量激素。

---

63. [A1型题｜记忆] batch043-M03-A1-009

> 模块：M03｜页码：教材P152

休克病人若无脊柱损伤和心衰，应采取的体位是

- **A. 头高20°～30°、下肢15°～20°** ✅
- B. 头躯干高40°、下肢下垂
- C. 头低足高位，下肢抬高40°
- D. 平卧位，头偏向一侧休息
- E. 半坐位，双下肢自然下垂

答案：A

> 解析：【正确答案】休克体位为头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°：下肢抬高促进静脉回流，头胸抬高利于呼吸并减少腹腔脏器对膈肌的压迫，兼顾循环与呼吸。
>
> 【逐项解析】A. 头高 20°～30°、下肢高 15°～20°是标准休克体位。（正确）
> B. 头高 40°会使脑灌注进一步下降，且下肢下垂减少回流。（错误）
> C. 头低足高会使腹腔脏器上推膈肌、影响通气，并增加颅内压。（错误）
> D. 平卧不能改善回心血量，也未兼顾呼吸；把休息体位当休克体位。（错误）
> E. 半坐位下肢下垂会减少静脉回流，加重低血压。（错误）
>
> 【易错点】休克体位记“头高 20～30、腿高 15～20”，不是头低足高。

---

64. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-010

> 模块：M03｜页码：教材P153-154

低血容量性休克的血流动力学特点，正确的是

- **A. CVP降低、CO下降、SVR增高** ✅
- B. CVP升高、CO下降、SVR增高
- C. CVP降低、CO升高、SVR降低
- D. CVP升高、CO升高、SVR降低
- E. CVP正常、CO正常、SVR正常

答案：A

> 解析：【正确答案】低血容量性休克时有效循环血量减少，回心血量下降使中心静脉压降低、心输出量下降；机体代偿性交感兴奋使外周血管阻力增加、心率加快，皮肤苍白湿冷。
>
> 【逐项解析】A. CVP 降低、CO 下降、SVR 增高，符合低血容量休克的代偿模式。（正确）
> B. CVP 升高不符合血容量不足，见于心衰或容量过负荷。（错误）
> C. CO 升高、SVR 降低是感染性休克的高排低阻模式。（错误）
> D. CVP 与 CO 均升高不符合失血；把高动力状态当失血。（错误）
> E. 三项均正常与明显休克不符；忽视代偿变化。（错误）
>
> 【易错点】低血容量＝低 CVP、低 CO、高 SVR；感染性＝高 CO、低 SVR。

---

65. [A1型题｜理解] batch043-M03-A1-011

> 模块：M03｜页码：教材P154

支持心源性休克诊断的血流动力学指标是

- **A. CI<2.2、PAWP>18mmHg** ✅
- B. CI>4.0、PAWP<12mmHg
- C. CI<2.2、PAWP<12mmHg
- D. CI正常、PAWP正常
- E. CI>2.5、PAWP>18mmHg

答案：A

> 解析：【正确答案】心源性休克时心脏泵功能衰竭，心脏指数下降至 <2.2L/(m^2・min)，同时左室充盈压升高使肺动脉楔压 >18mmHg；若 PAWP 不高，则休克更可能源于容量不足而非泵衰竭。
>
> 【逐项解析】A. CI<2.2、PAWP>18mmHg 是心源性休克的典型组合。（正确）
> B. CI 升高、PAWP 降低见于高动力或低容量状态。（错误）
> C. CI 低但 PAWP 不高，更像低血容量而非泵衰。（错误）
> D. 指标正常不能诊断休克，本例也未给出 CI 与 PAWP 数值。（错误）
> E. CI>2.5 尚未达到低心排标准；把临界值当诊断值。（错误）
>
> 【易错点】心源性休克记“低泵高压”：CI<2.2、PAWP>18。

---

66. [A1型题｜记忆] batch043-M03-A1-012

> 模块：M03｜页码：教材P155

过敏性休克通常在接触过敏原后多长时间内发生严重反应

- A. 5分钟内
- **B. 15分钟内** ✅
- C. 30分钟内
- D. 1小时内
- E. 24小时内

答案：B

> 解析：【正确答案】过敏性休克在接触过敏原后 15 分钟内即可发生严重反应，重者 10 分钟内死亡，因此必须就地抢救、首选肾上腺素肌内注射，不能等待转运。
>
> 【逐项解析】A. 5 分钟内是部分超急性反应，不是通用时间界值。（错误）
> B. 15 分钟内发生严重反应是教材口径；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 30 分钟已超过典型时间，可能延误识别。（错误）
> D. 1 小时内发生更少见，不符合“休克”的急骤特点。（错误）
> E. 24 小时已属迟发反应，与过敏性休克不符。（错误）
>
> 【易错点】过敏性休克记“15 分钟内、重者 10 分钟死亡”，抢救必须就地。

---

67. [A2型题｜应用] batch043-M03-A2-003

> 模块：M03｜页码：教材P155

女，26 岁，静脉滴注头孢曲松 5 分钟后出现全身荨麻疹、喉头发紧、呼吸困难，血压 70/40mmHg。首选的抢救药物是

- **A. 肾上腺素肌内注射** ✅
- B. 地塞米松静脉推注
- C. 口服氯雷他定
- D. 多巴胺静脉滴注
- E. 碳酸氢钠静脉滴注

答案：A

> 解析：【正确答案】该病人用药后数分钟出现荨麻疹、喉头水肿、呼吸困难与低血压，符合过敏性休克。首选肾上腺素肌内注射，可收缩血管、松弛支气管平滑肌并抑制介质释放；糖皮质激素与抗组胺药起效慢，只能作为辅助。
>
> 【逐项解析】A. 肾上腺素肌内注射是过敏性休克的首选急救药。（正确）
> B. 地塞米松起效慢，不能替代肾上腺素；把激素当首选。（错误）
> C. 口服抗组胺药起效更慢，且休克时吸收差；把轻症用药用于休克。（错误）
> D. 多巴胺可用于升压，但不是过敏性休克的首选。（错误）
> E. 碳酸氢钠不针对过敏机制，可能加重碱中毒。（错误）
>
> 【易错点】过敏性休克第一针永远是肾上腺素肌注，激素与抗组胺是配角。

---

68. [A2型题｜应用] batch043-M03-A2-004

> 模块：M03｜页码：教材P152

男，28 岁，车祸致脾破裂，血压 85/50mmHg，心率 130 次/分，皮肤湿冷。在手术止血前，复苏首选的液体是

- **A. 等渗晶体液** ✅
- B. 5%葡萄糖液
- C. 人血白蛋白
- D. 新鲜全血
- E. 低分子右旋糖酐

答案：A

> 解析：【正确答案】失血性休克在确定性止血前应先快速补充等渗晶体液（如平衡盐溶液）以恢复有效循环血量，同时积极准备输血与手术止血；葡萄糖液不能扩容，白蛋白与全血不是首选起始液体。
>
> 【逐项解析】A. 等渗晶体液是失血性休克起始复苏的首选；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 5% 葡萄糖液迅速分布到细胞内，不能有效扩容。（错误）
> C. 白蛋白价格高、起效不如晶体液快，不作首选。（错误）
> D. 全血需配型，紧急时不能作为第一瓶液体；把输血当起始复苏。（错误）
> E. 右旋糖酐影响凝血与配型，不作首选；把胶体代用品当首选。（错误）
>
> 【易错点】失血性休克第一瓶打晶体液，同时催血、催手术。

---

69. [A3型题｜应用] batch043-M03-A3-003

> 模块：M03｜页码：教材P148

该病人休克的分型最可能是

- **A. 低血容量性休克** ✅
- B. 心源性休克
- C. 感染性休克
- D. 过敏性休克
- E. 神经源性休克

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有明确创伤史、腹腔内出血证据（移动性浊音、穿刺不凝血）及失血性休克表现（面色苍白、皮肤湿冷、脉快、血压下降），属于低血容量性休克；休克分型按病因分为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性五类。
>
> 【逐项解析】A. 腹腔内出血致有效循环血量减少，符合低血容量性休克。（正确）
> B. 心源性休克需有泵衰竭证据，本例为失血；把失血性休克当心源性。（错误）
> C. 感染性休克需感染灶与高排低阻表现，本例无。（错误）
> D. 过敏性休克需过敏原接触与荨麻疹等，本例无。（错误）
> E. 神经源性休克需脊髓损伤致交感张力丧失，本例不符。（错误）
>
> 【易错点】创伤＋腹腔不凝血＋低血压＝低血容量性休克，先止血再谈分型细节。

---

70. [A3型题｜分析] batch043-M03-A3-004

> 模块：M03｜页码：教材P153-154

在快速补液的同时，对该病人最恰当的处理是

- A. 立即静脉推注去甲肾上腺素
- **B. 积极止血并准备急诊手术** ✅
- C. 先静脉滴注碳酸氢钠纠酸
- D. 大量输入5%葡萄糖液
- E. 立即给予呋塞米利尿

答案：B

> 解析：【正确答案】低血容量性休克的治疗关键是补充血容量、控制出血和去除病因。该病人为腹腔内出血，单纯补液只能暂时维持，必须尽快止血（急诊手术）；血管活性药应在充分液体复苏后血压仍不稳定时使用，不能替代止血。
>
> 【逐项解析】A. 升压药不能替代止血，且应在充分复苏后使用。（错误）
> B. 控制出血、去除病因是低血容量性休克治疗的关键。（正确）
> C. 纠酸不是首要，改善灌注后酸中毒多可自行纠正。（错误）
> D. 葡萄糖液不能扩容，反而加重低渗与高血糖。（错误）
> E. 休克时利尿会进一步减少有效循环血量；把少尿当成利尿指征。（错误）
>
> 【易错点】失血性休克两条腿：快补液 + 快止血；升压药与纠酸都排在后面。

---

71. [判断题｜理解] batch043-M03-JUD-002

> 模块：M03｜页码：教材P209-211、P228

MODS 一旦发生即不可避免地进行性加重，属于不可逆的器官衰竭，治疗上应常规使用大剂量糖皮质激素。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】MODS 是严重打击后≥2 个器官序贯发生功能障碍，并非必然不可逆，早期控制原发病、器官支持可使部分病人恢复；治疗重点是控制原发病加器官支持，不常规使用大剂量糖皮质激素。
>
> 【逐项解析】A. MODS 并非必然不可逆，也不常规大剂量激素，原句错误。（错误）
> B. 早期干预可逆，且不常规大剂量激素，故原句错误。（正确）
>
> 【易错点】MODS 记两句：可逆、治原发病＋器官支持；激素不常规大剂量。

---

72. [X型题｜理解] batch043-M03-X-004

> 模块：M03｜页码：教材P152

关于休克的治疗原则，下列叙述正确的有

- **A. 首先稳定生命体征与器官灌注** ✅

- **B. 除心源性休克外以等渗晶体液扩容** ✅
- **C. 充分复苏后血压仍低可用血管活性药** ✅
- D. 休克病人一律立即使用升压药
- **E. 体位取头躯干高20°～30°、下肢高15°～20°** ✅

答案：ABCE

> 解析：【正确答案】休克治疗首先稳定生命体征、保持重要器官微循环灌注并改善细胞代谢，在此基础上病因治疗；除心源性休克外，补液是抗休克的基本治疗，以等渗晶体液为主；血管活性药应在充分液体复苏后血压仍不稳定时使用；体位为头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°。
>
> 【逐项解析】A. 稳定生命体征与器官灌注是休克治疗的首要目标，叙述正确。（正确）
> B. 除心源性休克外，等渗晶体液是基本补液选择，叙述正确。（正确）
> C. 血管活性药在充分复苏后仍低血压时使用，叙述正确。（正确）
> D. 一律立即使用升压药会掩盖容量不足、加重器官缺血，叙述错误。（错误）
> E. 头躯干高 20°～30°、下肢高 15°～20°是标准休克体位，叙述正确。（正确）
>
> 【易错点】休克治疗顺序：稳生命→补晶体液→仍低再加升压药→同时去病因。

M04（26题）

73. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-001

> 模块：M04｜页码：教材P160

口服毒物后，洗胃效果最好的时间窗是

- A. 1小时内
- **B. 4～6小时内** ✅
- C. 12小时内
- D. 24小时内
- E. 48小时内

答案：B

> 解析：【正确答案】口服中毒一般在服毒后 4～6 小时内洗胃效果最好；即使超过 6 小时，部分毒物仍残留于胃内，多数情况下仍需洗胃。洗胃时先抽出全部胃内容物留样，再反复灌洗至回收液清亮无味。
>
> 【逐项解析】A. 1 小时内当然更早，但教材给出的“效果最好”窗口是 4～6 小时。（错误）
> B. 4～6 小时内洗胃效果最好，符合教材；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 12 小时已超过最佳窗口，毒物多已吸收，但仍可能需洗胃。（错误）
> D. 24 小时后洗胃获益明显下降，仅特定情况考虑。（错误）
> E. 48 小时后一般不再常规洗胃，除非有特殊指征。（错误）
>
> 【易错点】洗胃记“4～6 小时最好，超过 6 小时仍可洗”，腐蚀性毒物例外。

---

74. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-002

> 模块：M04｜页码：教材P161

阿片类药物中毒导致呼吸抑制，首选的解毒剂及剂量是

- A. 氟马西尼0.2mg静脉注射
- **B. 纳洛酮0.4～0.8mg静脉注射** ✅
- C. 亚甲蓝1～2mg/kg静脉注射
- D. 碘解磷定1g静脉滴注
- E. 二巯丙醇2.5mg/kg肌内注射

答案：B

> 解析：【正确答案】纳洛酮为阿片受体拮抗剂，对阿片类药物所致的呼吸抑制有特异性拮抗作用，常用 0.4～0.8mg 静脉注射，酌情重复，总量可达 10～20mg。氟马西尼用于苯二氮䓬类，亚甲蓝用于高铁血红蛋白血症。
>
> 【逐项解析】A. 氟马西尼是苯二氮䓬类解毒剂，对阿片受体无效。（错误）
> B. 纳洛酮 0.4～0.8mg 静注，是阿片类中毒呼吸抑制的首选。（正确）
> C. 亚甲蓝用于亚硝酸盐/苯胺所致高铁血红蛋白血症。（错误）
> D. 碘解磷定是胆碱酯酶复活剂，用于有机磷中毒。（错误）
> E. 二巯丙醇用于砷、汞等重金属中毒；把重金属螯合剂套到阿片。（错误）
>
> 【易错点】阿片—纳洛酮，苯二氮䓬—氟马西尼，亚硝酸盐—亚甲蓝，三对不要串。

---

75. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-003

> 模块：M04｜页码：教材P161

亚甲蓝（1～2mg/kg）主要用于下列哪种中毒

- A. 有机磷杀虫剂中毒
- B. 阿片类药物中毒
- **C. 亚硝酸盐所致高铁血红蛋白血症** ✅
- D. 苯二氮䓬类中毒
- E. 急性氰化物中毒

答案：C

> 解析：【正确答案】小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白，是亚硝酸盐、苯胺、硝基苯等高铁血红蛋白生成性毒物中毒的特效解毒药，常用 1% 亚甲蓝 5～10ml（1～2mg/kg）稀释后静脉注射。
>
> 【逐项解析】A. 有机磷中毒用阿托品+胆碱酯酶复活剂，亚甲蓝无效。（错误）
> B. 阿片类中毒用纳洛酮，亚甲蓝无拮抗作用；把亚甲蓝当通用解毒剂。（错误）
> C. 亚甲蓝用于高铁血红蛋白血症，1～2mg/kg 静注，正确。（正确）
> D. 苯二氮䓬类中毒用氟马西尼，不是亚甲蓝；把苯二氮䓬解毒剂记错。（错误）
> E. 氰化物中毒用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法，亚甲蓝不是首选。（错误）
>
> 【易错点】亚甲蓝只认“高铁血红蛋白”：亚硝酸盐、苯胺、硝基苯。

---

76. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-004

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

有机磷杀虫剂中毒时，下列属于毒蕈碱样（M 样）症状的是

- A. 可见肌纤维颤动
- **B. 瞳孔针尖样缩小、大汗、流涎** ✅
- C. 全身肌肉抽搐发作
- D. 血压明显升高者
- E. 出现血红蛋白尿

答案：B

> 解析：【正确答案】有机磷中毒使乙酰胆碱蓄积，M 样症状表现为瞳孔针尖样缩小、大汗淋漓、流涎、支气管分泌物增多等腺体分泌增加和平滑肌痉挛表现；N 样症状为肌纤维颤动、肌无力；中枢症状为抽搐、昏迷。
>
> 【逐项解析】A. 肌纤维颤动是烟碱样（N 样）症状，不是 M 样。（错误）
> B. 瞳孔缩小、大汗、流涎、分泌物增多是典型的 M 样症状。（正确）
> C. 全身抽搐属于中枢神经系统症状，不是 M 样。（错误）
> D. 血压升高不是有机磷中毒的典型 M 样表现，反可因脱水/休克下降。（错误）
> E. 血红蛋白尿见于溶血/挤压伤等，不是有机磷 M 样症状。（错误）
>
> 【易错点】M 样看“腺体+瞳孔”，N 样看“肌肉颤动”，中枢看“抽搐昏迷”。

---

77. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-005

> 模块：M04｜页码：教材P163

有机磷中毒时，血胆碱酯酶活力 40% 提示中毒程度为

- A. 轻度中毒
- **B. 中度中毒** ✅
- C. 重度中毒
- D. 正常
- E. 无法判断

答案：B

> 解析：【正确答案】有机磷中毒按血胆碱酯酶活力分级：轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度小于 30%（正常人为 100%）。40% 落在 30%～50% 区间，属于中度中毒，临床常同时出现 M 样与 N 样症状。
>
> 【逐项解析】A. 轻度中毒胆碱酯酶活力为 50%～70%，40% 已低于该区间。（错误）
> B. 30%～50% 为中度中毒，40% 正在此区间。（正确）
> C. 重度中毒胆碱酯酶活力小于 30%，40% 尚未达到。（错误）
> D. 正常人胆碱酯酶活力为 100%，40% 明显降低。（错误）
> E. 胆碱酯酶活力结合接触史与症状可以分级，并非无法判断。（错误）
>
> 【易错点】胆碱酯酶分级记“50/30”：轻度 50～70、中度 30～50、重度<30。

---

78. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-006

> 模块：M04｜页码：教材P163

有机磷中毒的中间综合征通常在急性中毒后多长时间发病

- A. 数分钟内
- **B. 1～4日** ✅
- C. 2周
- D. 1个月
- E. 3个月

答案：B

> 解析：【正确答案】中间综合征常发生于急性有机磷中毒后 1～4 日，个别病例可在第 7 日发病，表现为颈屈肌、四肢近端肌肉及第III～VII、IX～XII对脑神经支配肌肌力减退，累及呼吸肌时可致呼吸肌麻痹、呼吸衰竭。
>
> 【逐项解析】A. 数分钟内发生的是急性胆碱能危象，不是中间综合征。（错误）
> B. 1～4 日（个别第 7 日）是中间综合征的典型时间窗。（正确）
> C. 2 周已超过中间综合征的常见窗口，更接近迟发性神经病。（错误）
> D. 1 个月不符合中间综合征，应考虑迟发性神经病。（错误）
> E. 3 个月更不符合，中间综合征是急性中毒后的早期并发症。（错误）
>
> 【易错点】中间综合征记“1～4 日、个别第 7 日”，与迟发性神经病（2～3 周后）区分。

---

79. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-007

> 模块：M04｜页码：教材P158

下列中毒最可能出现瞳孔针尖样缩小的是

- A. 阿托品中毒
- B. 甲醇中毒
- **C. 有机磷杀虫剂中毒** ✅
- D. 氰化物中毒
- E. 乙醇中毒

答案：C

> 解析：【正确答案】瞳孔缩小常见于有机磷、阿片类、镇静催眠药及氨基甲酸酯类中毒；瞳孔扩大常见于阿托品、莨菪碱、甲醇、乙醇、大麻、苯、氰化物等中毒。有机磷中毒的针尖样瞳孔是其特征性体征之一。
>
> 【逐项解析】A. 阿托品阻断 M 受体，瞳孔扩大而不是缩小。（错误）
> B. 甲醇中毒瞳孔扩大，不是缩小；把扩大类毒物混入缩小类。（错误）
> C. 有机磷中毒典型表现为瞳孔针尖样缩小，正确。（正确）
> D. 氰化物中毒瞳孔扩大，不是缩小；把扩大类毒物混入缩小类。（错误）
> E. 乙醇中毒瞳孔扩大，不是缩小；把扩大类毒物混入缩小类。（错误）
>
> 【易错点】瞳孔缩小记“有机磷、阿片、镇静催眠”；扩大记“阿托品、甲醇、乙醇、氰化物”。

---

80. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-008

> 模块：M04｜页码：教材P160、P176

关于一氧化碳中毒迟发性脑病，下列叙述正确的是

- **A. 高压氧可减少迟发性脑病的发生** ✅
- B. 迟发性脑病只在轻度中毒后出现
- C. COHb降至20%即停氧
- D. 迟发性脑病由高铁血红蛋白引起
- E. 首选亚甲蓝治疗

答案：A

> 解析：【正确答案】高压氧能加速碳氧血红蛋白解离、缩短昏迷时间和病程，可减少迟发性脑病的发生；血液碳氧血红蛋白降至 5% 时可停止吸氧。迟发性脑病多见于中重度中毒、昏迷时间长者，与白质脱髓鞘等有关，不是高铁血红蛋白血症，亚甲蓝无效。
>
> 【逐项解析】A. 高压氧可减少迟发性脑病发生，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 迟发性脑病多见于中重度中毒、昏迷时间长者，不是只见于轻度。（错误）
> C. COHb 降至 5% 才可停氧，20% 仍偏高。（错误）
> D. 迟发性脑病与白质脱髓鞘、再灌注损伤有关，不是高铁血红蛋白。（错误）
> E. 亚甲蓝用于高铁血红蛋白血症，对 CO 中毒无效。（错误）
>
> 【易错点】CO 中毒记“高压氧防迟发、COHb 5% 停氧、24～48 小时脑水肿高峰”。

---

81. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-009

> 模块：M04｜页码：教材P160、P176

急性中毒病人昏迷、呼吸浅慢，洗胃前最重要的处理是

- A. 立即插胃管洗胃
- **B. 先保护气道，必要时气管插管** ✅
- C. 先给特效解毒剂
- D. 先立即导泻处理
- E. 先抽血查毒物浓度

答案：B

> 解析：【正确答案】昏迷、惊厥病人洗胃时极易误吸，必须先保护呼吸道：头偏向一侧、吸引分泌物、放置口咽通气道，必要时气管插管；昏迷、窒息或呼吸停止者应及时气管内插管、机械通气，然后再洗胃。
>
> 【逐项解析】A. 未保护气道就洗胃，误吸风险极高，可致窒息或吸入性肺炎。（错误）
> B. 先保护气道、必要时插管，是昏迷中毒病人洗胃前的关键。（正确）
> C. 解毒剂重要，但不能替代气道保护，且部分解毒剂需按中毒类型选择。（错误）
> D. 导泻在洗胃后进行，不能解决气道风险；把后续步骤提前。（错误）
> E. 毒物浓度检测不改变急诊处理顺序，不能因等结果延误气道。（错误）
>
> 【易错点】中毒昏迷顺序：先气道（侧位/口咽通气道/插管），再洗胃。

---

82. [A2型题｜应用] batch043-M04-A2-001

> 模块：M04｜页码：教材P163、P176

女，31 岁，口服有机磷农药后经洗胃、碘解磷定及阿托品治疗症状缓解，24 小时后再次出现呼吸困难。查体：呼吸浅慢，昏迷，皮肤湿冷，瞳孔针尖样，双肺湿啰音，心率 50～60 次/分。最恰当的急诊处理是

- **A. 立即气管插管机械通气，然后给予解毒剂** ✅
- B. 立即解毒、导泻，必要时再插管
- C. 立即解毒、重复洗胃，必要时再插管
- D. 立即气管插管，强心、利尿
- E. 立即呼吸兴奋剂+解毒治疗

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有机磷中毒后 24 小时出现呼吸浅慢、昏迷、瞳孔针尖样，符合中间综合征并呼吸肌麻痹，首要处理是立即气管插管机械通气纠正缺氧，再继续解毒治疗；等待解毒剂起效或使用呼吸兴奋剂都会延误通气。
>
> 【逐项解析】A. 先插管机械通气纠正缺氧，再给解毒剂，符合中间综合征呼吸肌麻痹的处理。（正确）
> B. 呼吸已浅慢、昏迷，必须先建立气道，不能等待解毒剂起效。（错误）
> C. 重复洗胃不能解决呼吸肌麻痹，且未先保护气道。（错误）
> D. 强心、利尿不是中间综合征的核心处理，缺氧未纠正前无益。（错误）
> E. 呼吸兴奋剂不能替代机械通气，且可增加氧耗。（错误）
>
> 【易错点】中间综合征呼吸肌麻痹：先插管通气，再解毒；呼吸兴奋剂不顶用。

---

83. [A2型题｜应用] batch043-M04-A2-002

> 模块：M04｜页码：教材P159-160

对危重急性中毒病人，到达急诊后应立即采取的措施是

- **A. 维持生命体征并终止毒物接触** ✅
- B. 立即洗胃，迅速排出消化道毒物
- C. 立即导泻，排出体内毒物
- D. 立即吸氧保护脑组织
- E. 立即使用特效解毒药

答案：A

> 解析：【正确答案】急性中毒的总原则是优先稳定生命体征、终止与毒物接触，然后再清除毒物、使用特效解毒剂和支持治疗。洗胃、导泻、吸氧、解毒药都重要，但都必须建立在生命体征稳定与脱离毒物接触的基础上。
>
> 【逐项解析】A. 先稳定生命体征并终止毒物接触，符合中毒总原则。（正确）
> B. 洗胃是清除毒物的手段，但应在稳定生命体征、保护气道之后。（错误）
> C. 导泻在洗胃后进行，不能作为首要措施；把后续步骤提前。（错误）
> D. 吸氧是支持治疗的一部分，不能替代整体复苏与脱离毒物。（错误）
> E. 特效解毒药需先识别毒物，且不能替代生命体征支持。（错误）
>
> 【易错点】中毒急救顺序：先保命、脱离毒物，再清除、解毒。

84. [A2型题｜应用] batch043-M04-A2-003

> 模块：M04｜页码：教材P168-170

某小学 47 名学生进食课间餐后 1～6 小时相继出现呕吐、上腹剧痛、腹泻，少数低热，未进食者不发病。针对该起食物中毒，主要的治疗措施是

- A. 应用多价抗毒素血清
- B. 服用改变肠道菌群的制剂
- C. 应用强效止痛药物治疗
- D. 彻底洗胃及清洁灌肠
- **E. 静脉补充水、电解质，静脉输注抗生素** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】该事件符合细菌性食物中毒：潜伏期短（1～6 小时）、群体发病、与共同进食史明确相关。治疗以补液、纠正水电解质紊乱为主，必要时静脉输注抗生素；多价抗毒素主要用于肉毒杆菌中毒，洗胃灌肠并非所有食物中毒的首选。
>
> 【逐项解析】A. 多价抗毒素主要用于肉毒杆菌中毒，本例无肉毒中毒线索。（错误）
> B. 调节肠道菌群制剂不是急性食物中毒的主要治疗。（错误）
> C. 止痛剂只能缓解症状，不能纠正脱水与感染。（错误）
> D. 彻底洗胃、灌肠适用于部分经口中毒，但不是本病主要治疗。（错误）
> E. 补液纠正水电解质紊乱、必要时抗生素，是细菌性食物中毒的主要治疗。（正确）
>
> 【易错点】食物中毒治疗以补液为主，抗毒素只对肉毒；洗胃不是人人都做。

---

85. [A3型题｜应用] batch043-M04-A3-001

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

该病人最可能的中毒是

- **A. 有机磷杀虫剂中毒** ✅
- B. 阿托品中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 苯二氮䓬类中毒
- E. 亚硝酸盐中毒

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有农药接触史，出现瞳孔针尖样缩小、大汗、流涎、支气管分泌物增多等 M 样症状，伴肌纤维颤动这一 N 样症状，呼出气有蒜味，符合有机磷杀虫剂中毒的典型表现。
>
> 【逐项解析】A. 接触农药+针尖瞳+大汗+蒜味+肌颤，符合有机磷中毒。（正确）
> B. 阿托品中毒表现为瞳孔扩大、皮肤干燥潮红、心率快，与本例相反。（错误）
> C. CO 中毒多无针尖瞳与蒜味，皮肤可呈樱桃红。（错误）
> D. 苯二氮䓬类中毒以中枢抑制为主，无蒜味与肌颤。（错误）
> E. 亚硝酸盐中毒表现为发绀、高铁血红蛋白升高，无针尖瞳与蒜味。（错误）
>
> 【易错点】针尖瞳+大汗+蒜味+肌颤，四条凑齐就是有机磷。

---

86. [A3型题｜分析] batch043-M04-A3-002

> 模块：M04｜页码：教材P161、P164

该病人的特效解毒治疗应选择

- **A. 阿托品+胆碱酯酶复活剂** ✅
- B. 纳洛酮+氟马西尼
- C. 亚甲蓝+维生素C
- D. 二巯丙醇+依地酸钙钠
- E. 肾上腺素+糖皮质激素

答案：A

> 解析：【正确答案】有机磷中毒的特效解毒包括抗胆碱药阿托品（解除 M 样症状及呼吸中枢抑制）与胆碱酯酶复活剂（氯解磷定/碘解磷定，解除 N 样症状、恢复胆碱酯酶活力），二者联合、早期、足量、重复使用。
>
> 【逐项解析】A. 阿托品解 M 样、复活剂解 N 样，联合使用是有机磷中毒的标准解毒方案。（正确）
> B. 纳洛酮用于阿片类、氟马西尼用于苯二氮䓬类，对有机磷无效。（错误）
> C. 亚甲蓝用于高铁血红蛋白血症，维生素 C 不是有机磷特效解毒。（错误）
> D. 二巯丙醇/依地酸钙钠用于重金属中毒，对有机磷无效。（错误）
> E. 肾上腺素/激素用于过敏性休克，不是有机磷解毒。（错误）
>
> 【易错点】有机磷解毒记“阿托品管 M、复活剂管 N”，两药联合。

87. [判断题｜理解] batch043-M04-JUD-001

> 模块：M04｜页码：教材P160

吞服强酸、强碱等腐蚀性毒物后，应尽快插胃管洗胃，以减少毒物吸收。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】吞服腐蚀性毒物不宜洗胃，也不宜催吐：洗胃管可能加重食管、胃黏膜损伤，甚至导致穿孔。此类病人应以稳定生命体征、保护消化道黏膜、避免进一步损伤为主。
>
> 【逐项解析】A. 腐蚀性毒物洗胃可致穿孔，原句错误；把通用洗胃原则套到腐蚀性毒物。（错误）
> B. 腐蚀性毒物禁洗胃，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】洗胃禁忌记“腐蚀性毒物不洗、不催吐”。

---

88. [X型题｜理解] batch043-M04-X-001

> 模块：M04｜页码：教材P161

下列毒物与特效解毒剂的配对，正确的有

- **A. 有机磷—阿托品+碘解磷定** ✅
- **B. 阿片类—纳洛酮** ✅
- **C. 苯二氮䓬类—氟马西尼** ✅
- **D. 亚硝酸盐—亚甲蓝** ✅
- E. 氰化物—二巯丙醇

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】有机磷用阿托品+胆碱酯酶复活剂；阿片类用纳洛酮；苯二氮䓬类用氟马西尼；亚硝酸盐所致高铁血红蛋白血症用亚甲蓝。氰化物中毒采用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法，二巯丙醇用于砷、汞等重金属中毒。
>
> 【逐项解析】A. 有机磷—阿托品+碘解磷定，配对正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 阿片类—纳洛酮，配对正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 苯二氮䓬类—氟马西尼，配对正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 亚硝酸盐—亚甲蓝，配对正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 氰化物应用亚硝酸盐-硫代硫酸钠，二巯丙醇用于砷汞，配对错误。（错误）
>
> 【易错点】五对解毒剂要成组背，尤其别把氰化物与重金属的解毒剂互换。

---

89. [A1型题｜理解] batch043-M04-A1-010

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

有机磷中毒病人出现肌纤维颤动，应在阿托品基础上加用的药物是

- **A. 碘解磷定** ✅
- B. 纳洛酮
- C. 氟马西尼
- D. 亚甲蓝
- E. 依地酸钙钠

答案：A

> 解析：【正确答案】有机磷中毒的 M 样症状用阿托品拮抗，而肌纤维颤动属于 N 样症状，是乙酰胆碱在神经肌肉接头蓄积所致，需用胆碱酯酶复活剂（碘解磷定、氯解磷定）恢复胆碱酯酶活性，单纯加大阿托品无效。
>
> 【逐项解析】A. 碘解磷定是胆碱酯酶复活剂，针对 N 样症状。（正确）
> B. 纳洛酮用于阿片类中毒，不针对有机磷；把阿片解毒剂套过来。（错误）
> C. 氟马西尼用于苯二氮䓬类中毒；把镇静催眠药解毒剂套过来。（错误）
> D. 亚甲蓝用于亚硝酸盐或苯胺中毒；把高铁血红蛋白解毒剂套过来。（错误）
> E. 依地酸钙钠用于铅中毒；把金属络合剂套过来。（错误）
>
> 【易错点】有机磷双管齐下：阿托品管 M 样，碘解磷定管 N 样（肌颤）。

---

90. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-011

> 模块：M04｜页码：教材P161

氰化物中毒的特异性解毒方案是

- **A. 亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法** ✅
- B. 阿托品-碘解磷定疗法
- C. 纳洛酮静脉注射
- D. 亚甲蓝1～2mg/kg
- E. 依地酸钙钠静滴

答案：A

> 解析：【正确答案】氰化物中毒采用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法：亚硝酸盐使血红蛋白氧化为高铁血红蛋白，与氰离子结合形成氰化高铁血红蛋白；硫代硫酸钠再提供硫，使氰离子转为低毒的硫氰酸盐排出。
>
> 【逐项解析】A. 亚硝酸盐-硫代硫酸钠是氰化物中毒的标准解毒方案。（正确）
> B. 阿托品-碘解磷定是有机磷中毒的方案；把有机磷方案套过来。（错误）
> C. 纳洛酮用于阿片类中毒；把阿片拮抗剂套过来。（错误）
> D. 亚甲蓝用于亚硝酸盐或苯胺中毒；把亚甲蓝当通用解毒剂。（错误）
> E. 依地酸钙钠用于铅中毒；把金属络合剂套过来。（错误）
>
> 【易错点】氰化物记“亚硝酸盐拉高铁、硫代硫酸钠给硫”，两步缺一不可。

---

91. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-012

> 模块：M04｜页码：教材P161

铅中毒的特异性解毒剂是

- **A. 依地酸钙钠** ✅
- B. 二巯丙醇
- C. 亚甲蓝
- D. 氟马西尼
- E. 纳洛酮

答案：A

> 解析：【正确答案】铅中毒选用依地酸钙钠等金属络合剂，与铅形成可溶性络合物经肾排出；二巯丙醇主要用于砷、汞中毒。两者不可互换，选错络合剂不仅无效，还会增加肾毒性。
>
> 【逐项解析】A. 依地酸钙钠是铅中毒的首选络合剂；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 二巯丙醇主要用于砷、汞中毒；把砷汞解毒剂套给铅。（错误）
> C. 亚甲蓝用于亚硝酸盐或苯胺中毒；把氧化还原剂当络合剂。（错误）
> D. 氟马西尼用于苯二氮䓬类中毒；把受体拮抗剂当络合剂。（错误）
> E. 纳洛酮用于阿片类中毒；把阿片拮抗剂当络合剂。（错误）
>
> 【易错点】金属中毒配对：铅—依地酸钙钠；砷汞—二巯丙醇。

---

92. [A1型题｜记忆] batch043-M04-A1-013

> 模块：M04｜页码：教材P160、P176

一氧化碳中毒病人吸氧应持续至血液碳氧血红蛋白降至

- A. 15%
- B. 10%
- **C. 5%** ✅
- D. 2%
- E. 正常范围

答案：C

> 解析：【正确答案】一氧化碳中毒应持续吸氧，直至血液碳氧血红蛋白降至 5% 可停止吸氧；高压氧能加速碳氧血红蛋白解离、减少迟发性脑病发生，重症病人应尽早使用。
>
> 【逐项解析】A. 15% 仍明显高于正常，不能停氧；把中毒水平当停氧线。（错误）
> B. 10% 仍偏高，迟发性脑病风险未消除；把安全上限当停氧线。（错误）
> C. 碳氧血红蛋白降至 5% 可停止吸氧；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 2% 已接近正常，但教材停氧线是 5%。（错误）
> E. “正常范围”过于模糊，无法执行；用模糊表述替代数值。（错误）
>
> 【易错点】CO 中毒停氧看 5%，重症尽早高压氧防迟发脑病。

---

93. [A2型题｜应用] batch043-M04-A2-004

> 模块：M04｜页码：教材P160、P176

男，45 岁，冬季在密闭房间用煤炉取暖，晨起被发现意识模糊、头痛、恶心，皮肤黏膜呈樱桃红色，血碳氧血红蛋白 35%。最恰当的处理是

- **A. 立即撤离现场并高流量吸氧** ✅
- B. 立即静脉注射纳洛酮
- C. 立即插胃管洗胃
- D. 立即静脉注射亚甲蓝
- E. 立即行血液透析

答案：A

> 解析：【正确答案】该病人有密闭煤炉接触史、樱桃红色皮肤黏膜与碳氧血红蛋白升高，符合一氧化碳中毒。首要处理是立即脱离现场、保持呼吸道通畅并给予高流量吸氧，重症尽早高压氧，以减少迟发性脑病。
>
> 【逐项解析】A. 脱离现场加高流量吸氧是一氧化碳中毒的首要处理。（正确）
> B. 纳洛酮用于阿片类中毒，对 CO 无效；把昏迷一律当阿片中毒。（错误）
> C. CO 经肺排出，洗胃无意义；把吸入中毒当口服中毒。（错误）
> D. 亚甲蓝用于亚硝酸盐或苯胺中毒；把高铁血红蛋白血症的解毒剂套过来。（错误）
> E. 血液透析不能有效清除 CO；把透析当通用解毒。（错误）
>
> 【易错点】CO 中毒三步：脱离现场→高流量吸氧→重症高压氧。

---

94. [A3型题｜应用] batch043-M04-A3-003

> 模块：M04｜页码：教材P161

该病人最可能的中毒药物是

- **A. 苯二氮䓬类** ✅
- B. 有机磷中毒
- C. 阿片类中毒
- D. 甲醇中毒
- E. 氰化物中毒

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有明确的地西泮服药史，表现为昏迷、呼吸抑制、瞳孔缩小而对光反射存在，符合苯二氮䓬类中毒；有机磷中毒会有大汗、流涎、支气管分泌物增多与肌纤维颤动，阿片类中毒则呼吸抑制更深、瞳孔针尖样且常有低血压。
>
> 【逐项解析】A. 明确的地西泮服药史加昏迷、呼吸抑制，符合苯二氮䓬类中毒。（正确）
> B. 有机磷中毒应有大汗、流涎、肌纤维颤动，本例无。（错误）
> C. 阿片类中毒瞳孔更小、呼吸抑制更重，且无服药史。（错误）
> D. 甲醇中毒以代谢性酸中毒、视神经损害为主。（错误）
> E. 氰化物中毒起病极快，皮肤呈樱桃红、呼出气苦杏仁味。（错误）
>
> 【易错点】镇静催眠药中毒：昏迷＋呼吸抑制＋瞳孔缩小，但有明确服药史。

---

95. [A3型题｜应用] batch043-M04-A3-004

> 模块：M04｜页码：教材P161

在保持气道通畅、辅助通气的基础上，应选用的拮抗剂是

- **A. 氟马西尼0.2mg静脉注射** ✅
- B. 纳洛酮0.4mg静脉注射
- C. 阿托品1mg静脉注射
- D. 亚甲蓝1mg/kg静脉注射
- E. 碘解磷定0.5g静脉滴注

答案：A

> 解析：【正确答案】苯二氮䓬类中毒的特异性拮抗剂是氟马西尼，首剂 0.2mg 静脉注射，总量可达 2mg；但它可诱发癫痫与戒断反应，长期服用苯二氮䓬类或有癫痫史者应慎用，且不能替代气道保护与通气支持。
>
> 【逐项解析】A. 氟马西尼是苯二氮䓬类受体拮抗剂，首剂 0.2mg 静注。（正确）
> B. 纳洛酮拮抗阿片类，对地西泮无效；把阿片拮抗剂套过来。（错误）
> C. 阿托品用于有机磷中毒的 M 样症状；把抗胆碱药当拮抗剂。（错误）
> D. 亚甲蓝用于亚硝酸盐或苯胺中毒；把氧化还原剂当拮抗剂。（错误）
> E. 碘解磷定是胆碱酯酶复活剂，用于有机磷中毒。（错误）
>
> 【易错点】苯二氮䓬→氟马西尼 0.2mg；阿片→纳洛酮 0.4mg，两个剂量别串。

---

96. [判断题｜理解] batch043-M04-JUD-002

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

有机磷中毒病人出现肌纤维颤动时，说明阿托品剂量不足，应首先加大阿托品用量。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】肌纤维颤动属于 N 样症状，是乙酰胆碱在神经肌肉接头蓄积所致，阿托品只拮抗 M 样症状，对 N 样症状无效；应加用胆碱酯酶复活剂（碘解磷定、氯解磷定），而不是单纯加大阿托品。
>
> 【逐项解析】A. 肌颤是 N 样症状，阿托品无效，原句错误。（错误）
> B. 应加用胆碱酯酶复活剂，故原句错误；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
>
> 【易错点】肌颤＝N 样＝复活剂；大汗流涎＝M 样＝阿托品。

---

97. [X型题｜理解] batch043-M04-X-002

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

关于有机磷中毒的临床表现与分级，下列叙述正确的有

- **A. M样症状可见瞳孔针尖样缩小** ✅
- **B. N样症状表现为肌纤维颤动** ✅
- **C. 呼出气可有蒜味** ✅
- **D. 胆碱酯酶活力越低病情越重** ✅
- E. 阿托品可消除肌纤维颤动

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】有机磷中毒抑制胆碱酯酶，乙酰胆碱蓄积产生 M 样症状（瞳孔针尖样缩小、大汗、流涎、支气管分泌物增多）、N 样症状（肌纤维颤动）与中枢症状，呼出气有蒜味；血胆碱酯酶活力轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度 <30%，活力越低病情越重。阿托品只拮抗 M 样症状，不能消除肌纤维颤动。
>
> 【逐项解析】A. 瞳孔针尖样缩小是典型 M 样症状，叙述正确。（正确）
> B. 肌纤维颤动是 N 样症状，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 呼出气蒜味是有机磷中毒的特征，叙述正确。（正确）
> D. 胆碱酯酶活力越低，病情越重，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 阿托品不能消除肌颤，需用复活剂，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】有机磷三件套：M 样（阿托品）、N 样（复活剂）、蒜味（提示线索）。

---

98. [X型题｜理解] batch043-M04-X-003

> 模块：M04｜页码：教材P159-160

关于急性口服中毒的洗胃，下列叙述正确的有

- **A. 口服中毒4～6小时内洗胃效果最好** ✅
- **B. 吞服腐蚀性毒物不宜洗胃** ✅
- **C. 昏迷者洗胃须保护呼吸道** ✅
- **D. 洗胃时头偏向一侧防误吸** ✅
- E. 腐蚀性毒物应大量清水反复洗胃

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】口服中毒在 4～6 小时内洗胃效果最好；吞服腐蚀性毒物不宜洗胃，以免加重食管与胃穿孔；昏迷、惊厥者洗胃必须先保护呼吸道、头偏向一侧，防止误吸。腐蚀性毒物大量清水洗胃是禁忌，不是常规。
>
> 【逐项解析】A. 4～6 小时内洗胃效果最好，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 腐蚀性毒物洗胃可致穿孔，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 昏迷者洗胃须先保护呼吸道，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 头偏向一侧可减少误吸，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 腐蚀性毒物大量清水洗胃会加重损伤，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】洗胃记“4～6 小时、腐蚀禁洗、昏迷先护气道”。

M05（32题）

99. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-001

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

关于中暑分级与体温，下列对应正确的是

- A. 先兆>38℃，轻症≤38℃
- **B. 先兆≤38℃，轻症>38℃** ✅
- C. 热射病体温一般不超过40℃
- D. 热痉挛体温必须超过40.5℃
- E. 轻症中暑体温正常

答案：B

> 解析：【正确答案】中暑按轻重分为先兆、轻症、重症（热痉挛、热衰竭、热射病）。先兆中暑体温正常或略高、不超过 38℃；轻症中暑体温一般超过 38℃；热射病核心体温超过 40.5℃。
>
> 【逐项解析】A. 先兆与轻症的体温界值被对调，先兆不应超过 38℃。（错误）
> B. 先兆≤38℃、轻症>38℃，与教材一致。（正确）
> C. 热射病核心体温超过 40.5℃，不是不超过 40℃。（错误）
> D. 热痉挛体温一般正常，不需要超过 40.5℃。（错误）
> E. 轻症中暑体温一般超过 38℃，不是正常。（错误）
>
> 【易错点】中暑体温记“三八线”：先兆≤38、轻症>38、热射病>40.5。

---

100. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-002

> 模块：M05｜页码：教材P178

先兆中暑的典型表现是

- A. 高热、无汗、意识障碍
- **B. 口渴乏力多汗头晕，体温≤38℃** ✅
- C. 腓肠肌对称性痉挛，体温正常
- D. 面色苍白、血压下降、晕厥
- E. 皮肤干热、体温超过40.5℃

答案：B

> 解析：【正确答案】先兆中暑表现为口渴、乏力、多汗、头晕、目眩、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中，体温正常或略高、不超过 38℃；及时脱离高温环境、补充淡盐水多可迅速缓解。
>
> 【逐项解析】A. 高热、无汗、意识障碍是热射病表现，不是先兆。（错误）
> B. 口渴、乏力、多汗、头晕、心悸且体温≤38℃，符合先兆中暑。（正确）
> C. 腓肠肌痉挛是热痉挛的特点，属于重症中暑。（错误）
> D. 面色苍白、血压下降、晕厥是热衰竭表现；把热衰竭当成先兆。（错误）
> E. 皮肤干热、体温>40.5℃是热射病表现。（错误）
>
> 【易错点】先兆中暑记“症状一大堆、体温不过 38”。

---

101. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-003

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

轻症中暑与先兆中暑的主要区别是

- **A. 循环紊乱，体温>38℃** ✅
- B. 轻症体温一定超过40.5℃
- C. 轻症必然出现昏迷
- D. 轻症无汗表现
- E. 轻症不需要处理即可自愈

答案：A

> 解析：【正确答案】轻症中暑在先兆症状基础上出现早期循环功能紊乱：面色潮红或苍白、烦躁或淡漠、恶心呕吐、大汗、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低、心率加快，体温一般超过 38℃；及时处理常于数小时内恢复。
>
> 【逐项解析】A. 轻症出现循环功能紊乱且体温一般超过 38℃，是与先兆的关键区别。（正确）
> B. 超过 40.5℃是热射病，不是轻症；把热射病体温套到轻症。（错误）
> C. 昏迷属于重症中暑，轻症意识清楚；把重症表现套到轻症。（错误）
> D. 轻症常大汗淋漓，不是无汗；无汗见于热射病。（错误）
> E. 轻症需要补液、降温等处理，不能放任不管。（错误）
>
> 【易错点】先兆→轻症的分水岭是“循环紊乱+体温>38”。

---

102. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-004

> 模块：M05｜页码：教材P179

热射病的典型表现是

- **A. 高热、无汗、意识障碍** ✅
- B. 大汗、抽搐、体温正常
- C. 面色苍白、血压下降、体温38.5℃
- D. 腓肠肌痉挛、意识清楚
- E. 低热、皮疹、关节痛

答案：A

> 解析：【正确答案】热射病是中暑最严重的类型，典型表现为高热、无汗、意识障碍，核心体温超过 40.5℃；严重者可出现休克、心力衰竭、脑水肿、ARDS、急性肾损伤、DIC 甚至 MODS。
>
> 【逐项解析】A. 高热、无汗、意识障碍是热射病典型三联，正确。（正确）
> B. 大汗与体温正常不符合热射病，热射病常无汗且高热。（错误）
> C. 面色苍白、血压下降、38.5℃更像热衰竭。（错误）
> D. 腓肠肌痉挛、意识清楚是热痉挛特点；把热痉挛当成热射病。（错误）
> E. 低热、皮疹、关节痛不是热射病表现；用感染/过敏表现替代。（错误）
>
> 【易错点】热射病记“高热+无汗+昏迷”，体温>40.5℃。

---

103. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-005

> 模块：M05｜页码：教材P179

热射病快速降温的目标是

- A. 30分钟到38℃，1小时到37℃
- **B. 10～40分<39℃，2h<38.5** ✅
- C. 2小时<39℃，6小时<38℃
- D. 4小时内降至38.5℃以下
- E. 降至正常体温以下时

答案：B

> 解析：【正确答案】热射病降温目标为核心体温在 10～40 分钟内迅速降至 39°C以下、2 小时内降至 38.5°C以下，达到正常体温时停止降温，避免体温过低。降温速度直接关系病死率。
>
> 【逐项解析】A. 目标过于激进，正常体温即可，不需要降到 37°C。（错误）
> B. 10～40 分钟到 39°C以下、2 小时到 38.5°C以下，与教材一致。（正确）
> C. 时间窗过宽，2 小时才到 39°C会显著增加病死率。（错误）
> D. 4 小时才到 38.5°C过慢，错过最佳窗口。（错误）
> E. 降到正常体温即应停止，不能降到正常以下。（错误）
>
> 【易错点】热射病降温记“10～40 分钟到 39、2 小时到 38.5”。

---

104. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-006

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

重度淹溺病人的体温常低于多少，复温的初始目标是多少

- A. 低于32°C，复温到37°C
- **B. 低于30°C，复温到34°C** ✅
- C. 低于35°C，复温到36°C
- D. 低于28°C，复温到32°C
- E. 低于36°C，复温到38°C

答案：B

> 解析：【正确答案】重度淹溺病人体温常低于 30°C；为减少脑及肺的再灌注损伤，建议初始复温到 34°C，经过 24 小时温和的低体温治疗后再恢复到正常体温。复温不宜过快。
>
> 【逐项解析】A. 重度淹溺体温常低于 30°C而非 32°C，初始复温目标是 34°C。（错误）
> B. 低于 30°C、初始复温 34°C，符合教材。（正确）
> C. 低于 35°C不够低，初始复温 36°C也不是推荐目标。（错误）
> D. 低于 28°C过于极端，复温到 32°C不符合推荐。（错误）
> E. 低于 36°C范围过宽，复温到 38°C会加重再灌注损伤。（错误）
>
> 【易错点】淹溺复温记“30 以下、先到 34、24 小时温和”。

---

105. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-007

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

溺水者被救上岸后，现场急救的首要措施是

- A. 倒挂控水，排出胃内积水
- **B. 清口鼻、开气道、通气/按压** ✅
- C. 先脱去湿衣、擦干身体
- D. 立即大量喂水冲咽
- E. 先送医院再处理

答案：B

> 解析：【正确答案】淹溺的核心病理是窒息缺氧，现场应立即清除口鼻泥沙异物、开放气道，给予人工呼吸和胸外按压，并注意保温；不常规倒挂控水，因为控水会延误通气、增加误吸。
>
> 【逐项解析】A. 倒挂控水会延误通气、增加误吸，不推荐作为首要措施。（错误）
> B. 清口鼻、开气道、人工呼吸/按压，是溺水现场的首要措施。（正确）
> C. 脱衣擦干属于保温措施，应在气道与复苏之后或同时进行。（错误）
> D. 喂水会加重误吸，昏迷者禁忌；用土办法处理溺水。（错误）
> E. 先送医院会错过黄金抢救时间，现场应立即复苏。（错误）
>
> 【易错点】溺水现场记“清口鼻—开气道—通气/按压—保温”，不倒挂控水。

---

106. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-008

> 模块：M05｜页码：教材P189

发现有人触电倒地，现场急救的第一步是

- A. 立即用手拉开病人
- **B. 切断电源或用绝缘物挑开电线** ✅
- C. 立即行心肺复苏
- D. 立即给病人喂水
- E. 立即搬动病人身体

答案：B

> 解析：【正确答案】电击伤现场急救的第一步是立即切断电源或用绝缘物挑开电线，确保施救者与病人脱离电源后再判断意识、呼吸、脉搏并开始心肺复苏；未断电直接接触病人会使施救者一同触电。
>
> 【逐项解析】A. 用手直接拉拽会使施救者一同触电，绝对禁止。（错误）
> B. 先断电或用绝缘物挑开电线，是电击伤现场的第一步。（正确）
> C. 心肺复苏很重要，但必须先脱离电源，否则施救者也会触电。（错误）
> D. 喂水与电击急救无关，昏迷者还会误吸；用无关措施替代。（错误）
> E. 未断电搬动病人不能消除触电风险；把搬运当成断电。（错误）
>
> 【易错点】电击急救顺序：先断电，再碰人，再 CPR。

---

107. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-009

> 模块：M05｜页码：教材P189

电线落地时，人与落地点应保持的安全距离是

- A. 室内1m、室外2m
- B. 室内2m、室外4m
- **C. 室内4m、室外8m** ✅
- D. 室内8m、室外16m
- E. 无需保持距离

答案：C

> 解析：【正确答案】电线落地时会形成跨步电压，人与落地点应保持室内 4m、室外 8m 以上的安全距离；若已小于该距离，应单脚跳跃或双脚并小步迅速离开不安全区域，进入时穿绝缘鞋。
>
> 【逐项解析】A. 1m/2m 距离不足，跨步电压仍可致触电。（错误）
> B. 2m/4m 仍小于推荐距离；把安全距离减半。（错误）
> C. 室内 4m、室外 8m，符合教材；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 8m/16m 过度保守，不是教材推荐值。（错误）
> E. 跨步电压确实存在，必须保持距离；忽视跨步电压风险。（错误）
>
> 【易错点】跨步电压记“室内四米、室外八米”，小于则单脚跳离。

---

108. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-010

> 模块：M05｜页码：教材P187、P309

关于烧烫伤的现场冷疗，下列叙述正确的是

- A. 所有烧伤均应长时间冰敷
- **B. Ⅰ～Ⅱ度冷疗，Ⅲ度/大面积不必** ✅
- C. 烧伤后应立即涂抹牙膏、酱油
- D. 水疱应刺破后冷疗
- E. 冷疗后立即用油脂包扎

答案：B

> 解析：【正确答案】Ⅰ～Ⅱ度中小面积烧烫伤可立即用冷水连续冲洗或浸泡，以降低皮肤温度、减轻热力继续损伤；Ⅲ度及大面积烧伤不必冷疗，以免低体温加重休克。不应涂油脂/药膏、不刺破水疱，用清洁敷料覆盖。
>
> 【逐项解析】A. 长时间冰敷可致低体温与血管收缩，不是所有烧伤都适用。（错误）
> B. Ⅰ～Ⅱ度中小面积可冷疗，Ⅲ度及大面积不必，符合教材。（正确）
> C. 牙膏、酱油会污染创面、影响判断，禁忌；用土方替代冷疗。（错误）
> D. 水疱是天然敷料，刺破会增加感染风险；把水疱当成需要放液。（错误）
> E. 油脂会封闭创面、阻碍散热并增加感染；用油脂代替清洁敷料。（错误）
>
> 【易错点】烧伤现场“冲脱泡盖送”，不涂药、不挑疱、Ⅲ度不大面积冷疗。

---

109. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-011

> 模块：M05｜页码：教材P192

狂犬病暴露后 5 针法接种程序的时间是

- A. 第0、1、3、7、14天
- **B. 第0、3、7、14、28天** ✅
- C. 第0、7、14、21、28天
- D. 第1、3、7、14、28天
- E. 第0、3、7、21、28天

答案：B

> 解析：【正确答案】狂犬病疫苗 5 针法程序为第 0、3、7、14 和 28 天各接种 1 剂，共 5 剂；“2-1-1”程序为第 0 天接种 2 剂、第 7 天和第 21 天各 1 剂，共 4 剂。接种部位为上臂三角肌。
>
> 【逐项解析】A. 第 1 天不是 5 针法的起点，且缺少第 28 天。（错误）
> B. 0、3、7、14、28 天各 1 剂，是标准 5 针法。（正确）
> C. 缺少第 3 天、把 14/21/28 全部纳入，不是 5 针法。（错误）
> D. 首剂应在第 0 天而不是第 1 天；把当天算成第 1 天。（错误）
> E. 第 5 剂应在第 28 天，且第 3 天不可省。（错误）
>
> 【易错点】5 针法记“0-3-7-14-28”；2-1-1 记“0 天两针、7、21”。

---

110. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-012

> 模块：M05｜页码：教材P282

关于止血带的使用，下列正确的是

- A. 可持续绑扎8小时不放松
- **B. ≤4小时，每小时松1～2分钟** ✅
- C. 每10分钟放松一次
- D. 直接缠在皮肤上即可
- E. 可用铁丝、绳索代替

答案：B

> 解析：【正确答案】止血带最长不宜超过 4 小时，通常每小时缓慢放松 1 次、每次 1～2 分钟，放松前先压迫伤口以减少出血；止血带不能直接缠在皮肤上，须用三角巾、毛巾等垫衬，严禁用电线、铁丝、绳索代替。
>
> 【逐项解析】A. 8 小时不放松会导致缺血性肌挛缩与神经损伤。（错误）
> B. 最长 4 小时、每小时放松 1～2 分钟，符合教材。（正确）
> C. 每 10 分钟放松过于频繁，反而反复出血。（错误）
> D. 直接缠皮肤会压伤神经与皮肤，必须垫衬；忽略衬垫。（错误）
> E. 电线、铁丝、绳索接触面小、无弹性，易切割组织，严禁代替。（错误）
>
> 【易错点】止血带记“4 小时上限、每小时松 1～2 分钟、必须垫衬”。

---

111. [A2型题｜应用] batch043-M05-A2-001

> 模块：M05｜页码：教材P179

夏天建筑工人在工地干活时突然头晕、头痛，大量出汗后转为无汗，皮肤干热，体温超过 40℃，伴意识障碍。该病人最可能的诊断是

- A. 休克
- B. 热痉挛
- **C. 热射病** ✅
- D. 热衰竭
- E. 普通中暑

答案：C

> 解析：【正确答案】病人在高温环境下强体力作业，出现高热、无汗、皮肤干热、意识障碍，体温超过 40℃，符合热射病（中暑最严重类型）的典型表现；热痉挛意识清楚、体温多正常，热衰竭体温一般不超过 40℃且无明确中枢障碍。
>
> 【逐项解析】A. 休克可有意识障碍，但不会以高热、无汗、皮肤干热为突出表现。（错误）
> B. 热痉挛表现为腓肠肌痉挛、意识清楚、体温多正常。（错误）
> C. 高热、无汗、意识障碍、体温>40℃，符合热射病。（正确）
> D. 热衰竭体温一般不超过 40℃，无汗与意识障碍不是其典型表现。（错误）
> E. 普通中暑范围过宽，不能体现热射病的危重性。（错误）
>
> 【易错点】高温作业+高热+无汗+昏迷，直接诊断热射病，不要笼统写“中暑”。

---

112. [A2型题｜应用] batch043-M05-A2-002

> 模块：M05｜页码：教材P282

男，30 岁，右大腿被机器割伤，喷射性出血，加压包扎不能控制。现场使用止血带的正确做法是

- A. 大腿伤口下方5cm处扎
- **B. 伤口上方5cm、大腿上2/3** ✅
- C. 直接扎在皮肤上，越紧越好
- D. 用铁丝代替止血带
- E. 持续绑扎6小时不放松

答案：B

> 解析：【正确答案】累及大血管的严重四肢创伤可用止血带：扎在出血伤口上方 5cm，大腿宜在上 2/3；须用三角巾、毛巾等垫衬，不能直接缠皮肤；以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度；记录时间，最长不宜超过 4 小时，每小时缓慢放松 1～2 分钟。
>
> 【逐项解析】A. 止血带应扎在伤口上方而非下方，否则不能阻断动脉出血。（错误）
> B. 伤口上方 5cm、大腿上 2/3、垫衬、记录时间，符合规范。（正确）
> C. 直接缠皮肤会压伤神经与皮肤，且过紧可致组织坏死。（错误）
> D. 铁丝无弹性、接触面小，易切割组织，严禁代替。（错误）
> E. 超过 4 小时不放松可致缺血性肌挛缩与神经损伤。（错误）
>
> 【易错点】止血带“上 5cm、大腿 2/3、垫衬、记时、4 小时上限”。

---

113. [A2型题｜应用] batch043-M05-A2-003

> 模块：M05｜页码：教材P192

男，10 岁，被流浪犬咬伤小腿，伤口贯穿皮肤并出血。按狂犬病暴露分级，正确的处理是

- A. 仅清洗伤口，不接种疫苗
- B. 处理伤口+接种狂犬病疫苗
- **C. 处理伤口+被动免疫+疫苗** ✅
- D. 仅注射被动免疫制剂
- E. 观察犬10天，暂不处理

答案：C

> 解析：【正确答案】贯穿皮肤的咬伤属于III级暴露，处理包括：彻底冲洗伤口、注射狂犬病被动免疫制剂（抗狂犬病血清/狂犬病人免疫球蛋白）并在伤口周围浸润注射、接种狂犬病疫苗。II级暴露才只需处理伤口+疫苗。
>
> 【逐项解析】A. III级暴露风险最高，不接种疫苗会危及生命。（错误）
> B. III级暴露还需被动免疫制剂，仅疫苗不够；把III级降为 II 级处理。（错误）
> C. 伤口处理+被动免疫+疫苗，是III级暴露的完整方案。（正确）
> D. 被动免疫制剂不能替代疫苗的主动免疫；把被动免疫当成全部。（错误）
> E. III级暴露应立即处置，观察犬只不能替代暴露后预防。（错误）
>
> 【易错点】 II 级“洗+疫苗”，III级“洗+被动免疫+疫苗”。

---

114. [A3型题｜应用] batch043-M05-A3-001

> 模块：M05｜页码：教材P178

该病人最可能的中暑分级是

- **A. 先兆中暑** ✅
- B. 轻症中暑
- C. 热痉挛
- D. 热衰竭
- E. 热射病

答案：A

> 解析：【正确答案】病人在高温环境下出现头晕、乏力、多汗、恶心，体温 37.8℃（不超过 38℃），意识清楚、血压正常，符合先兆中暑；轻症中暑体温一般超过 38℃并出现循环功能紊乱，热射病则有高热、无汗、意识障碍。
>
> 【逐项解析】A. 症状符合且体温≤38℃，属于先兆中暑；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 轻症中暑体温一般超过 38℃并伴循环紊乱，本例未达到。（错误）
> C. 热痉挛以腓肠肌痉挛为突出表现，体温多正常。（错误）
> D. 热衰竭有血压下降、晕厥等循环衰竭表现，本例血压正常。（错误）
> E. 热射病有高热、无汗、意识障碍，本例意识清楚。（错误）
>
> 【易错点】先兆中暑的硬指标是体温≤38℃且无循环衰竭。

---

115. [A3型题｜分析] batch043-M05-A3-002

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

若该病人未及时处理，体温升至 39℃并出现面色潮红、脉搏细数、血压偏低，应判断为

- A. 先兆中暑
- **B. 轻症中暑** ✅
- C. 热痉挛
- D. 热射病
- E. 冻伤

答案：B

> 解析：【正确答案】病人体温升至 39°C（超过 38°C），并出现面色潮红、脉搏细数、血压偏低等早期循环功能紊乱，符合轻症中暑；热射病需有高热、无汗、意识障碍且核心体温超过 40.5°C。
>
> 【逐项解析】A. 先兆中暑体温不超过 38°C，本例已 39°C。（错误）
> B. 体温>38°C+循环功能紊乱，符合轻症中暑。（正确）
> C. 热痉挛以腓肠肌痉挛为主、体温多正常，本例无痉挛。（错误）
> D. 热射病需高热、无汗、意识障碍且>40.5°C，本例未达到。（错误）
> E. 冻伤发生在寒冷环境，与本例高温暴露无关。（错误）
>
> 【易错点】先兆→轻症的升级线：体温过 38°C+循环紊乱。

---

116. [判断题｜理解] batch043-M05-JUD-001

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

溺水者救上岸后，应首先倒挂控水，把胃内和肺内的水排出，再行心肺复苏。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】溺水致死的核心是窒息缺氧，现场应首先清除口鼻异物、开放气道并给予人工呼吸/胸外按压；倒挂控水会延误通气、增加误吸，不常规推荐。
>
> 【逐项解析】A. 倒挂控水会延误通气并增加误吸，故原句错误。（错误）
> B. 应先开放气道、通气/按压，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】溺水急救先通气，不控水。

---

117. [判断题｜理解] batch043-M05-JUD-002

> 模块：M05｜页码：教材P187、P309

烧烫伤后应立即在创面上涂抹牙膏或酱油，以减轻疼痛、防止感染。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】烧烫伤创面不应涂抹牙膏、酱油、油脂或药膏，这些物质会污染创面、影响对烧伤深度的判断并增加感染风险；正确做法是冷水冲洗、剪开衣物、清洁敷料覆盖后转运。
>
> 【逐项解析】A. 牙膏/酱油会污染创面并干扰判断，故原句错误。（错误）
> B. 不应涂抹牙膏/酱油，原句错误，选“错误”正确。（正确）
>
> 【易错点】烧伤创面只盖清洁敷料，不涂任何“土方”。

---

118. [X型题｜理解] batch043-M05-X-001

> 模块：M05｜页码：教材P179

关于重症中暑的类型，下列叙述正确的有

- **A. 热痉挛常表现为腓肠肌对称性痉挛，意识清楚** ✅
- **B. 热衰竭可出现血压下降、晕厥，体温一般不超过40℃** ✅
- **C. 热射病表现为高热、无汗、意识障碍** ✅
- **D. 热射病核心体温超过40.5℃** ✅
- E. 热痉挛必然出现昏迷

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】重症中暑分热痉挛、热衰竭、热射病。热痉挛以腓肠肌对称性痉挛为特点、意识清楚、体温多正常；热衰竭有脱水、血压下降、晕厥，体温一般不超过 40℃；热射病为高热、无汗、意识障碍，核心体温超过 40.5℃。热痉挛意识清楚，不出现昏迷。
>
> 【逐项解析】A. 热痉挛腓肠肌痉挛、意识清楚，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 热衰竭血压下降、晕厥、体温≤40℃，叙述正确。（正确）
> C. 热射病高热、无汗、意识障碍，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 热射病核心体温>40.5℃，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 热痉挛意识清楚，不出现昏迷，叙述错误；把热射病表现套到热痉挛。（错误）
>
> 【易错点】重症中暑三型：痉挛清、衰竭低压、热射高热昏迷。

---

119. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-013

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

高温作业者大量出汗后出现腓肠肌疼痛性抽搐，体温正常，应判断为

- **A. 热痉挛** ✅
- B. 热衰竭
- C. 热射病
- D. 先兆中暑
- E. 低钙抽搐

答案：A

> 解析：【正确答案】热痉挛属重症中暑的一种，发生在高温环境下大量出汗后，因盐分丢失过多引起肌肉痉挛，以腓肠肌最常见，体温多正常；热衰竭以循环容量不足为主，热射病则有高热、无汗与意识障碍。
>
> 【逐项解析】A. 大量出汗后腓肠肌痉挛、体温正常，符合热痉挛。（正确）
> B. 热衰竭以血压下降、循环虚脱为主，不是单纯痉挛。（错误）
> C. 热射病需核心体温>40.5℃并有意识障碍。（错误）
> D. 先兆中暑以口渴乏力头晕为主，无肌肉痉挛。（错误）
> E. 低钙抽搐与高温出汗无直接关系，血钙多正常。（错误）
>
> 【易错点】热痉挛＝大汗后腓肠肌抽、体温正常；补盐即可缓解。

---

120. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-014

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

重度淹溺病人的体温常低于

- A. 37℃
- B. 35℃
- C. 32℃
- **D. 30℃** ✅
- E. 28℃

答案：D

> 解析：【正确答案】重度淹溺因长时间浸泡在冷水中，体温常低于 30℃，可出现意识丧失、心动过缓甚至心室颤动；复温初始目标为 34℃，经 24 小时温和的低体温治疗后再恢复到正常体温。
>
> 【逐项解析】A. 37℃ 属正常体温，不符合重度淹溺；忽略冷水浸泡降温。（错误）
> B. 35℃ 仅为轻度低体温，未达重度淹溺常见水平。（错误）
> C. 32℃ 已明显降低，但教材界值是 30℃。（错误）
> D. 重度淹溺体温常低于 30℃；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 28℃ 更低，但界值仍是 30℃；把更重情形当界值。（错误）
>
> 【易错点】重度淹溺记“体温<30℃、复温先到 34℃”。

---

121. [A1型题｜记忆] batch043-M05-A1-015

> 模块：M05｜页码：教材P282

上肢外伤使用止血带时，正确的绑扎部位是

- **A. 上臂上1/3** ✅
- B. 上臂中1/3
- C. 上臂下1/3
- D. 肘窝上方
- E. 前臂中段

答案：A

> 解析：【正确答案】止血带应扎在出血伤口上方 5cm，上肢宜在上臂上 1/3、下肢宜在大腿上 2/3；上臂中下 1/3 有桡神经走行，扎在此处易致神经损伤，前臂与小腿因双骨结构止血效果差。
>
> 【逐项解析】A. 上臂上 1/3 是上肢止血带的标准部位。（正确）
> B. 上臂中 1/3 邻近桡神经，易致神经损伤。（错误）
> C. 上臂下 1/3 同样易伤及桡神经；把下段当安全区。（错误）
> D. 肘窝上方仍偏下，且邻近血管神经；把关节附近当标准部位。（错误）
> E. 前臂双骨间有骨间动脉，止血带效果差；把前臂当可扎部位。（错误）
>
> 【易错点】止血带部位记“上臂上 1/3、大腿上 2/3”，避开桡神经。

---

122. [A1型题｜理解] batch043-M05-A1-016

> 模块：M05｜页码：教材P282

止血带绑扎的松紧程度应以什么为标准

- A. 能摸到远端动脉搏动
- **B. 出血停止、远端搏动消失** ✅
- C. 肢端轻度发紫即可
- D. 越紧越好，不必顾虑
- E. 以病人能忍受为度

答案：B

> 解析：【正确答案】止血带以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度：过松只压住静脉、动脉仍供血，反而加重出血；过紧则压迫神经与软组织，导致肢体缺血坏死。
>
> 【逐项解析】A. 能摸到远端搏动说明动脉未压住，止血不彻底。（错误）
> B. 出血停止且远端搏动消失，是止血带的松紧标准。（正确）
> C. 肢端发紫可能是静脉回流受阻而动脉仍通，不能作为标准。（错误）
> D. 过紧会压迫神经、致肢体缺血坏死；认为越紧越安全。（错误）
> E. 以病人忍受度为度缺乏客观指标，容易过松或过紧。（错误）
>
> 【易错点】止血带两条：出血停、远端脉搏摸不到；过松反出血，过紧致坏死。

---

123. [A2型题｜应用] batch043-M05-A2-004

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

男，28 岁，建筑工人，38℃高温下连续作业 4 小时，大量出汗后出现双小腿腓肠肌痉挛，体温 37.2℃，血压正常。最恰当的处理是

- **A. 移至阴凉处并补充含盐液体** ✅
- B. 立即静脉注射地塞米松
- C. 立即冷水浸浴降温
- D. 立即静脉注射呋塞米
- E. 立即行气管插管

答案：A

> 解析：【正确答案】该病人高温作业后大量出汗、腓肠肌痉挛而体温正常，符合热痉挛，属盐分丢失过多所致。处理为迅速移至阴凉通风处、口服或静脉补充含盐液体，痉挛多可缓解；无需激素、利尿或冷水浸浴。
>
> 【逐项解析】A. 脱离高温环境并补盐是热痉挛的关键处理；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 激素不用于热痉挛，且不能纠正盐丢失；把激素当常规。（错误）
> C. 热痉挛体温正常，冷水浸浴无指征；把热射病降温套过来。（错误）
> D. 利尿会加重容量与电解质丢失；把少尿处理套过来。（错误）
> E. 病人呼吸正常，无插管指征；把重症处理套给轻症。（错误）
>
> 【易错点】热痉挛处理两个字：补盐；体温正常就别上冷水。

---

124. [A2型题｜应用] batch043-M05-A2-005

> 模块：M05｜页码：教材P189

男，30 岁，在工地触电倒地，身旁有落地的高压电线。救护者首先应

- A. 直接用手拉开病人
- **B. 切断电源或用绝缘物挑开电线** ✅
- C. 立即向病人泼水降温
- D. 立即抱起病人送医院
- E. 先给病人做心电图

答案：B

> 解析：【正确答案】触电急救的第一步是使病人脱离电源：立即切断电源或用干燥的木棒等绝缘物挑开电线。在未断电前直接接触病人，救护者也会触电；电线落地时还应保持室内 4m、室外 8m 以上的安全距离。
>
> 【逐项解析】A. 直接用手拉会使救护者一起触电；忽视救护者自身安全。（错误）
> B. 切断电源或用绝缘物挑开电线是首要步骤；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 泼水会导电，加重触电并危及救护者；用降温办法处理触电。（错误）
> D. 未断电就搬动，救护者同样触电；把转运置于断电之前。（错误）
> E. 心电图应在脱离电源、评估生命体征后进行。（错误）
>
> 【易错点】触电急救顺序：先断电（绝缘物）→再评估→再 CPR。

---

125. [A3型题｜应用] batch043-M05-A3-003

> 模块：M05｜页码：教材P187、P309

脱离热源后，现场首选的创面处理是

- **A. 冷水连续冲洗或浸泡** ✅
- B. 立即刺破水疱放液
- C. 涂抹牙膏或酱油
- D. 用酒精反复擦拭创面
- E. 用不透气塑料膜紧紧包扎

答案：A

> 解析：【正确答案】该病人为Ⅰ～Ⅱ度、中小面积烧烫伤，脱离热源后应立即用冷水连续冲洗或浸泡，以降低创面温度、减轻热力继续损伤并缓解疼痛；Ⅲ度及大面积烧伤则不必冷疗，以免诱发低体温。
>
> 【逐项解析】A. Ⅰ～Ⅱ度中小面积应先用冷水冲洗或浸泡；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 刺破水疱会破坏屏障、增加感染；把水疱当必须放液。（错误）
> C. 牙膏、酱油会污染创面、影响判断；用土办法处理创面。（错误）
> D. 酒精刺激创面并加重疼痛与损伤；把消毒当成冷疗。（错误）
> E. 不透气包扎会使热力蓄积并增加感染；把包扎当降温。（错误）
>
> 【易错点】烧伤现场先冷疗：Ⅰ～Ⅱ度中小面积冲冷水，Ⅲ度/大面积不冷疗。

---

126. [A3型题｜应用] batch043-M05-A3-004

> 模块：M05｜页码：教材P187、P309

冷疗后对水疱与创面的正确处理是

- **A. 保留水疱，用清洁敷料覆盖** ✅
- B. 刺破水疱后涂抗生素药膏
- C. 剪除全部疱皮后暴露创面
- D. 撒消炎粉后加压包扎
- E. 用棉花直接覆盖创面

答案：A

> 解析：【正确答案】烧烫伤创面不刺破水疱、不涂油脂或药膏，用清洁敷料覆盖后转运。完整的水疱皮是天然生物敷料，能保护创面、减少感染与疼痛；刺破或剪除会增加感染风险。
>
> 【逐项解析】A. 保留完整水疱并用清洁敷料覆盖，符合教材处理。（正确）
> B. 刺破水疱并涂药膏会增加感染、影响后续评估。（错误）
> C. 剪除疱皮会丢失天然屏障，增加感染；把清创扩大化。（错误）
> D. 粉剂会异物残留、影响创面判断；用粉剂处理创面。（错误）
> E. 棉花纤维会粘连创面、留下异物；用棉花当敷料。（错误）
>
> 【易错点】烧伤创面三不：不刺疱、不涂药膏、不撒粉；只盖清洁敷料。

---

127. [判断题｜理解] batch043-M05-JUD-003

> 模块：M05｜页码：教材P189

发现有人触电倒地，救护者应立即用手将其拉离电源，再判断意识和呼吸。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】未切断电源前，人体与电线仍带电，救护者直接用手拉拽会一起触电。正确做法是立即切断电源或用干燥木棒等绝缘物挑开电线，确认现场安全后再评估意识与呼吸。
>
> 【逐项解析】A. 直接用手拉拽会使救护者触电，原句错误；忽视救护者安全。（错误）
> B. 应先断电或用绝缘物挑开电线，故原句错误。（正确）
>
> 【易错点】触电现场第一原则：先保护自己，再救人；断电永远排在拉人之前。

---

128. [X型题｜理解] batch043-M05-X-002

> 模块：M05｜页码：教材P179

关于热射病，下列叙述正确的有

- **A. 核心体温超过40.5℃** ✅
- **B. 高热、无汗、意识障碍** ✅
- **C. 10～40分钟内降至39℃以下** ✅

- **D. 2小时内降至38.5℃以下** ✅
- E. 降温应缓慢进行以防寒战

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】热射病是中暑最严重类型，表现为高热、无汗、意识障碍，核心体温超过40.5℃；降温目标为核心体温 10～40 分钟内降至 39℃ 以下、2 小时内降至 38.5℃ 以下。降温必须迅速，缓慢降温会增加死亡风险。
>
> 【逐项解析】A. 核心体温>40.5℃是热射病的诊断界值，叙述正确。（正确）
> B. 高热、无汗、意识障碍是典型三联，叙述正确。（正确）
> C. 10～40 分钟内降至 39℃以下，叙述正确。（正确）
> D. 2 小时内降至 38.5℃以下，叙述正确。（正确）
> E. 热射病需快速降温，缓慢降温是错误的；把“防寒战”当成慢慢降温。（错误）
>
> 【易错点】热射病两个时间点：10～40 分钟到 39℃，2 小时到 38.5℃。

---

129. [X型题｜理解] batch043-M05-X-003

> 模块：M05｜页码：教材P187、P309

关于烧烫伤的现场急救，下列叙述正确的有

- **A. Ⅰ～Ⅱ度中小面积可冷水冲洗** ✅
- **B. III度及大面积不必冷疗** ✅
- **C. 不刺破水疱** ✅
- **D. 不涂油脂或药膏** ✅
- E. 创面应用棉花直接覆盖

答案：ABCD

解析：【正确答案】烧烫伤现场急救：脱离热源后立即用冷水连续冲洗或浸泡，适用于Ⅰ～Ⅱ度中小面积；Ⅲ度及大面积烧伤不必冷疗，以免低体温。不刺破水疱、不涂油脂或药膏，用清洁敷料覆盖；棉花纤维会粘连创面，不能直接覆盖。

【逐项解析】A. Ⅰ～Ⅱ度中小面积冷水冲洗是正确做法；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
B. Ⅲ度及大面积不必冷疗，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
C. 不刺破水疱可保留天然屏障，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
D. 不涂油脂或药膏可避免污染，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
E. 棉花会粘连创面，不能直接覆盖，叙述错误。（错误）

【易错点】烧伤急救记“冲、盖、不刺、不涂”；棉花不是敷料。

---

130. [X型题｜理解] batch043-M05-X-004

模块：M05｜页码：教材P192

关于犬咬伤后的狂犬病预防，下列叙述正确的有

- **A. Ⅱ级暴露处理伤口并接种疫苗** ✅
- **B. Ⅲ级暴露加用被动免疫制剂** ✅
- **C. 5针法为0、3、7、14、28天** ✅
- **D. 2-1-1程序第0天接种2剂** ✅
- E. 潜伏期多数为1～3天

答案：ABCD

解析：【正确答案】Ⅱ级暴露处理伤口并接种狂犬病疫苗；Ⅲ级暴露在此基础上加用狂犬病被动免疫制剂。5针法为第0、3、7、14、28天各1剂；“2-1-1”程序第0天2剂、第7天和第21天各1剂。潜伏期多数为20～90天，不是1～3天。

【逐项解析】A. Ⅱ级暴露处理伤口加疫苗，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
B. Ⅲ级暴露加用被动免疫制剂，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
C. 5针法时间点为0、3、7、14、28天，叙述正确。（正确）
D. 2-1-1程序第0天接种2剂，叙述正确。（正确）
E. 潜伏期多数20～90天，1～3天是错误的。（错误）

【易错点】狂犬病记“Ⅱ级疫苗、Ⅲ级加免疫球；5针0-3-7-14-28”。

M06（26题）

131. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-001

> 模块：M06｜页码：教材P255

多发伤是指

- **A. 一个因素致≥2个部位重伤** ✅
- B. 两种以上致伤因素同时造成的损伤
- C. 同一部位的多处浅表伤
- D. 慢性疾病急性发作
- E. 单一器官的贯穿伤

答案：A

> 解析：【正确答案】多发伤指同一致伤因素造成 2 个及以上解剖部位的严重损伤，伤情重、变化快，具有加重效应；与复合伤不同，后者是两种以上致伤因素（如烧伤+骨折、放射+创伤）同时作用。
>
> 【逐项解析】A. 同一致伤因素、≥2 个解剖部位严重损伤，是多发伤的定义。（正确）
> B. 两种以上致伤因素是复合伤的定义，不是多发伤。（错误）
> C. 同一部位多处浅表伤不构成多个解剖部位的严重损伤。（错误）
> D. 慢性病急性发作不是创伤，不符合多发伤；把内科急症混入。（错误）
> E. 单一器官贯穿伤只涉及一个部位，不是多发伤。（错误）
>
> 【易错点】多发伤记“一个因素、两个部位”；复合伤记“两个因素”。

---

132. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-002

> 模块：M06｜页码：教材P256-257

创伤病人初级评估的 ABCDE 顺序是

- **A. 气道颈椎-呼吸-循环-意识-暴露** ✅
- B. 呼吸—气道—循环—意识—暴露
- C. 循环—气道—呼吸—意识—暴露
- D. 意识—气道—呼吸—循环—暴露
- E. 暴露—气道—呼吸—循环—意识

答案：A

> 解析：【正确答案】创伤初级评估按 ABCDE 进行：A 气道与颈椎保护、B 呼吸与通气、C 循环与止血、D 意识（GCS）、E 暴露与保温；致命性外出血应在 A 之前先控制，整个评估遵循先救命后治伤。
>
> 【逐项解析】A. A 气道颈椎、B 呼吸、C 循环止血、D 意识、E 暴露保温，顺序正确。（正确）
> B. 呼吸排在气道之前，若气道不通畅则通气无效。（错误）
> C. 循环排在气道之前，不符合 ABCDE；把 C 提前。（错误）
> D. 意识不是第一项，且暴露应在最后；把 D 提前。（错误）
> E. 暴露放在首位会增加低体温风险，且未先处理气道。（错误）
>
> 【易错点】ABCDE 记“气—呼—循—意—露”，大出血在 A 之前先压住。

---

133. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-003

> 模块：M06｜页码：教材P255-257

下列创伤中，属于必须优先处理的致命伤的是

- A. 单根肋骨骨折
- **B. 张力性气胸** ✅
- C. 踝关节扭伤
- D. 前臂擦伤
- E. 轻度脑震荡

答案：B

> 解析：【正确答案】连枷胸、开放性气胸、张力性气胸、骨盆骨折等可在短时间内危及生命，属于优先处理的致命伤；单根肋骨骨折、踝扭伤、擦伤、轻度脑震荡一般不立即致命，可在初级评估后处理。
>
> 【逐项解析】A. 单根肋骨骨折通常不立即致命，除非合并血气胸。（错误）
> B. 张力性气胸可在数分钟内致循环衰竭，必须优先穿刺减压。（正确）
> C. 踝关节扭伤不影响生命体征，不属于致命伤。（错误）
> D. 前臂擦伤是浅表伤，不危及生命；把浅表伤当成致命伤。（错误）
> E. 轻度脑震荡需观察，但不属于立即致命的胸部/骨盆伤。（错误）
>
> 【易错点】致命伤记“连枷、开放气胸、张力气胸、骨盆骨折”。

---

134. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-004

> 模块：M06｜页码：教材P257

连枷胸的典型体征及首要处理是

- **A. 浮动胸壁+反常呼吸，先固定** ✅
- B. 胸壁压痛；立即开胸探查
- C. 气管偏移；立即切开心包
- D. 皮下气肿；立即拔除肋骨
- E. 心音遥远；立即输血

答案：A

> 解析：【正确答案】连枷胸由多根多处肋骨骨折引起，该段胸壁失去骨性支撑，出现胸壁浮动与反常呼吸，导致通气效率下降和肺挫伤；处理包括固定浮动胸壁、充分镇痛、保持气道通畅，必要时气管插管机械通气。
>
> 【逐项解析】A. 胸壁浮动、反常呼吸是连枷胸特征，处理为固定、镇痛、气道支持。（正确）
> B. 单纯胸壁压痛不能诊断连枷胸，开胸也不是首要处理。（错误）
> C. 气管偏移提示张力性气胸，不是连枷胸；心包切开用于心脏压塞。（错误）
> D. 皮下气肿提示气胸/气道损伤，拔除肋骨是错误做法。（错误）
> E. 心音遥远提示心脏压塞，不是连枷胸；把 Beck 三联征套到连枷胸。（错误）
>
> 【易错点】连枷胸记“浮动胸壁+反常呼吸”，先固定镇痛、必要时通气。

---

135. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-005

> 模块：M06｜页码：教材P257、P282

开放性气胸现场急救的第一步是

- A. 立即行胸腔闭式引流
- **B. 凡士林纱布封闭伤口** ✅
- C. 立即气管插管
- D. 立即开胸探查
- E. 立即给强心药

答案：B

> 解析：【正确答案】开放性气胸胸壁伤口使胸膜腔与大气相通，现场应立即用 5～6 层凡士林油纱布封闭伤口，外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性，再行胸腔闭式引流；先穿刺或先引流都不能解决持续漏气。
>
> 【逐项解析】A. 闭式引流是后续处理，现场必须先封闭伤口，否则持续漏气。（错误）
> B. 凡士林纱布封闭伤口是开放性气胸现场的第一步。（正确）
> C. 气管插管正压通气可能加重漏气，应在封闭伤口后评估。（错误）
> D. 现场开胸不具备条件，也不是首要处理；把确定性手术当成急救。（错误）
> E. 强心药不能解决胸膜腔漏气与肺萎陷；用药物替代机械处理。（错误）
>
> 【易错点】开放气胸先封闭，张力气胸先穿刺，连枷胸先固定。

---

136. [A1型题｜记忆] batch043-M06-A1-006

> 模块：M06｜页码：教材P257、P282

张力性气胸紧急穿刺排气的位置是

- **A. 锁骨中线第2或腋中线4、5肋间** ✅
- B. 腋前线第6肋间处
- C. 剑突下方穿刺位置
- D. 肩胛下角线第8肋间
- E. 胸骨正中穿刺部位

答案：A

> 解析：【正确答案】张力性气胸应立即用 9～16 号针头在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，并给予高流量吸氧；穿刺后接单向活瓣或胸腔闭式引流，不能等待胸片确认。
>
> 【逐项解析】A. 锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间，是张力性气胸的穿刺位置。（正确）
> B. 腋前线第 6 肋间位置偏低，不是首选穿刺点。（错误）
> C. 剑突下穿刺用于心包穿刺，不是气胸减压；把心包穿刺位置套过来。（错误）
> D. 肩胛下角线第 8 肋间位置过低，易损伤肝脾。（错误）
> E. 胸骨正中不能进入胸膜腔，无法排气；把中线当成穿刺点。（错误）
>
> 【易错点】张力气胸穿刺记“锁骨中线第 2 或腋中线第 4、5 肋间”。

---

137. [A1型题｜记忆] batch043-M06-A1-007

> 模块：M06｜页码：教材P255、P284

骨盆骨折病人的搬运方法，正确的是

- A. 一人抱起搬运法
- B. 两人拉车式搬运
- **C. 仰卧屈膝、多人平托** ✅
- D. 俯卧位背负骨盆伤员
- E. 坐位、三人抬送

答案：C

> 解析：【正确答案】骨盆骨折搬运应使伤员仰卧，双下肢髋、膝关节半屈，膝下垫软物，用三角巾或骨盆带围绕臀部和骨盆，多人平托放在木板或担架上；不稳定的骨盆环在搬动时可继续出血。
>
> 【逐项解析】A. 一人抱起会使骨盆环变形、加重出血与疼痛。（错误）
> B. 拉车式使骨盆扭转，是骨盆/脊柱骨折的禁忌。（错误）
> C. 仰卧、髋膝半屈、骨盆带固定、多人平托，符合骨盆骨折搬运。（正确）
> D. 俯卧背负会压迫骨盆与腹部，加重损伤；把脊柱伤搬运法套过来。（错误）
> E. 坐位会使骨折端受力，不适用于骨盆骨折；让伤员坐起。（错误）
>
> 【易错点】骨盆骨折记“仰卧屈膝、骨盆带、多人平托”。

---

138. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-008

> 模块：M06｜页码：教材P317

下列现场处理中，做法错误的是

- A. 外露骨折端用无菌敷料覆盖
- B. 畸形肢体按原位固定
- C. 脊柱骨折三人平托搬运
- D. 用制式止血带控制肢体大出血
- **E. 腹部内脏脱出立即还纳** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】腹部内脏脱出不应还纳，因为脱出脏器已被污染，还纳会把污染带入腹腔；正确做法是用湿无菌敷料覆盖、外用清洁容器保护后转运。外露骨折端不回纳、畸形不复位、脊柱骨折平托、制式止血带都是正确做法。
>
> 【逐项解析】A. 外露骨折端覆盖无菌敷料、不回纳，是正确做法。（错误）
> B. 现场不复位、按原位固定，是正确做法；把正确做法当成错误。（错误）
> C. 脊柱骨折三人/四人平托，是正确搬运；把正确做法当成错误。（错误）
> D. 制式止血带用于大血管出血，是正确做法；把正确做法当成错误。（错误）
> E. 腹部内脏脱出立即还纳会把污染带入腹腔，是错误做法。（正确）
>
> 【易错点】现场四不：不回纳骨折端、不复位、不拉车、不还纳内脏。

---

139. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-009

> 模块：M06｜页码：教材P256-257

创伤病人同时存在气道梗阻与肢体喷射性大出血时，最先应处理的是

- A. 气道梗阻伴大出血
- **B. 肢体大出血** ✅
- C. 肢体骨折固定
- D. 意识评估
- E. 暴露查体

答案：B

> 解析：【正确答案】致命性外出血应在气道评估之前先控制，因为可在数分钟内失血致死；控制出血后再按 A（气道与颈椎）、B（呼吸）、C（循环）继续评估。若出血已控制，则按 ABCDE 顺序推进。
>
> 【逐项解析】A. 气道梗阻重要，但致命性外出血可在更短时间内致死，须先压迫止血。（错误）
> B. 致命性外出血优先控制，符合创伤急救原则。（正确）
> C. 骨折固定属于后续处理，不能优先于止血；把骨科处理提前。（错误）
> D. 意识评估在 D 步，不能先于止血；把 D 提前。（错误）
> E. 暴露查体在 E 步，且可加重低体温；把 E 提前。（错误）
>
> 【易错点】创伤顺序有一个例外：致命性外出血先于 A。

---

140. [A2型题｜应用] batch043-M06-A2-001

> 模块：M06｜页码：教材P257

男，20 岁，闭合性胸外伤 5 小时。查体：口唇发绀，端坐呼吸，左侧胸壁触及皮下气肿，气管右偏，左侧呼吸音消失。正确的急救措施是

- A. 急诊开胸检查
- B. 心包穿刺
- **C. 左胸腔穿刺排气** ✅
- D. 加压吸氧
- E. 气管插管

答案：C

> 解析：【正确答案】病人有胸外伤史，出现发绀、端坐呼吸、患侧皮下气肿、气管向对侧偏移、患侧呼吸音消失，符合张力性气胸；应立即用粗针在患侧锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，再行闭式引流。
>
> 【逐项解析】A. 开胸探查是后续确定性处理，现场/急诊应先穿刺减压。（错误）
> B. 心包穿刺用于心脏压塞，本例无颈静脉怒张、心音遥远等表现。（错误）
> C. 患侧胸腔穿刺排气是张力性气胸的立即处理。（正确）
> D. 加压吸氧可辅助，但不能替代穿刺减压，且正压通气可能加重。（错误）
> E. 气管插管正压通气在未减压前可加重张力性气胸。（错误）
>
> 【易错点】气管偏移+皮下气肿+患侧呼吸音消失：先穿刺，后引流，不等片。

---

141. [A2型题｜应用] batch043-M06-A2-002

> 模块：M06｜页码：教材P284

下列骨折急救处理中，不正确的是

- A. 包扎骨折伤口
- B. 骨折妥善外固定
- C. 首先抢救生命
- **D. 外露骨折端立即复位** ✅
- E. 迅速运往医院

答案：D

> 解析：【正确答案】骨折急救中，外露的骨折端不应立即复位或回纳，因为已被污染，回纳会把污染带入深部并可能加重血管神经损伤；正确做法是覆盖无菌敷料、按原位固定后转运。包扎、外固定、先抢救生命、迅速转运都是正确的。
>
> 【逐项解析】A. 包扎伤口可减少污染与出血，是正确做法；把正确做法当成错误。（正确）
> B. 妥善外固定可减少骨折端移动与二次损伤，是正确做法。（正确）
> C. 首先抢救生命符合先救命后治伤，是正确做法。（正确）
> D. 外露骨折端立即复位会把污染带入深部，是错误做法。（错误）
> E. 迅速转运至有条件的医院是正确做法；把正确做法当成错误。（正确）
>
> 【易错点】骨折现场记“不回纳、不复位、先固定、再转运”。

---

142. [A2型题｜应用] batch043-M06-A2-003

> 模块：M06｜页码：教材P255、P284

男，35 岁，车祸致骨盆骨折，血压 85/55mmHg，心率 125 次/分，面色苍白，会阴部见瘀斑。现场处理最恰当的是

- A. 立即站立位搬动至担架
- **B. 骨盆带固定、平托、限制性补液** ✅
- C. 立即行尿道探查
- D. 先做骨盆X线再处理
- E. 立即大量输注升压药

答案：B

> 解析：【正确答案】骨盆骨折合并休克提示腹膜后大出血，现场应立即用骨盆带固定骨盆环、多人平托搬运，建立静脉通道并限制性液体复苏，尽快转运至可行血管造影栓塞或外固定的医院；搬动、探查、等影像都会加重出血或延误。
>
> 【逐项解析】A. 站立或单人搬动会使骨盆环变形、加重出血。（错误）
> B. 骨盆带固定+多人平托+静脉通道+限制性液体复苏，符合骨盆骨折休克处理。（正确）
> C. 尿道探查应先评估，不能在现场盲目进行，且不解决大出血。（错误）
> D. 血流动力学不稳定时先复苏与固定，不能等 X 线。（错误）
> E. 升压药不能替代止血与扩容，未控制出血时升压可加重出血。（错误）
>
> 【易错点】骨盆骨折+休克：先固定骨盆、平托、补液，尽快栓塞/外固定。

---

143. [A3型题｜应用] batch043-M06-A3-001

> 模块：M06｜页码：教材P256-257

按创伤初级评估，最先应处理的是

- A. 左大腿畸形复位
- B. 左胸壁皮下气肿
- **C. 活动性大出血与气道/呼吸** ✅
- D. 立即头部CT
- E. 左大腿骨折内固定

答案：C

> 解析：【正确答案】该病人存在活动性大出血、呼吸急促与发绀、皮下气肿，提示失血与胸部致命伤；创伤初级评估应先控制致命性外出血，再按 A 气道与颈椎、B 呼吸（张力性气胸需穿刺减压）、C 循环继续处理。骨折复位、CT、内固定都属于后续处理。
>
> 【逐项解析】A. 骨折复位不是首要，且现场复位会加重出血与损伤。（错误）
> B. 皮下气肿提示气胸，需在 B 步评估减压，但不能先于止血与气道。（错误）
> C. 活动性大出血与气道/呼吸问题直接致命，应最先处理。（正确）
> D. 头部 CT 需在生命体征稳定后进行；把影像置于复苏之前。（错误）
> E. 内固定是确定性手术，不能在初级评估阶段优先。（错误）
>
> 【易错点】多发伤先止血、再 ABCDE；骨折与 CT 都往后排。

---

144. [A3型题｜分析] batch043-M06-A3-002

> 模块：M06｜页码：教材P257

该病人左胸壁皮下气肿、呼吸急促、发绀，最应考虑并立即处理的胸部损伤是

- A. 单纯胸壁软组织挫伤
- **B. 张力性气胸** ✅
- C. 连枷胸
- D. 心脏压塞
- E. 肋骨单根骨折

答案：B

> 解析：【正确答案】胸外伤后出现呼吸急促、发绀、患侧皮下气肿，提示胸膜腔内压持续升高，最应考虑张力性气胸；应立即用粗针在患侧锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，再行闭式引流。
>
> 【逐项解析】A. 软组织挫伤不能解释发绀与皮下气肿；把致命伤降级为轻伤。（错误）
> B. 呼吸急促、发绀、皮下气肿提示张力性气胸，需立即穿刺减压。（正确）
> C. 连枷胸以浮动胸壁、反常呼吸为特征，本例未描述。（错误）
> D. 心脏压塞表现为颈静脉怒张、心音遥远、低血压，本例不典型。（错误）
> E. 单根肋骨骨折一般不致严重发绀与广泛皮下气肿。（错误）
>
> 【易错点】胸外伤+发绀+皮下气肿：先想张力性气胸，先穿刺。

---

145. [判断题｜理解] batch043-M06-JUD-001

> 模块：M06｜页码：教材P257

连枷胸病人出现严重呼吸窘迫时，应尽早气管插管并机械通气，同时充分镇痛。

- **A. 正确** ✅
- B. 错误

答案：A

> 解析：【正确答案】连枷胸因胸壁浮动、反常呼吸导致通气效率下降与肺挫伤，严重呼吸窘迫时应尽早气管插管、机械通气（可起内固定作用），并充分镇痛以改善呼吸功；局部固定浮动胸壁、保持气道通畅也很重要。
>
> 【逐项解析】A. 严重呼吸窘迫时插管机械通气+镇痛，符合连枷胸处理，故正确。（正确）
> B. 把正确处置判为错误，可能低估了连枷胸的呼吸衰竭风险。（错误）
>
> 【易错点】连枷胸呼吸窘迫：插管通气+镇痛，不要只贴胸带。

---

146. [X型题｜理解] batch043-M06-X-001

> 模块：M06｜页码：教材P282、P284、P317

下列创伤现场处理中，属于禁忌的有

- **A. 外露骨折端回纳伤口内** ✅
- **B. 现场强行复位畸形肢体** ✅

- **C. 一人抬胸、一人抬腿搬运脊柱骨折伤员** ✅
- **D. 用电线、铁丝代替止血带** ✅
- E. 用无菌敷料覆盖外露骨折端

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】外露骨折端回纳、现场强行复位、拉车式搬运脊柱骨折、用电线/铁丝代替止血带都属于现场禁忌，会增加感染、神经血管损伤、截瘫与组织切割风险；用无菌敷料覆盖外露骨折端是正确做法。
>
> 【逐项解析】A. 外露骨折端回纳会把污染带入深部，属于禁忌。（正确）
> B. 现场强行复位缺乏影像与无菌条件，属于禁忌。（正确）
> C. 拉车式使脊柱屈曲扭转，可致截瘫，属于禁忌。（正确）
> D. 电线/铁丝无弹性、接触面小，属于禁忌；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 无菌敷料覆盖外露骨折端是正确做法，不是禁忌。（错误）
>
> 【易错点】创伤现场四禁：不回纳、不复位、不拉车、不用电线。

---

147. [A1型题｜记忆] batch043-M06-A1-010

> 模块：M06｜页码：教材P255

多发伤有三个死亡高峰，其中第二个高峰出现在伤后

- A. 数分钟内
- **B. 1小时内** ✅
- C. 数小时至数天
- D. 1周左右
- E. 1个月左右

答案：B

> 解析：【正确答案】多发伤有三个死亡高峰：第一高峰在伤后数分钟内（当场死亡，多因脑干、高位颈髓损伤或大血管破裂），第二高峰在伤后 1 小时内（早期死亡，多因失血、张力性气胸等可挽救的致命伤），第三高峰在伤后数天（多因感染与 MODS）。
>
> 【逐项解析】A. 数分钟内是第一死亡高峰，多为当场死亡；把第一高峰当第二。（错误）
> B. 伤后 1 小时内是第二高峰，是急救最关键的时间窗。（正确）
> C. 数小时至数天对应第三高峰，以感染与 MODS 为主。（错误）
> D. 1 周左右已属后期并发症阶段；把后期当早期。（错误）
> E. 1 个月左右不属于三个死亡高峰；把康复期并发症算入。（错误）
>
> 【易错点】三个高峰：数分钟（当场）—1 小时（早期可救）—数天（感染/MODS）。

---

148. [A1型题｜记忆] batch043-M06-A1-011

> 模块：M06｜页码：教材P257、P282

张力性气胸紧急穿刺排气时，应选用的针头型号是

- A. 4～6号
- B. 7～8号
- **C. 9～16号** ✅
- D. 18～20号
- E. 22～24号

答案：C

> 解析：【正确答案】张力性气胸需立即用 9～16 号粗针头在患侧锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，随后接闭式引流；针头过细（如 22 号）无法有效排出高压气体。
>
> 【逐项解析】A. 4～6 号过细，无法快速排气；把细针当粗针。（错误）
> B. 7～8 号仍偏细，减压不彻底；低估排气需求。（错误）
> C. 9～16 号粗针头是张力性气胸的穿刺规格。（正确）
> D. 18～20 号可用于一般穿刺，但教材推荐 9～16 号。（错误）
> E. 22～24 号过细，不能有效减压；用输液针代替减压针。（错误）
>
> 【易错点】张力性气胸记“9～16 号粗针、锁骨中线第 2 肋间”。

---

149. [A1型题｜理解] batch043-M06-A1-012

> 模块：M06｜页码：教材P282、P284、P317

腹部外伤致内脏脱出，现场正确的处理是

- A. 立即将内脏还纳腹腔
- **B. 不还纳，用无菌敷料覆盖保护** ✅
- C. 用清水冲洗后还纳
- D. 用止血带扎住脱出物
- E. 直接加压包扎压迫内脏

答案：B

> 解析：【正确答案】腹部内脏脱出时不要还纳，以免把污染带入腹腔并加重损伤；应用无菌敷料或清洁碗覆盖保护、外做环形包扎，尽快转运手术。强行还纳可致弥漫性腹膜炎，是现场红线。
>
> 【逐项解析】A. 还纳会把污染物带入腹腔，加重感染；把脱出当疝复位。（错误）
> B. 不还纳、无菌敷料覆盖是正确现场处理；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 冲洗后还纳同样违反“不还纳”原则；把清创扩大到腹腔。（错误）
> D. 止血带会阻断脱出脏器血供，导致坏死；把止血带用于内脏。（错误）
> E. 直接加压会压迫脱出脏器并致其损伤；把加压包扎套给内脏脱出。（错误）
>
> 【易错点】内脏脱出记“不还纳、不冲洗、不压迫，只覆盖保护”。

---

150. [A2型题｜应用] batch043-M06-A2-004

> 模块：M06｜页码：教材P257、P282

男，25 岁，左胸被刀刺伤，创口随呼吸有气体进出并闻及吮吸声，呼吸急促、口唇发绀。现场首要的处理是

- **A. 立即用凡士林纱布封闭伤口** ✅
- B. 立即行胸腔闭式引流
- C. 立即行气管插管
- D. 立即开胸探查
- E. 立即静脉注射呋塞米

答案：A

> 解析：【正确答案】伤口随呼吸有气体进出并出现吮吸声，是开放性气胸的典型表现。现场应先用 5～6 层凡士林油纱布封闭伤口、外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性，再行胸腔闭式引流。
>
> 【逐项解析】A. 凡士林纱布封闭伤口是开放性气胸的现场首要处理。（正确）
> B. 闭式引流需在伤口封闭、条件具备后进行；把确定性处理提前。（错误）
> C. 气道通畅时不必立即插管，先处理胸壁伤口。（错误）
> D. 开胸探查需在医院手术室进行；把手术当现场急救。（错误）
> E. 利尿不针对开放性气胸，可能加重低血容量。（错误）
>
> 【易错点】开放性气胸记“先封闭、后引流”；听到吮吸声就是封闭指征。

---

151. [A2型题｜应用] batch043-M06-A2-005

> 模块：M06｜页码：教材P257

男，50 岁，车祸致左侧多根多处肋骨骨折，吸气时左胸壁局部内陷、呼气时外突，呼吸浅快、发绀。现场处理的重点是

- **A. 固定浮动胸壁并保持气道通畅** ✅
- B. 立即加压包扎整个胸壁
- C. 立即行肋骨内固定手术
- D. 立即抽胸腔积液
- E. 立即使用正压通气即可

答案：A

> 解析：【正确答案】吸气时胸壁内陷、呼气时外突是反常呼吸，提示连枷胸。处理包括固定浮动胸壁、镇痛、保持气道通畅，必要时机械通气；现场可用敷料加压固定胸壁，但不宜环形包扎整个胸廓。
>
> 【逐项解析】A. 固定浮动胸壁、镇痛、保持气道通畅是连枷胸的处理要点。（正确）
> B. 环形包扎整个胸壁会限制通气，加重呼吸衰竭。（错误）
> C. 肋骨内固定是后续确定性手术，非现场处理。（错误）
> D. 连枷胸的主要问题是反常呼吸与肺挫伤，不是胸腔积液。（错误）
> E. 正压通气是必要时的支持手段，不是唯一处理。（错误）
>
> 【易错点】连枷胸记“固定浮动胸壁＋镇痛＋保气道”，不要全胸环形包扎。

---

152. [A3型题｜应用] batch043-M06-A3-003

> 模块：M06｜页码：教材P255、P284

该病人搬运时正确的方法是

- **A. 仰卧屈膝、骨盆带、多人平托** ✅
- B. 由一人抱起搬运
- C. 一人抬头、一人抬腿
- D. 俯卧位由单人背负
- E. 让病人自行行走转运

答案：A

> 解析：【正确答案】骨盆骨折搬运应取仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，用骨盆带固定，多人平托保持骨盆稳定；一人抱、一人抬头一人抬腿、背负或自行行走都会使骨折端移位，加重出血与疼痛。
>
> 【逐项解析】A. 仰卧屈膝、骨盆带固定、多人平托是正确搬运法。（正确）
> B. 一人抱起会使骨盆受力变形，加重出血；把抱运当省事。（错误）
> C. 一人抬头一人抬腿会造成骨盆分离；用拉车式搬运。（错误）
> D. 俯卧背负会压迫骨盆并致移位；把背负当快速搬运。（错误）
> E. 自行行走会使骨折端活动、加重损伤；把能走当成伤轻。（错误）
>
> 【易错点】骨盆骨折记“仰卧屈膝、骨盆带、多人平托”，三种错误搬运都要认出来。

---

153. [A3型题｜分析] batch043-M06-A3-004

> 模块：M06｜页码：教材P255、P284

该病人合并休克，最优先的处理是

- A. 立即复位骨盆后转运
- **B. 快速补液并准备止血或手术** ✅
- C. 先完成骨盆CT检查
- D. 立即留置导尿
- E. 立即静脉推注升压药

答案：B

> 解析：【正确答案】复杂性骨盆骨折或伴休克属危重，首要任务是抗休克：建立静脉通道、快速补液，同时用骨盆带固定减少出血，并尽快准备止血或手术。CT、导尿等检查应在生命体征相对稳定后进行；升压药不能替代容量复苏与止血。
>
> 【逐项解析】A. 现场复位不能止血，反而可能加重出血；把复位当止血。（错误）
> B. 快速补液加止血/手术是骨盆骨折合并休克的首要处理。（正确）
> C. CT 需在血流动力学稳定后进行；把影像置于复苏之前。（错误）
> D. 导尿应在确认尿道损伤后谨慎进行，不是最优先。（错误）
> E. 升压药应在充分液体复苏后使用，不能替代止血。（错误）
>
> 【易错点】骨盆骨折合并休克：先固定骨盆＋补液止血，CT 与导尿都往后排。

---

154. [判断题｜理解] batch043-M06-JUD-002

> 模块：M06｜页码：教材P282、P284、P317

四肢骨折现场发现骨折端外露时，应立即将其回纳，以免暴露过久引起感染。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】外露的骨折端不得回纳：回纳会把污染物带入深部组织，引起深部感染与骨髓炎，且可能加重血管神经损伤。正确做法是原位覆盖清洁敷料、妥善固定后转运。
>
> 【逐项解析】A. 回纳会把污染带入深部，原句错误；把“减少暴露”当成“回纳”。（错误）
> B. 应原位覆盖、固定后转运，故原句错误；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
>
> 【易错点】外露骨折端记“不回纳、不复位、只覆盖固定”。

---

155. [X型题｜理解] batch043-M06-X-002

> 模块：M06｜页码：教材P255-257

关于胸部致命伤的识别与现场处理，下列叙述正确的有

- **A. 连枷胸表现为反常呼吸** ✅
- **B. 开放性气胸先用凡士林纱布封闭** ✅

- **C. 张力性气胸立即粗针穿刺排气** ✅
- D. 张力性气胸应先等床旁胸片
- E. 开放性气胸应先做闭式引流

答案：ABC

> 解析：【正确答案】连枷胸的特征是胸壁浮动与反常呼吸；开放性气胸应先用 5～6 层凡士林纱布封闭伤口，使其变为闭合性，再行闭式引流；张力性气胸必须立即用粗针穿刺排气，不能等待床旁胸片，否则可因高压气胸迅速致死。
>
> 【逐项解析】A. 反常呼吸是连枷胸的特征，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 开放性气胸先封闭伤口，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 张力性气胸立即粗针穿刺排气，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 等待胸片会延误减压、危及生命，叙述错误。（错误）
> E. 开放性气胸应先封闭再引流，直接引流是错误的。（错误）
>
> 【易错点】胸部三伤顺序：连枷固定、开放封闭、张力穿刺；都不能等影像。

---

156. [X型题｜理解] batch043-M06-X-003

> 模块：M06｜页码：教材P255

关于多发伤的评估与现场处理，下列叙述正确的有

- **A. 同一致伤因素致2个以上部位重伤** ✅
- **B. 初级评估按ABCDE顺序进行** ✅
- **C. 处理原则是先救命后治伤** ✅
- **D. 致命性外出血优先控制** ✅
- E. 脊柱骨折可用拉车式搬运

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】多发伤指同一致伤因素造成 2 个及以上解剖部位严重损伤；初级评估按 A 气道与颈椎、B 呼吸、C 循环与止血、D 意识、E 暴露与保温的顺序进行，原则是先救命后治伤，致命性外出血优先控制。脊柱骨折严禁一人抬胸一人抬腿的拉车式搬运。
>
> 【逐项解析】A. 同一致伤因素致≥2 个部位重伤是多发伤定义，叙述正确。（正确）
> B. ABCDE 是创伤初级评估的标准顺序，叙述正确。（正确）
> C. 先救命后治伤是多发伤处理原则，叙述正确。（正确）
> D. 致命性外出血应优先控制，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 拉车式搬运会加重脊柱损伤，叙述错误；把禁忌当做法。（错误）
>
> 【易错点】多发伤记“一个因素、两个部位、ABCDE、先救命”；拉车式是红线。

M07（24题）

157. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-001

> 模块：M07｜页码：教材P87

急性冠脉综合征（ACS）不包括下列哪一型

- A. 不稳定型心绞痛
- B. 非ST段抬高型心肌梗死
- C. ST段抬高型心肌梗死
- D. 变异型心绞痛
- **E. 稳定型劳力性心绞痛** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】ACS 包括不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死和 ST 段抬高型心肌梗死，其共同基础是冠脉斑块破裂与血栓形成；稳定型劳力性心绞痛属于慢性冠脉综合征，不在 ACS 范围内。
>
> 【逐项解析】A. 不稳定型心绞痛是 ACS 的一型，属于急性冠脉事件。（正确）
> B. NSTEMI 是 ACS 的一型，cTn 升高但无 ST 段抬高。（正确）
> C. STEMI 是 ACS 最危重的一型，需紧急再灌注。（正确）
> D. 变异型心绞痛由冠脉痉挛引起，可归入 ACS 的特殊类型。（正确）
> E. 稳定型劳力性心绞痛属于慢性冠脉综合征，不是 ACS。（错误）
>
> 【易错点】ACS 三型记“不稳定心绞痛、NSTEMI、STEMI”，稳定型不在其中。

158. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-002

> 模块：M07｜页码：教材P82

高血压急症的血压标准是

- A. >160/100mmHg
- **B. >180/120mmHg并靶器官损害** ✅
- C. 收缩压>140mmHg伴头痛
- D. 收缩压>200mmHg无论有无症状
- E. 血压正常但心率增快

答案：B

> 解析：【正确答案】高血压急症指高血压伴有急性进行性靶器官病变，收缩压大于 180mmHg、舒张压大于 120mmHg，需要立即降压治疗，但不宜立即降至正常水平，应注意靶器官保护。
>
> 【逐项解析】A. 160/100mmHg 是高血压的诊断界值之一，不是高血压急症标准。（错误）
> B. 血压>180/120 且伴急性进行性靶器官损害，符合高血压急症。（正确）
> C. 仅收缩压>140 伴头痛不能诊断，需更高的血压与靶器官损害。（错误）
> D. 高血压急症强调靶器官损害，不是单看血压数值。（错误）
> E. 血压正常不符合高血压急症的定义；把其他急症套过来。（错误）
>
> 【易错点】高血压急症记“180/120+靶器官损害”，两者缺一不可。

---

159. [A1型题｜理解] batch043-M07-A1-003

> 模块：M07｜页码：教材P55-56

急性左心衰的典型表现是

- **A. 端坐呼吸、粉红泡沫痰** ✅
- B. 发热、咳嗽、脓痰
- C. 突发胸痛、咯血、低氧
- D. 腹胀、下肢水肿、颈静脉怒张
- E. 心悸、多汗、消瘦

答案：A

> 解析：【正确答案】急性左心衰表现为突发极度呼吸困难、端坐呼吸、频繁咳嗽、咳粉红色泡沫痰，查体双肺湿啰音或哮鸣音、心率 130～140 次/分、心尖区舒张期奔马律；胸片示肺间质水肿。
>
> 【逐项解析】A. 端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺湿啰音是急性左心衰的典型三联。（正确）
> B. 发热、脓痰提示肺炎，不是左心衰；把感染套到心衰。（错误）
> C. 突发胸痛、咯血、低氧提示肺栓塞；把肺栓塞套到左心衰。（错误）
> D. 颈静脉怒张、下肢水肿更符合右心衰；把右心衰表现套到左心衰。（错误）
> E. 心悸、多汗、消瘦提示甲亢等，不是急性左心衰。（错误）
>
> 【易错点】左心衰记“端坐+粉红泡沫痰+湿啰音”，右心衰才是颈静脉怒张、下肢水肿。

---

160. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-004

> 模块：M07｜页码：教材P57

急性左心衰伴肺淤血时，首选的利尿剂及剂量是

- **A. 呋塞米20～40mg静脉注射** ✅
- B. 氢氯噻嗪25mg口服
- C. 螺内酯20mg口服
- D. 甘露醇250ml静脉滴注
- E. 呋塞米200mg静脉注射

答案：A

> 解析：【正确答案】急性左心衰伴肺循环淤血或容量负荷过重时，首选呋塞米 20～40mg 静脉注射，必要时增加剂量或重复；呋塞米可快速利尿并扩张静脉，减少循环血容量。急性心肌梗死并发左心衰时利尿要慎重，过快可致低血压。
>
> 【逐项解析】A. 呋塞米 20～40mg 静注是急性左心衰的首选利尿方案。（正确）
> B. 氢氯噻嗪利尿作用较弱，不适合急性肺水肿。（错误）
> C. 螺内酯起效慢，不能用于急性肺水肿；把保钾利尿剂当急救药。（错误）
> D. 甘露醇是渗透性利尿/脱水剂，用于脑水肿，不用于心衰。（错误）
> E. 200mg 剂量过大，常规首剂 20～40mg，需按反应调整。（错误）
>
> 【易错点】急性左心衰利尿记“呋塞米 20～40mg 静推”，不是口服、不是甘露醇。

---

161. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-005

> 模块：M07｜页码：教材P15

心律失常所致心源性晕厥，常见的心率界值是

- A. 心室率<50次/分或>100次/分
- **B. 心室率<40次/分或>130次/分** ✅
- C. 心室率<60次/分或>120次/分
- D. 心室率<30次/分或>150次/分
- E. 与心率快慢无明确关系

答案：B

> 解析：【正确答案】各种原因导致的心动过缓（心室率小于 40 次/分）和快速性室性心律失常（心率大于 130 次/分）均可引起急性脑缺血而发生晕厥；心源性晕厥常无先兆，伴心悸、胸痛，可致猝死。
>
> 【逐项解析】A. 50/100 次/分不是心源性晕厥的典型界值，阈值偏低。（错误）
> B. <40 次/分或>130 次/分，符合教材。（正确）
> C. 60/120 次/分更接近一般心率异常，不是晕厥的高危界值。（错误）
> D. 30/150 次/分过于极端，会漏掉部分高危病人。（错误）
> E. 心源性晕厥与心率/心律密切相关，不能说无关。（错误）
>
> 【易错点】心源性晕厥记“慢于 40、快于 130”。

---

162. [A1型题｜理解] batch043-M07-A1-006

> 模块：M07｜页码：教材P50-51

下列最能提示支气管哮喘急性发作病情危重的是

- **A. 哮鸣音减弱乃至消失** ✅
- B. 双肺满布哮鸣音
- C. 胸片示肺充气过度
- D. 呼气峰流速下降
- E. 心率100次/分

答案：A

> 解析：【正确答案】哮喘危重时，由于气流严重受限，哮鸣音反而减弱乃至消失，出现“沉默肺”，是病情恶化的危险信号；双肺满布哮鸣音、肺充气过度、PEF 下降可见于中度发作，不能单独提示危重。
>
> 【逐项解析】A. 哮鸣音减弱乃至消失提示气流极度受限，是危重信号。（正确）
> B. 双肺满布哮鸣音说明气道痉挛明显，但不一定达到危重。（错误）
> C. 肺充气过度是哮喘常见表现，不能单独提示危重。（错误）
> D. PEF 下降可见于各程度发作，需结合数值判断。（错误）
> E. 心率 100 次/分仅轻度增快，危重时常>120 次/分。（错误）
>
> 【易错点】哮喘危重记“沉默肺”：哮鸣音消失比满肺哮鸣更可怕。

---

163. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-007

> 模块：M07｜页码：教材P59-60

急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的氧合指数（PaO2/FiO2）标准是

- A. ≤400mmHg
- **B. ≤300mmHg** ✅
- C. ≤200mmHg
- D. ≤100mmHg
- E. ≥300mmHg

答案：B

> 解析：【正确答案】ARDS 的诊断要点为急性起病、双肺浸润影、氧合指数 PaO2/FiO2≤300mmHg，且排除心源性肺水肿。机械通气采用小潮气量 6～8ml/kg、平台压 <30cmH2O，并限制液体入量。
>
> 【逐项解析】A. ≤400mmHg 过宽，会把部分非 ARDS 的低氧病人纳入。（错误）
> B. PaO2/FiO2≤300mmHg 是 ARDS 的氧合标准。（正确）
> C. ≤200mmHg 是中度 ARDS 的范围，不是诊断总阈值。（错误）
> D. ≤100mmHg 是重度 ARDS，不能代表全部。（错误）
> E. ≥300mmHg 不符合 ARDS 的低氧程度。（错误）
>
> 【易错点】ARDS 记“P/F≤300、双肺浸润、非心源性”。

---

164. [A1型题｜理解] batch043-M07-A1-008

> 模块：M07｜页码：教材P57

肺血栓栓塞症的栓子最主要来源于

- **A. 下肢深静脉血栓** ✅
- B. 左心房附壁血栓
- C. 主动脉粥样斑块
- D. 肺动脉原位血栓
- E. 上肢浅静脉血栓

答案：A

> 解析：【正确答案】肺血栓栓塞症的栓子约 70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主，盆腔静脉血栓是女性肺栓塞的重要来源；少数来自右心。诊断首选 CT 肺动脉造影。
>
> 【逐项解析】A. 70%～90% 的栓子来自深静脉血栓，下肢深静脉为主，正确。（正确）
> B. 左心房附壁血栓多导致体循环动脉栓塞（如脑栓塞），不是肺栓塞主源。（错误）
> C. 主动脉斑块脱落导致动脉栓塞，不进入肺动脉。（错误）
> D. 肺动脉原位血栓形成较少见，不是最主要来源。（错误）
> E. 上肢浅静脉血栓脱落风险远低于下肢深静脉。（错误）
>
> 【易错点】肺栓塞栓子记“下肢深静脉为主，盆腔静脉女性重要”。

---

165. [A2型题｜应用] batch043-M07-A2-001

> 模块：M07｜页码：教材P89-90

男，60 岁，持续胸痛 2 小时，心电图示 V1～V4 导联 ST 段抬高，诊断急性前壁心肌梗死。所在医院具备 PCI 条件，预计 90 分钟内可完成 PCI。最恰当的处理是

- A. 立即静脉溶栓
- **B. 首选直接PCI** ✅
- C. 先抗凝观察24小时
- D. 仅给硝酸甘油等待PCI
- E. 立即冠脉搭桥

答案：B

> 解析：【正确答案】STEMI 病人若预计 120 分钟内可转运至有 PCI 条件的医院并完成 PCI，首选直接 PCI；直接 PCI 的血管开通率与预后优于溶栓。溶栓适用于无 PCI 条件且发病 12 小时内的病人。
>
> 【逐项解析】A. 本例具备 PCI 条件且能在 120 分钟内完成，直接 PCI 优于溶栓。（错误）
> B. 预计 120 分钟内可完成 PCI，首选直接 PCI，符合指南。（正确）
> C. STEMI 需立即再灌注，观察 24 小时会扩大梗死范围。（错误）
> D. 硝酸甘油只能缓解症状，不能开通闭塞血管。（错误）
> E. 急诊搭桥仅用于特定解剖或不适合 PCI 的病人，不是首选。（错误）
>
> 【易错点】STEMI 再灌注记“能 120 分钟内 PCI 就 PCI，否则 12 小时内溶栓”。

---

166. [A2型题｜应用] batch043-M07-A2-002

> 模块：M07｜页码：教材P52

女，28 岁，哮喘急性发作，端坐呼吸，只能讲单个字，大汗淋漓，呼吸 34 次/分，心率 128 次/分，SaO2 88%。最恰当的处理是

- **A. 吸氧SaO2>92%+SABA+激素** ✅
- B. 仅口服茶碱缓释片治疗
- C. 立即静脉推注镇静药
- D. 给予纯氧吸入提高SaO2
- E. 先做支气管激发试验

答案：A

> 解析：【正确答案】病人休息时气短、端坐呼吸、单字讲话、大汗、呼吸>30 次/分、心率>120 次/分、SaO2≤90%，属于重症哮喘。处理为大流量吸氧使 SaO2>92%，雾化短效β2受体激动剂（可联合 SAMA）、全身糖皮质激素，必要时无创/有创机械通气。
>
> 【逐项解析】A. 氧疗+SABA+全身激素、必要时通气，符合重症哮喘处理。（正确）
> B. 茶碱起效慢、治疗窗窄，不能作为重症哮喘的首选。（错误）
> C. 镇静药仅在机械通气时使用，清醒病人可抑制呼吸。（错误）
> D. 不宜给纯氧，可致 PaCO2 升高；目标 SaO2>92% 即可。（错误）
> E. 急性发作期做激发试验危险且无意义；把诊断试验置于治疗之前。（错误）
>
> 【易错点】重症哮喘：氧疗到 92% 以上、SABA+激素，必要时插管。

---

167. [A3型题｜应用] batch043-M07-A3-001

> 模块：M07｜页码：教材P55-56

该病人最可能的诊断是

- **A. 急性左心衰竭** ✅
- B. 支气管哮喘
- C. 自发性气胸
- D. 肺栓塞
- E. 急性心包炎

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有心脏病史，夜间突发端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰，双肺湿啰音、心率130～140 次/分、心尖区舒张期奔马律，符合急性左心衰伴肺水肿。
>
> 【逐项解析】A. 端坐呼吸、粉红泡沫痰、湿啰音、奔马律，符合急性左心衰。（正确）
> B. 哮喘以呼气性呼吸困难和哮鸣音为主，无粉红泡沫痰。（错误）
> C. 气胸表现为患侧呼吸音消失、叩诊鼓音，不是双肺湿啰音。（错误）
> D. 肺栓塞突发呼吸困难伴胸痛、低氧，肺部体征常不明显。（错误）
> E. 心包炎以胸痛、心包摩擦音为主，不会咳粉红泡沫痰。（错误）
>
> 【易错点】粉红泡沫痰+双肺湿啰音+奔马律＝急性左心衰。

---

168. [A3型题｜分析] batch043-M07-A3-002

> 模块：M07｜页码：教材P56-57

该病人的首选处理是

- **A. 端坐吸氧+呋塞米20～40mg** ✅
- B. 平卧位、快速大量补液
- C. 立即静脉推注β受体阻滞剂
- D. 立即口服大量温水
- E. 立即行气管切开术

答案：A

> 解析：【正确答案】急性左心衰伴肺水肿的处理为端坐位、双腿下垂减少回心血量，高流量吸氧（必要时无创通气），呋塞米 20～40mg 静脉注射利尿，硝酸甘油舌下/静滴扩血管；平卧大量补液会加重肺水肿。
>
> 【逐项解析】A. 端坐位、腿下垂、吸氧+呋塞米，是急性左心衰肺水肿的标准处理。（正确）
> B. 平卧大量补液会增加回心血量，加重肺水肿。（错误）
> C. 急性肺水肿时β受体阻滞剂可抑制心肌收缩，不宜立即静推。（错误）
> D. 口服大量温水会增加容量负荷，加重肺水肿。（错误）
> E. 气管切开用于上气道梗阻，不是肺水肿的首选。（错误）
>
> 【易错点】急性左心衰：坐起来、腿下垂、吸氧、利尿、扩血管。

---

169. [判断题｜理解] batch043-M07-JUD-001

> 模块：M07｜页码：教材P59-60

ARDS 的诊断需要排除心源性肺水肿，且氧合指数 PaO2/FiO2≤300mmHg。

- **A. 正确** ✅
- B. 错误

答案：A

> 解析：【正确答案】ARDS 的诊断要点包括急性起病、双肺浸润影、氧合指数 PaO2/FiO2≤300mmHg，并且必须排除心源性肺水肿（如左心衰）。心源性肺水肿有心脏病史、端坐呼吸、BNP 升高、利尿有效等特点。
>
> 【逐项解析】A. ARDS 需排除心源性肺水肿且 P/F≤300，叙述正确。（正确）
> B. 把正确诊断标准判为错误，说明未掌握 ARDS 的排除性条件。（错误）
>
> 【易错点】ARDS 三步：急性双肺浸润、P/F≤300、排除心源性。

---

170. [X型题｜理解] batch043-M07-X-001

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

关于高血压急症的降压治疗，下列叙述正确的有

- **A. 需立即降压，但不宜立即降至正常水平** ✅
- **B. 主动脉夹层目标收缩压100～110mmHg** ✅

- **C. 高血压合并脑出血维持收缩压130～180mmHg** ✅
- **D. 降压应从小剂量开始，避免降压过快** ✅
- E. 所有高血压急症均应快速降至120/80mmHg以下

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】高血压急症需立即降压但不宜立即降至正常，应从小剂量开始、避免降压过快；主动脉夹层目标收缩压 100～110mmHg；高血压合并脑出血维持收缩压 130～180mmHg。把所有急症都快速降到 120/80 以下会导致脑、肾灌注不足。
>
> 【逐项解析】A. 立即降压但不清零，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 主动脉夹层目标 100～110mmHg，叙述正确。（正确）
> C. 脑出血维持 130～180mmHg，叙述正确。（正确）
> D. 从小剂量开始、避免过快，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. 所有急症统一降到 120/80 以下会导致灌注不足，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】高血压急症降压记“快慢有别、目标因病而异”。

---

171. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-009

> 模块：M07｜页码：教材P203

社区获得性肺炎（CAP）的时间定义是

- **A. 院外肺实质感染，入院48h内** ✅
- B. 入院7天后发生的肺炎
- C. 长期卧床病人发生的肺炎
- D. 气管插管后48小时内发生的肺炎
- E. 任何时间发生的肺部感染

答案：A

> 解析：【正确答案】社区获得性肺炎指在医院外罹患的肺实质急性感染，包括由于其他原因入院但具有社区病原体潜伏、并在入院后短期（小于 48 小时）内发病的肺炎；入院 48 小时后新发的肺炎多归为医院获得性肺炎。
>
> 【逐项解析】A. 院外罹患、入院 48 小时内发病，是 CAP 的时间定义。（正确）
> B. 入院 7 天后发生更符合医院获得性肺炎，不是 CAP。（错误）
> C. 长期卧床本身不是定义，需看感染发生的地点与时间。（错误）
> D. 气管插管后 48 小时内发生的肺炎属于呼吸机相关性肺炎。（错误）
> E. 任何时间发生的肺部感染范围过宽，无法区分社区与医院获得。（错误）
>
> 【易错点】CAP 记“院外罹患 + 入院 48 小时内发病”。

---

172. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-010

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

高血压急症合并主动脉夹层时，降压的目标收缩压是

- **A. 100～110mmHg** ✅
- B. 120～130mmHg
- C. 130～140mmHg
- D. 140～150mmHg
- E. 160～170mmHg

答案：A

> 解析：【正确答案】主动脉夹层时的高血压会加速夹层撕裂，需迅速降压至收缩压 100～110mmHg，在保证器官灌注的前提下降低主动脉壁张力；同时合用β受体阻滞剂控制心率。
>
> 【逐项解析】A. 收缩压 100～110mmHg 是主动脉夹层的目标。（正确）
> B. 120～130mmHg 仍偏高，夹层撕裂风险未充分控制。（错误）
> C. 130～140mmHg 适用于多数高血压急症，不是夹层。（错误）
> D. 140～150mmHg 对夹层而言过高。（错误）
> E. 160～170mmHg 远未达标，夹层可继续撕裂。（错误）
>
> 【易错点】夹层记“收缩压 100～110”，比一般高血压急症更激进。

---

173. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-011

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

高血压合并脑出血时，血压应维持在

- A. 收缩压100～110mmHg
- **B. 收缩压130～180mmHg** ✅
- C. 收缩压180～200mmHg
- D. 舒张压120mmHg以上
- E. 血压降得越低越好

答案：B

> 解析：【正确答案】高血压合并脑出血时，既要防止血压过高加重出血，又要保证脑灌注，指南与教材口径为维持收缩压 130～180mmHg；降压过快过低会加重脑缺血。
>
> 【逐项解析】A. 100～110mmHg 过低，脑灌注不足。（错误）
> B. 收缩压 130～180mmHg 是脑出血的维持范围。（正确）
> C. 180～200mmHg 过高，再出血风险增加。（错误）
> D. 舒张压 120mmHg 以上明显过高；只盯收缩压。（错误）
> E. 血压过低会加重脑缺血，不是越低越好；把降压绝对化。（错误）
>
> 【易错点】脑出血记“收缩压 130～180”，既止血又保灌注。

---

174. [A1型题｜记忆] batch043-M07-A1-012

> 模块：M07｜页码：教材P57-59

怀疑急性肺栓塞时，确诊首选的检查是

- **A. CT肺动脉造影** ✅
- B. 胸部X线片
- C. 心电图检查
- D. D-二聚体检测
- E. 肺动脉造影检查

答案：A

> 解析：【正确答案】CT 肺动脉造影是诊断肺栓塞的首选检查，可直接显示肺动脉内的充盈缺损；D-二聚体阴性有排除价值但特异性低，胸部 X 线片与心电图只能提供间接线索。
>
> 【逐项解析】A. CT 肺动脉造影是肺栓塞的首选确诊检查。（正确）
> B. 胸片多正常或仅有非特异改变，不能确诊；把筛查当确诊。（错误）
> C. 心电图可见右心负荷表现，但无特异性；把辅助检查当确诊。（错误）
> D. D-二聚体特异性低，阳性不能确诊；把排除指标当确诊指标。（错误）
> E. 肺动脉造影是有创检查，已非常规首选；把有创检查当首选。（错误）
>
> 【易错点】肺栓塞确诊记 CTPA；D-二聚体只用于排除。

---

175. [A2型题｜应用] batch043-M07-A2-003

> 模块：M07｜页码：教材P57-59

女，55 岁，髋关节置换术后第 5 天，起床时突发胸痛、呼吸困难、晕厥，血压 90/60mmHg，血氧饱和度 88%。最可能的诊断是

- **A. 急性肺栓塞** ✅
- B. 急性心肌梗死
- C. 自发性气胸
- D. 社区获得性肺炎
- E. 急性心包炎

答案：A

> 解析：【正确答案】病人有髋关节置换（深静脉血栓高危）病史，术后第 5 天突发胸痛、呼吸困难、晕厥并低氧、低血压，最符合急性肺栓塞；肺栓塞栓子 70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主。
>
> 【逐项解析】A. 术后卧床加突发胸痛、呼吸困难、低氧，最符合肺栓塞。（正确）
> B. 心梗多有压榨性胸痛与心电图改变，术后卧床史更支持肺栓塞。（错误）
> C. 气胸多有患侧呼吸音消失，本例无相关描述。（错误）
> D. 肺炎多有发热、咳嗽、咳痰，起病不如本例急骤。（错误）
> E. 心包炎多有体位相关性胸痛与心包摩擦音；把胸痛当心包炎。（错误）
>
> 【易错点】术后卧床＋突发胸痛呼吸困难＋低氧＝先想肺栓塞。

---

176. [A2型题｜应用] batch043-M07-A2-004

> 模块：M07｜页码：教材P59-61

男，40 岁，重症肺炎并发 ARDS，氧合指数 150mmHg，准备机械通气。应设置的潮气量是

- A. 4～5ml/kg
- **B. 6～8ml/kg** ✅
- C. 10～12ml/kg
- D. 12～15ml/kg
- E. 15ml/kg以上

答案：B

> 解析：【正确答案】ARDS 采用肺保护性通气：潮气量 6～8ml/kg 理想体重，气道平台压 <30cmH2O，维持 SpO2>90%，并限制液体入量 <2000ml/d，以减少呼吸机相关肺损伤与肺水肿。
>
> 【逐项解析】A. 4～5ml/kg 过低，易致通气不足与二氧化碳潴留。（错误）
> B. 6～8ml/kg 是 ARDS 的肺保护性潮气量。（正确）
> C. 10～12ml/kg 已属高潮气量，加重肺损伤。（错误）
> D. 12～15ml/kg 明显过高，易致气压伤。（错误）
> E. 15ml/kg 以上严重违反肺保护原则。（错误）
>
> 【易错点】ARDS 记“小潮气量 6～8、平台压<30、液体<2000”。

---

177. [A3型题｜应用] batch043-M07-A3-003

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

该病人的病情应判断为

- **A. 高血压急症** ✅
- B. 高血压亚急症
- C. 白大衣高血压
- D. 慢性高血压
- E. 低血压反应

答案：A

> 解析：【正确答案】病人收缩压 >180mmHg、舒张压 >120mmHg，并出现意识模糊、视乳头水肿、蛋白尿等急性进行性靶器官损害，符合高血压急症；仅有血压升高而无靶器官损害者才归为亚急症。
>
> 【逐项解析】A. 血压>180/120 加急性靶器官损害，符合高血压急症。（正确）
> B. 亚急症无急性进行性靶器官损害，本例已有。（错误）
> C. 白大衣高血压无靶器官损害，血压也不会如此高。（错误）
> D. 慢性高血压不能解释急性意识障碍与视乳头水肿。（错误）
> E. 本例为明显高血压，不是低血压反应；把方向弄反。（错误）
>
> 【易错点】高血压急症＝血压>180/120＋急性靶器官损害，两者缺一不可。

---

178. [A3型题｜分析] batch043-M07-A3-004

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

关于该病人的降压，正确的原则是

- A. 立即降至正常水平
- **B. 迅速降压但不宜立即正常** ✅
- C. 暂不降压，先观察
- D. 仅口服降压药即可
- E. 先大量补液再降压

答案：B

> 解析：【正确答案】高血压急症需立即降压，但不宜立即降至正常：短时间内血压骤降会导致脑、心、肾灌注不足。应按靶器官损害类型设定目标（如主动脉夹层 100～110mmHg、脑出血 130～180mmHg），在监测下逐步达标。
>
> 【逐项解析】A. 立即降至正常会造成器官低灌注，是错误做法。（错误）
> B. 立即降压但不宜立即正常，是高血压急症的原则。（正确）
> C. 不降压会继续加重靶器官损害；把急症当观察对象。（错误）
> D. 口服药起效慢，急症需静脉用药；把慢病用药用于急症。（错误）
> E. 大量补液会进一步升高血压，加重脑水肿；用补液代替降压。（错误）
>
> 【易错点】高血压急症记“要降、但要稳”：先降 20%～25%，按靶器官定目标。

---

179. [判断题｜理解] batch043-M07-JUD-002

> 模块：M07｜页码：教材P82-83

高血压急症病人应在数分钟内将血压迅速降至正常范围，以尽快保护靶器官。

- A. 正确
- **B. 错误** ✅

答案：B

> 解析：【正确答案】高血压急症需立即降压，但不宜立即降至正常。短时间内血压骤降至正常会导致脑、心、肾灌注不足，甚至诱发脑梗死或心肌缺血；应结合靶器官损害设定目标，在监测下逐步达标。
>
> 【逐项解析】A. 立即降至正常会造成器官低灌注，原句错误。（错误）
> B. 应逐步降压并设定个体化目标，故原句错误。（正确）
>
> 【易错点】高血压急症：降得快不等于降得低，目标是“部分降压”。

---

180. [X型题｜理解] batch043-M07-X-002

> 模块：M07｜页码：教材P87-90

关于急性冠脉综合征（ACS），下列叙述正确的有

- **A. 包括不稳定型心绞痛** ✅
- **B. 包括非ST段抬高型心梗** ✅
- **C. 包括ST段抬高型心梗** ✅
- **D. 心肌肌钙蛋白>99thULN** ✅
- E. 所有ACS均应首选溶栓

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】ACS 包括不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死与 ST 段抬高型心肌梗死；心肌肌钙蛋白 >99th ULN 是心肌损伤的标志。STEMI 预计 120 分钟内可完成 PCI 者首选直接 PCI，溶栓仅用于无 PCI 条件且发病 12 小时内，并非所有 ACS 都溶栓。
>
> 【逐项解析】A. 不稳定型心绞痛属于 ACS，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. NSTEMI 属于 ACS，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. STEMI 属于 ACS，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. 肌钙蛋白>99th ULN 提示心肌损伤，叙述正确。（正确）
> E. 并非所有 ACS 都溶栓，NSTEMI 不常规溶栓，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】ACS 三兄弟：不稳定心绞痛、NSTEMI、STEMI；只有部分 STEMI 需溶栓。

M08（20题）

181. [A1型题｜理解] batch043-M08-A1-001

> 模块：M08｜页码：教材P101

提示重症急性胰腺炎的特征性体征是

- A. Murphy征阳性
- **B. Grey-Turner征** ✅
- C. 麦氏点明显压痛
- D. 板状腹伴肝浊音界消失
- E. 移动性浊音阴性

答案：B

> 解析：【正确答案】重症急性胰腺炎可出现腰部皮肤青紫（Grey-Turner 征）与脐部皮肤青紫（Cullen 征），提示腹膜后出血沿筋膜间隙渗透；同时可有腹膜炎体征、休克，血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示重症。
>
> 【逐项解析】A. Murphy 征阳性提示急性胆囊炎，不是胰腺炎的特征体征。（错误）
> B. Grey-Turner 征与 Cullen 征是重症胰腺炎的特征性体征。（正确）
> C. 麦氏点压痛提示急性阑尾炎，不是胰腺炎；把阑尾炎体征套过来。（错误）
> D. 板状腹伴肝浊音界消失提示消化道穿孔；把穿孔体征套到胰腺炎。（错误）
> E. 移动性浊音阴性不能提示重症胰腺炎，腹水时可为阳性。（错误）
>
> 【易错点】胰腺炎记“腰部青紫 Grey-Turner、脐周青紫 Cullen”。

---

182. [A1型题｜理解] batch043-M08-A1-002

> 模块：M08｜页码：教材P36-37

糖尿病酮症酸中毒（DKA）病人，下列提示重度的是

- **A. HCO3-<5或昏迷** ✅
- B. 血糖11.1mmol/L
- C. 尿酮体呈阳性
- D. 动脉血呈正常pH
- E. 血钾4.0mmol/L

答案：A

> 解析：【正确答案】DKA 分为轻、中、重度，重度 DKA 在严重酸中毒基础上伴意识障碍，或虽无意识障碍但血清 HCO3-小于 5mmol/L。血糖≥11.1mmol/L、尿酮阳性是 DKA 的诊断条件，不是重度标准。
>
> 【逐项解析】A. HCO3-<5mmol/L 或意识障碍提示重度 DKA，正确。（正确）
> B. 血糖≥11.1mmol/L 只是 DKA 的诊断门槛，不能区分轻重。（错误）
> C. 尿酮阳性是 DKA 的共同特征，各度均可出现。（错误）
> D. pH 7.35 在正常范围，不符合重度酸中毒。（错误）
> E. 血钾 4.0mmol/L 在正常范围，不能提示重度。（错误）
>
> 【易错点】重度 DKA 记“HCO3-<5 或昏迷”。

---

183. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-003

> 模块：M08｜页码：教材P39

高渗高血糖综合征（HHS）的血糖诊断标准是

- A. ≥11.1mmol/L
- **B. ≥33.3mmol/L** ✅
- C. ≥22.2mmol/L
- D. ≥16.7mmol/L
- E. ≥7.0mmol/L

答案：B

> 解析：【正确答案】HHS 的血糖诊断标准为≥33.3mmol/L，同时有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)、尿酮阴性或弱阳性、神志木僵或昏迷；11.1mmol/L 是 DKA 的血糖门槛，不是 HHS 的标准。
>
> 【逐项解析】A. ≥11.1mmol/L 是 DKA 的血糖门槛，达不到 HHS 的高血糖程度。（错误）
> B. ≥33.3mmol/L 是 HHS 的血糖标准。（正确）
> C. ≥22.2mmol/L 虽明显升高，但仍未达到 HHS 的 33.3 标准。（错误）
> D. ≥16.7mmol/L 不足以诊断 HHS。（错误）
> E. ≥7.0mmol/L 仅为空腹血糖升高，远未达到 HHS。（错误）
>
> 【易错点】HHS 血糖记 33.3mmol/L，渗透压记 320mOsm/(kg·H2O)。

---

184. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-004

> 模块：M08｜页码：教材P29

缺血性脑卒中静脉溶栓的时间窗及 rt-PA 剂量是

- **A. 3～4.5h，rt-PA0.9mg/kg** ✅
- B. 6～12h，rt-PA1.5mg/kg
- C. 24h内尿激酶50万IU
- D. 发病3天内，阿司匹林300mg
- E. 1周内rt-PA0.5mg/kg

答案：A

> 解析：【正确答案】缺血性卒中静脉溶栓时间窗为发病 3～4.5 小时内使用 rt-PA，剂量 0.9mg/kg（最大 90mg），其中 10% 在 1 分钟内静推、其余 60 分钟内静滴；或 6 小时内使用尿激酶 100 万～150 万 IU。
>
> 【逐项解析】A. 3～4.5 小时、0.9mg/kg（最大 90mg）是 rt-PA 的标准方案。（正确）
> B. 6～12 小时已超过 rt-PA 静脉溶栓窗，剂量也不对。（错误）
> C. 24 小时超过静脉溶栓窗，尿激酶剂量也不足。（错误）
> D. 阿司匹林不是溶栓药，3 天时间窗也不对。（错误）
> E. 1 周远超溶栓窗，0.5mg/kg 剂量也不足。（错误）
>
> 【易错点】卒中溶栓记“3～4.5 小时、0.9mg/kg、最大 90mg”。

---

185. [A2型题｜应用] batch043-M08-A2-001

> 模块：M08｜页码：教材P116-120

男，25 岁，节律性上腹隐痛 3 年，加重 2 天。10 天前开始解黑便 3 次，量约 1000g，血压 68/45mmHg，脉率 120 次/分，Hb 90g/L。首选的治疗是

- A. 大量输液
- B. 输右旋糖酐
- C. 外科手术
- D. 急诊内镜止血
- **E. 输血、补液** ✅

答案：E

> 解析：【正确答案】病人有消化性溃疡病史，出现黑便约 1000g、血压 68/45mmHg、脉率 120 次/分，已处失血性休克，首要治疗是输血、补液纠正低血容量，稳定生命体征后再行急诊内镜止血；不能先手术或只用右旋糖酐。
>
> 【逐项解析】A. 单纯大量输液不能补充携氧能力，休克仍需输血。（错误）
> B. 右旋糖酐是血浆代用品，不能替代红细胞携氧，且可干扰凝血。（错误）
> C. 休克未纠正时手术风险极高，应先复苏与内镜止血。（错误）
> D. 急诊内镜止血重要，但必须在血流动力学稳定后进行。（错误）
> E. 输血、补液纠正失血性休克是首要治疗；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
>
> 【易错点】上消化道大出血先复苏（输血补液），稳定后 12～24 小时内镜。

---

186. [A2型题｜应用] batch043-M08-A2-002

> 模块：M08｜页码：教材P34-36

女，70 岁，糖尿病，口服格列本脲。今晨被发现呼之不应，血糖 1.9mmol/L。最恰当的处理是

- A. 立即口服葡萄糖水溶液
- **B. 50%葡萄糖40～60ml静脉推注** ✅
- C. 立即静脉推注胰岛素
- D. 立即静脉推注甘露醇
- E. 立即行经口气管插管

答案：B

> 解析：【正确答案】病人血糖 1.9mmol/L 且昏迷，诊断低血糖昏迷；昏迷者禁止口服补糖（误吸风险），应立即静脉推注 50% 葡萄糖 40～60ml，随后持续葡萄糖输注并复测血糖。磺脲类所致低血糖易复发，需观察 24～48 小时。
>
> 【逐项解析】A. 昏迷者口服补糖易误吸，禁忌；把清醒者的补糖方式套到昏迷。（错误）
> B. 50% 葡萄糖 40～60ml 静推，是低血糖昏迷的标准处理。（正确）
> C. 胰岛素会进一步降低血糖，方向完全相反；把降糖药当成升糖药。（错误）
> D. 甘露醇用于脑水肿，不是低血糖的首选；把脱水剂当成升糖措施。（错误）
> E. 病人昏迷但呼吸存在，气管插管不是首选；把气道处理提前。（错误）
>
> 【易错点】低血糖昏迷：禁口服、50% 葡萄糖 40～60ml 静推、续葡糖。

---

187. [判断题｜理解] batch043-M08-JUD-001

> 模块：M08｜页码：教材P27

蛛网膜下腔出血起病急骤，常有明显脑膜刺激征，但很少出现局限性神经系统体征。

- **A. 正确** ✅
- B. 错误

答案：A

> 解析：【正确答案】蛛网膜下腔出血起病急骤，表现为剧烈头痛、呕吐、一过性意识障碍，有明显脑膜刺激征而很少出现局限性神经系统体征；脑出血则常先出现偏瘫等局灶体征，待血液破入蛛网膜下腔才出现脑膜刺激征。
>
> 【逐项解析】A. 明显脑膜刺激征、局灶体征少，符合 SAH，叙述正确。（正确）
> B. 把 SAH 的特点判为错误，容易与脑出血混淆。（错误）
>
> 【易错点】SAH 记“脑膜刺激征明显、局灶体征少”；脑出血相反。

---

188. [X型题｜理解] batch043-M08-X-001

> 模块：M08｜页码：教材P40

关于糖尿病酮症酸中毒（DKA）与高渗高血糖综合征（HHS）的鉴别，下列正确的有

- **A. DKA血糖≥11.1mmol/L，HHS血糖≥33.3mmol/L** ✅
- **B. DKA动脉血pH<7.3，HHSpH≥7.3** ✅
- **C. DKA尿酮阳性，HHS尿酮阴性或弱阳性** ✅
- **D. HHS有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)** ✅
- E. HHS以酮症酸中毒为主要特征

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】DKA 与 HHS 的鉴别要点：DKA 血糖≥11.1mmol/L、pH<7.3、HCO3-<18mmol/L、尿酮阳性、渗透压不定；HHS 血糖≥33.3mmol/L、pH≥7.3、HCO3-≥18mmol/L、尿酮阴性或弱阳性、有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)，以高渗和脱水为主而非酮症。
>
> 【逐项解析】A. 血糖界值 11.1 与 33.3 的区分正确。（正确）
> B. pH<7.3 与≥7.3 的区分正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 尿酮阳性与阴性/弱阳性的区分正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> D. HHS 渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)，正确。（正确）
> E. HHS 以高渗、脱水为主，不以酮症酸中毒为主要特征，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】DKA 与 HHS 五项鉴别：血糖、pH、HCO3-、尿酮、渗透压。

---

189. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-005

> 模块：M08｜页码：教材P116-122

按教师口径，上消化道大出血指一次出血量超过

- A. 400ml
- B. 600ml
- **C. 800ml** ✅
- D. 1000ml
- E. 1500ml

答案：C

> 解析：【正确答案】教师口径的上消化道大出血为出血量 >800ml；教材口径为超过 1000ml 或血容量减少 20% 以上可危及生命。两个口径都要记住，答题时看清题干问的是哪一种。
>
> 【逐项解析】A. 400ml 属少量出血，不足以称大出血。（错误）
> B. 600ml 仍低于教师口径的 800ml。（错误）
> C. 800ml 是教师口径的上消化道大出血界值。（正确）
> D. 1000ml 是教材口径，不是教师口径。（错误）
> E. 1500ml 已属更大量出血，不是界值。（错误）
>
> 【易错点】上消化道大出血两个口径：教师 800ml、教材 1000ml（或血容量↓20%）。

---

190. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-006

> 模块：M08｜页码：教材P116-122

上消化道大出血最常见的病因是

- **A. 消化性溃疡** ✅
- B. 食管胃底静脉曲张
- C. 急性胃黏膜病变
- D. 胃癌出血
- E. 食管贲门黏膜撕裂

答案：A

> 解析：【正确答案】上消化道大出血最常见病因是消化性溃疡，其次为食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变和胃癌；门脉高压病人出血则多以食管胃底静脉曲张破裂为主。
>
> 【逐项解析】A. 消化性溃疡是上消化道大出血最常见的病因。（正确）
> B. 食管胃底静脉曲张是第二位常见病因，多见于肝硬化。（错误）
> C. 急性胃黏膜病变多与药物、应激相关，居第三位。（错误）
> D. 胃癌可引起出血，但发生率低于溃疡；把肿瘤当最常见。（错误）
> E. 贲门黏膜撕裂多在剧烈呕吐后，属少见病因。（错误）
>
> 【易错点】上消化道出血病因排序：溃疡＞静脉曲张＞急性胃黏膜病变＞胃癌。

---

191. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-007

> 模块：M08｜页码：教材P116-122

上消化道大出血的高危病人，应在多长时间内完成急诊内镜

- A. 6小时内
- **B. 12小时内** ✅
- C. 24小时内
- D. 48小时内
- E. 72小时内

答案：B

> 解析：【正确答案】对存在高危征象的上消化道出血病人，应在 12 小时内完成急诊内镜，以明确出血部位、评估再出血风险并进行内镜下止血；过早需先稳定生命体征，过晚则再出血与死亡风险增加。
>
> 【逐项解析】A. 6 小时内更早，但教材口径是 12 小时内。（错误）
> B. 12 小时内急诊内镜是高危病人的时限；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 24 小时已超过高危病人的推荐时限；把时限放宽。（错误）
> D. 48 小时明显过晚，再出血风险增加；按普通内镜预约。（错误）
> E. 72 小时已失去急诊内镜的意义；把急诊当择期。（错误）
>
> 【易错点】高危上消化道出血记“先复苏、12 小时内镜”。

---

192. [A1型题｜理解] batch043-M08-A1-008

> 模块：M08｜页码：教材P101

急性胰腺炎病人出现下列哪项提示重症

- **A. 血钙<2.0mmol/L** ✅
- B. 血钙>2.5mmol/L
- C. 血糖<6.1mmol/L
- D. 血淀粉酶轻度升高
- E. 白细胞计数正常

答案：A

> 解析：【正确答案】急性胰腺炎时血钙 <2.0mmol/L、血糖 >11.1mmol/L 提示重症，反映胰腺广泛坏死与脂肪皂化消耗钙；此外腹膜炎体征、休克、Grey-Turner 征与 Cullen 征也提示重症。
>
> 【逐项解析】A. 血钙<2.0mmol/L 提示重症胰腺炎。（正确）
> B. 血钙>2.5mmol/L 属正常，不提示重症。（错误）
> C. 血糖<6.1mmol/L 属正常，不提示重症。（错误）
> D. 淀粉酶轻度升高只见于轻症或非胰腺疾病；把轻症指标当重症。（错误）
> E. 白细胞正常不支持重症感染与炎症反应；把正常指标当重症。（错误）
>
> 【易错点】重症胰腺炎记“低钙<2.0、高糖>11.1、Grey-Turner/Cullen”。

---

193. [A1型题｜理解] batch043-M08-A1-009

> 模块：M08｜页码：教材P36-38

糖尿病酮症酸中毒的治疗核心是

- **A. 补液+小剂量胰岛素+纠正电解质** ✅
- B. 大剂量胰岛素快速降糖
- C. 单纯静脉补碱纠正酸中毒
- D. 先大量补碱再补液
- E. 立即给予大量利尿

答案：A

> 解析：【正确答案】DKA 治疗为补液、小剂量胰岛素静脉滴注、纠正电解质（尤其补钾）三项并举；补液是首要措施，胰岛素宜小剂量持续给药，补碱仅在重度酸中毒时谨慎使用，快速大剂量降糖易致脑水肿与低钾。
>
> 【逐项解析】A. 补液、小剂量胰岛素、纠正电解质是 DKA 治疗核心。（正确）
> B. 大剂量胰岛素会使血糖骤降，诱发脑水肿与低钾。（错误）
> C. 单纯补碱不能纠正脱水与酮症，且可能加重低钾。（错误）
> D. 先大量补碱会掩盖病情并加重电解质紊乱；把补碱置于补液之前。（错误）
> E. 利尿会加重脱水与低钾，DKA 不宜；把少尿当利尿指征。（错误）
>
> 【易错点】DKA 记“先补液、小剂量胰岛素、补钾”，不追求快速降糖。

---

194. [A1型题｜记忆] batch043-M08-A1-010

> 模块：M08｜页码：教材P34-36

低血糖的 Whipple 三联征不包括

- A. 低血糖症状
- B. 发作时血糖降低
- C. 补糖后症状缓解
- **D. 血糖升高后症状加重** ✅
- E. 交感神经兴奋表现

答案：D

> 解析：【正确答案】Whipple 三联征包括低血糖症状、发作时血糖降低、补糖后症状迅速缓解。血糖升高后症状加重不符合低血糖，而是高血糖表现，故不属于三联征。
>
> 【逐项解析】A. 低血糖症状是三联征的第一条，原叙述正确。（错误）
> B. 发作时血糖降低是三联征的核心，原叙述正确。（错误）
> C. 补糖后症状缓解是三联征的验证环节，原叙述正确。（错误）
> D. 血糖升高后症状加重是高血糖表现，不属于三联征。（正确）
> E. 交感神经兴奋属于低血糖症状的一部分，原叙述正确。（错误）
>
> 【易错点】Whipple 三联征：有症状、血糖低、补糖就好，三条缺一不可。

---

195. [A2型题｜应用] batch043-M08-A2-003

> 模块：M08｜页码：教材P101

男，45 岁，饱餐并饮酒后突发上腹剧痛，向腰背部放射，伴恶心呕吐，血淀粉酶明显升高，血钙 1.8mmol/L。最可能的诊断是

- **A. 急性胰腺炎** ✅
- B. 急性胃炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 急性心肌梗死

答案：A

> 解析：【正确答案】饱餐饮酒后突发上腹剧痛并向腰背放射、血淀粉酶升高，是急性胰腺炎的典型表现；血钙 1.8mmol/L 低于 2.0mmol/L，提示重症。其机制是胰腺消化酶被激活后对胰腺自身及周围脏器产生消化作用。
>
> 【逐项解析】A. 饱餐饮酒、上腹痛向腰背放射、淀粉酶升高，符合急性胰腺炎。（正确）
> B. 急性胃炎多为隐痛伴恶心，淀粉酶不显著升高。（错误）
> C. 胆囊炎疼痛多在右上腹、Murphy 征阳性。（错误）
> D. 穿孔多有板状腹与膈下游离气体；把胰腺炎当穿孔。（错误）
> E. 心梗可有上腹不适，但淀粉酶与血钙不支持。（错误）
>
> 【易错点】饱餐饮酒＋上腹痛向腰背放射＋淀粉酶升高＝急性胰腺炎。

---

196. [A3型题｜应用] batch043-M08-A3-003

> 模块：M08｜页码：教材P29-30

该病人最恰当的治疗是

- **A. 静脉rt-PA溶栓** ✅
- B. 立即抗凝治疗
- C. 立即降压至120/80
- D. 立即抗血小板治疗
- E. 立即脱水降颅压

答案：A

> 解析：【正确答案】病人发病 2 小时，在缺血性卒中静脉溶栓时间窗 3～4.5 小时内，CT 已排除出血，血压 170/100mmHg 未达到溶栓禁忌（收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg），应尽快静脉 rt-PA 溶栓（0.9mg/kg，最大 90mg）。
>
> 【逐项解析】A. 发病 2 小时、CT 无出血、血压未达禁忌，符合静脉溶栓指征。（正确）
> B. 抗凝不能溶解已形成的血栓，且增加出血风险。（错误）
> C. 血压 170/100 尚未达禁忌，立即降至 120/80 会加重脑缺血。（错误）
> D. 抗血小板是二级预防，不能替代急性期溶栓。（错误）
> E. 无颅内压增高证据，脱水降颅压无指征；把常规处理提前。（错误）
>
> 【易错点】卒中溶栓先算时间（3～4.5h）、再看 CT、再看血压（≥180/110 禁忌）。

---

197. [A3型题｜分析] batch043-M08-A3-004

> 模块：M08｜页码：教材P29-30

若该病人就诊时测得 190/115mmHg，正确的处理是

- **A. 先控制血压再评估溶栓** ✅
- B. 立即静脉溶栓
- C. 立即抗凝治疗
- D. 立即大量补液扩容
- E. 立即行去骨瓣减压

答案：A

> 解析：【正确答案】收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg 是缺血性卒中静脉溶栓的禁忌。血压 190/115mmHg 时应先平稳降压至溶栓允许范围，再评估是否溶栓；直接溶栓会显著增加症状性颅内出血风险。
>
> 【逐项解析】A. 血压达溶栓禁忌，应先降压再评估；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> B. 190/115mmHg 直接溶栓出血风险高，属禁忌。（错误）
> C. 抗凝不解决溶栓指征，且增加出血；用抗凝替代溶栓。（错误）
> D. 大量补液会进一步升高血压，加重脑水肿；把扩容当常规。（错误）
> E. 去骨瓣减压用于大面积梗死伴脑疝，非急性期首选。（错误）
>
> 【易错点】溶栓前记两条红线：时间>4.5 小时、血压≥180/110。

---

198. [判断题｜记忆] batch043-M08-JUD-002

> 模块：M08｜页码：教材P34-36

非糖尿病者血糖低于 2.8mmol/L、糖尿病者血糖低于 3.9mmol/L 即可诊断低血糖。

- **A. 正确** ✅
- B. 错误

答案：A

> 解析：【正确答案】低血糖的诊断阈值按人群区分：非糖尿病者血糖 <2.8mmol/L，糖尿病者 <3.9mmol/L。糖尿病病人使用降糖药时，血糖低于 3.9mmol/L 即需处理，以免进展为严重低血糖。
>
> 【逐项解析】A. 非糖尿病<2.8、糖尿病<3.9，与原句一致。（正确）
> B. 原句数值正确，不应判错；把两个阈值记反。（错误）
>
> 【易错点】低血糖两个阈值：普通人 2.8、糖尿病人 3.9。

---

199. [X型题｜理解] batch043-M08-X-002

> 模块：M08｜页码：教材P101

关于上消化道大出血与急性胰腺炎，下列叙述正确的有

- **A. 上消化道大出血出血量>800ml** ✅
- **B. 最常见病因包括消化性溃疡** ✅
- **C. 高危者12小时内急诊内镜** ✅
- **D. 重症胰腺炎可有Grey-Turner征** ✅
- E. 血钙>2.5mmol/L提示胰腺炎重症

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】教师口径上消化道大出血为出血量 >800ml，最常见病因为消化性溃疡，高危病人应在 12 小时内完成急诊内镜；重症急性胰腺炎可出现腰部皮肤青紫的 Grey-Turner 征与脐部青紫的 Cullen 征。血钙 <2.0mmol/L 才提示重症，>2.5mmol/L 属正常。
>
> 【逐项解析】A. 出血量>800ml 是教师口径，叙述正确。（正确）
> B. 消化性溃疡是最常见病因，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> C. 高危者 12 小时内急诊内镜，叙述正确。（正确）
> D. Grey-Turner 征提示重症胰腺炎，叙述正确。（正确）
> E. 血钙>2.5mmol/L 属正常，不提示重症，叙述错误。（错误）
>
> 【易错点】上消化道出血记 800ml/12 小时；胰腺炎重症记低钙、Grey-Turner。

---

200. [X型题｜理解] batch043-M08-X-003

> 模块：M08｜页码：教材P39-40

关于糖尿病急症，下列叙述正确的有

- **A. 重度DKA血清HCO3-<5mmol/L** ✅
- **B. HHS血糖≥33.3mmol/L** ✅
- **C. HHS渗透压≥320mOsm** ✅
- **D. 低血糖昏迷应静脉补糖** ✅
- E. HHS癫痫首选苯妥英钠

答案：ABCD

> 解析：【正确答案】重度 DKA 血清 HCO3-<5mmol/L 或伴意识障碍；HHS 血糖≥33.3mmol/L、有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg・H2O)、尿酮阴性或弱阳性、神志木僵或昏迷；低血糖昏迷应静脉补糖。HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠。
>
> 【逐项解析】A. 重度 DKA 的 HCO3-<5mmol/L，叙述正确。（正确）
> B. HHS 血糖≥33.3mmol/L，叙述正确。（正确）
> C. HHS 渗透压≥320mOsm，叙述正确。（正确）
> D. 低血糖昏迷静脉补糖，叙述正确；该表述与教材要点一致，故为正确选项。（正确）
> E. HHS 癫痫禁用苯妥英钠，叙述错误；把禁忌药当首选。（错误）
>
> 【易错点】DKA 看 HCO3-，HHS 看血糖 33.3 与渗透压 320；HHS 癫痫禁苯妥英钠。
